

Aula 10 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

11 de Julho de 2026

Sumário

Traumatologia forense	3
1 - Considerações Iniciais	3
2 - Conceitos Fundamentais	3
3 - Energia Mecânica	6
3.1 – Instrumentos Perfurantes	11
3.2 – Instrumentos Cortantes	18
3.3 – Instrumentos Contundentes	25
3.4 – Instrumentos Perfurocortantes	41
3.5 – Instrumentos Cortocontundentes	45
3.6 – Instrumentos Perfurocontundentes	49
Questões Comentadas	51
Lista de Questões	74
Gabarito	85
Resumo	86
Questões Extras - Comentadas	89
Questões Extras - Lista de Questões	161
Questões Extras - Gabarito	195



APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá Coruja, seja bem-vindo(a)! Que bom vê-lo(a) novamente! Se você está aqui é porque gostou da nossa primeira aula e está disposto a seguir firme na busca do sonho da aprovação. Agradeço imensamente pela sua confiança e comprometo-me a entregar o melhor material para sua preparação.

Vamos a alguns recados importantes...

ATENÇÃO!!!

- Nossas videoaulas estão sendo gravadas e serão inseridas no curso ao longo dos próximos dias, mas os PDF's estão sendo disponibilizados para que você tenha material pra estudar enquanto finalizamos a edição dos vídeos.
- Você perceberá que já temos vários vídeos de questões comentadas disponível, aproveite pois eles estão atualizadíssimos.
- Ao final desse PDF há uma sessão de questões extras para você treinar muito. São as mesmas questões trabalhadas nos vídeos de questões que já estão disponíveis.
- Nessa sessão extra temos as questões agrupadas por banca, iniciando com Cebraspe até a de número 50, depois FGV e finalizando com bancas diversas.
- Faça as questões da sua banca como prioridade mas não deixe de treinar com outras bancas se houver tempo hábil na sua preparação.
- O vídeo da aula teórica está em fase de processamento, em breve disponibilizarei.
- Temos uma agenda intensa de aulas ao vivo acontecendo. Me siga no Instagram para ficar por dentro das datas e horários ou então participe do nosso grupo de Whatsapp.

<https://chat.whatsapp.com/LRdvV1hkT917QeMqnoOjfv>

Instagram: @jusganzerla

E-mail: julianasganzerla.js@gmail.com



Sem mais, me acompanhe pelo maravilhoso mundo da Traumatologia Forense...



TRAUMATOLOGIA FORENSE

1 - Considerações Iniciais

A Traumatologia corresponde ao segundo assunto mais cobrado em concursos! Só perde para o tema Identificação (Antropologia Forense).

Por isso, preste bem atenção às explicações que aí não vai ter erro na hora da prova.

Ah! Esse assunto está dividido em diversas aulas e a parte referente à Balística deixei em uma aula separada. Obviamente, tem motivo para isso... as bancas de concurso adoram!

Vamos lá!

2 - Conceitos Fundamentais

A Traumatologia Forense é um ramo da Medicina Legal que observa, analisa e pesquisa as energias e agentes que causam dano no organismo (lesão corporal). Além disso, questões relativas ao diagnóstico, prognóstico e das implicações legais também são estudadas por esse ramo.

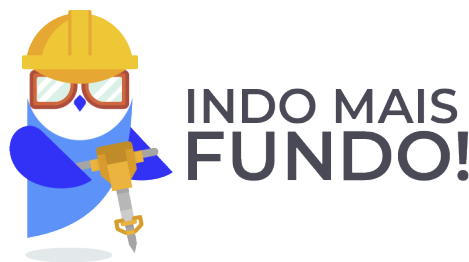
Outro termo sinônimo de Traumatologia é Lesonologia.

Porém, para que possamos continuar o nosso estudo dentro do campo da Traumatologia, é necessário apresentar as definições de alguns conceitos.

- **Trauma:** é a **atuação de uma energia externa sobre o indivíduo ao ponto de provocar desvio da normalidade**. Esse trauma, em alguns casos, não é suficiente para produzir uma lesão perceptível, mas pode conseguir alterar a função.
- **Traumatismo:** **estado geral** ou local produzido por uma lesão ou ferimento.
- **Lesão:** **alteração estrutural ou funcional** resultante de uma agressão ao organismo (mediante uma transferência de energia). Pode ser visível macroscopicamente ou microscopicamente.
- **Ferida:** tipo de lesão em que ocorre **interrupção da continuidade de um tecido corporal**. Geralmente, falamos de ferida quando a pele é traumatizada a ponto de expor as camadas subjacentes.
- **Energia:** está relacionada a capacidade de realização de trabalho, sendo todas as formas de energias conversíveis entre si. Energias Lesivas (qualquer forma de energia que seja capaz de provocar lesão) e vulnerantes (toda aquela forma de energia capaz de vulnerar o organismo).



- **Agentes Lesivos:** todos **aqueles que podem provocar lesões**.
- **Instrumento:** todo **utensílio que transfere energia mecânica (cinética) e que é utilizado para provocar o traumatismo**. Assim, o termo só é aplicado para os casos que envolvem energia mecânica. Outra forma de definição é a de que o instrumento representa o modo de ação como um objeto é utilizado. Exemplo: um pedaço de pau pode ser usado batendo no corpo de uma pessoa (ação de instrumento contundente).
- **Meios:** situações em que ocorrem **transferência de energia não cinética (mecânica)**. O termo é aplicado a todos os outros casos em que não envolvem energia mecânica. Exemplo: um choque elétrico (meio físico - eletricidade).



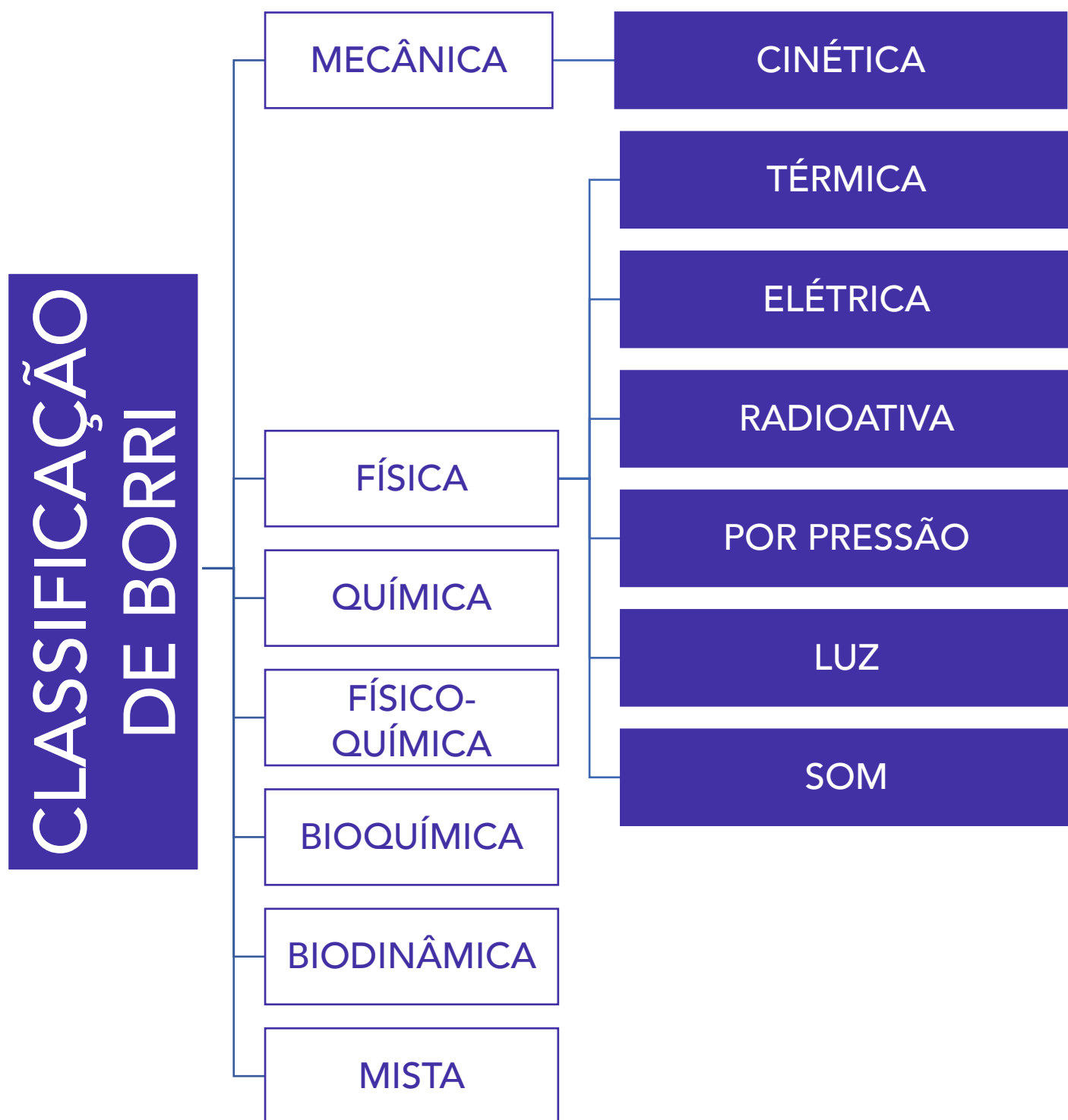
De acordo com Vanrell: **energias lesivas** são quaisquer formas de energia capazes de **provocar lesões** ou, então, **energias vulnerantes**, todas aquelas formas de energia capazes de **vulnerar o organismo**.

Com esses conceitos em mente, vimos que para que ocorra o trauma, há a atuação de energias que são transferidas para o corpo.

Essas transferências de energias podem ser através de agentes lesivos, que podem ser **instrumentos (nos casos de energia mecânica)** ou **meios (nos demais tipos de energia)**, podendo chegar a produzir alterações morfológicas (lesões físicas, funcionais ou psíquicas).

No começo do século XX, um italiano, **Lorenzo Borri**, classificou as energias e os agentes ou instrumentos lesivos de acordo com o esquema a seguir:





Vamos começar nosso estudo pela Energia Mecânica, pois é o tipo de energia na qual somos mais submetidos a sofrer danos.

Na próxima aula, veremos as demais.

(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL-2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques



elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Segundo a classificação de Borri, as energias vulnerantes de etiologia mecânica são estudadas separadamente das energias vulnerantes de ordem física.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários

Isso mesmo! De acordo com a Classificação de Bori temos as energias vulnerantes separadas da seguinte forma:

- Energia mecânica: Cinética;
- Energia física: Térmica; Elétrica; Radioativa; Por pressão; Luz; Som.
- Energia química
- Energia físico-química;
- Energia bioquímica;
- Energia biodinâmica;
- Mista

Gabarito: Certo

3 - Energia Mecânica

As lesões causadas por energia mecânica também podem ser chamadas de lesões por Arma Branca (Vanrell traz essa nomenclatura em seu livro). A característica mais comum, de onde advém o nome armas brancas, é o fato de que historicamente, na sua maioria, brilhavam, principalmente à noite (pareciam ser "brancas"), à diferença das armas de fogo da época, que, além de não reluzirem, projetavam fogo quando de seu acionamento.

Independente da nomenclatura, nos importa entender que a ação mecânica modifica, através de **energia cinética**, o estado de repouso ou de movimento do organismo.

Dessa maneira, os agentes mecânicos conseguem provocar lesões ao **transferir, parcialmente ou totalmente, sua energia cinética à superfície corporal em contato.**



Esses agentes podem se relacionar com o corpo e provocar a transferência de energia de formas extremamente variadas. Assim, os mecanismos de ação desses agentes podem ser por:

- Pressão
- Percussão
- Deslizamento
- Explosão
- Compressão
- Descompressão
- Torção
- Distensão
- Contragolpe
- Sucção



Os agentes que se utilizam da energia mecânica para provocar dano podem ser chamados de **instrumentos**.

Entretanto, no momento da transferência da energia cinética, a movimentação pode ser do instrumento, do corpo ou de ambos. Assim, temos as seguintes **dinâmicas de ação** do agente:



DINÂMICAS DE AÇÃO

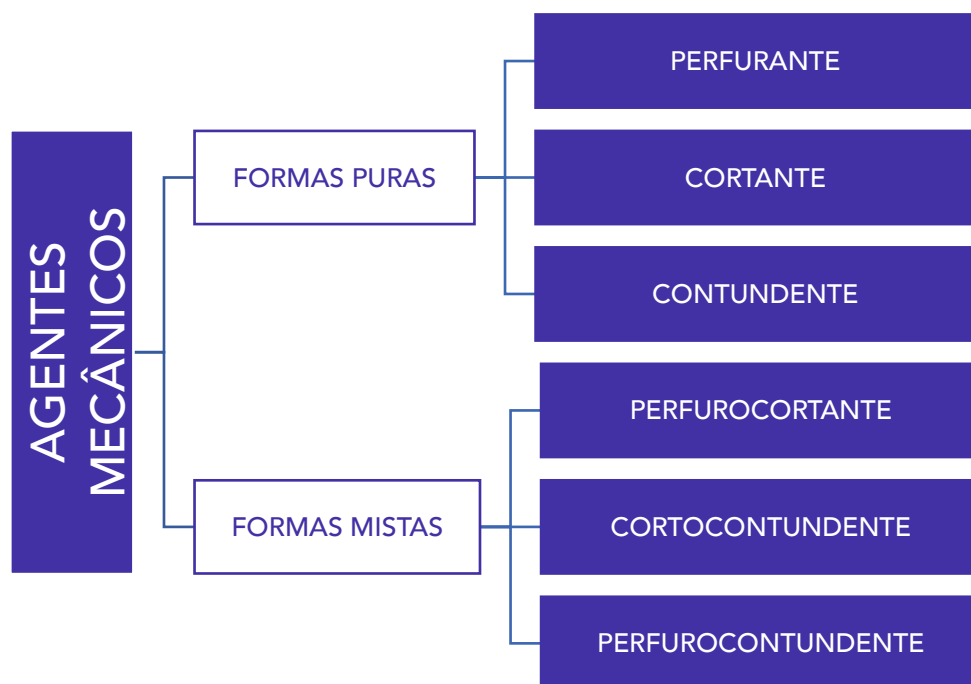


DINÂMICAS DE AÇÃO



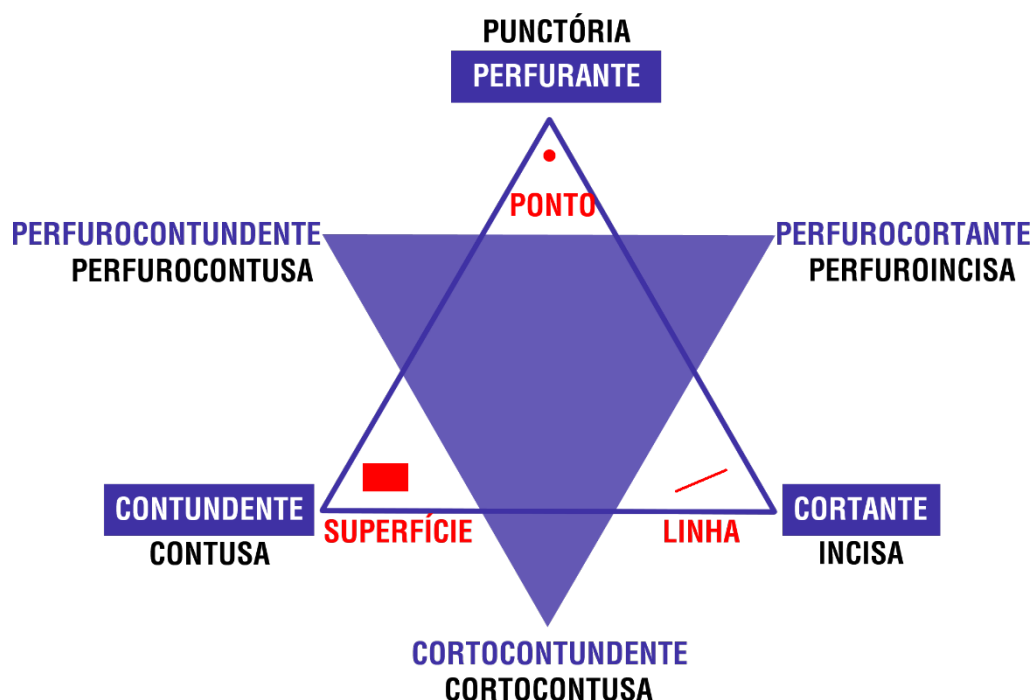
Os agentes mecânicos são classificados em:

- **Formas Puras**: quando age apenas um tipo de atuação (Perfurantes, Cortantes ou Contundentes).
- **Formas Mistas**: quando ocorre a combinação de mais de uma forma pura (Perfurocortantes, Cortocontundentes ou Perfurocontundentes).



Outra maneira de entender as formas de ação dos instrumentos é através do **Diagrama de Malthus**:

DIAGRAMA DE MALTHUS



Nessa representação gráfica, temos um triângulo indicando as formas puras e outro com as mistas. Em preto, estão as nomenclaturas das lesões produzidas por cada tipo de ação.





VAMOS RESOLVER
UMA QUESTÃO?

(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Em relação aos conceitos básicos em Traumatologia Forense, assinale a alternativa correta.

- a) Estuda os aspectos médico-legais das lesões causadas por agentes lesivos a fim de estabelecer o nexo causal entre eles.
- b) Instrumentos atuam sobre o corpo humano modificando no todo ou em parte o seu estado de repouso ou movimento, produzindo lesões ou morte.
- c) Energias são alterações estruturais provenientes de uma agressão ao organismo.
- d) Agente é o objeto utilizado com uma finalidade específica, possuindo forma e volume definido, podendo ser manuseado para provocar uma lesão.
- e) São considerados agentes de lesão os mecânicos, físicos, químicos, biológicos e físico-químicos.

Comentários

A Traumatologia Forense é um ramo da Medicina Legal que observa, analisa e pesquisa as energias e agentes que causam dano no organismo (lesão corporal). Além disso, questões relativas ao diagnóstico, prognóstico e das implicações legais também são estudadas por esse ramo.

Gabarito: Letra A.

Com esses conceitos entendidos, fica mais claro de notar que o tipo de traumatismo a ser examinado não depende exclusivamente do objeto utilizado, mas do modo como ele foi usado. Exemplo: uma faca pode ser usada deslizando seu gume (ação de instrumento cortante), mas em outra situação pode ser utilizada batendo o seu cabo (ação de instrumento contundente).

Agora iremos ver cada uma das formas de utilização dos instrumentos.





3.1 – Instrumentos Perfurantes

Os instrumentos perfurantes atuam transferindo energia cinética através da **pressão de uma ponta em uma superfície**, afastando os tecidos e, raramente, seccionando-os.

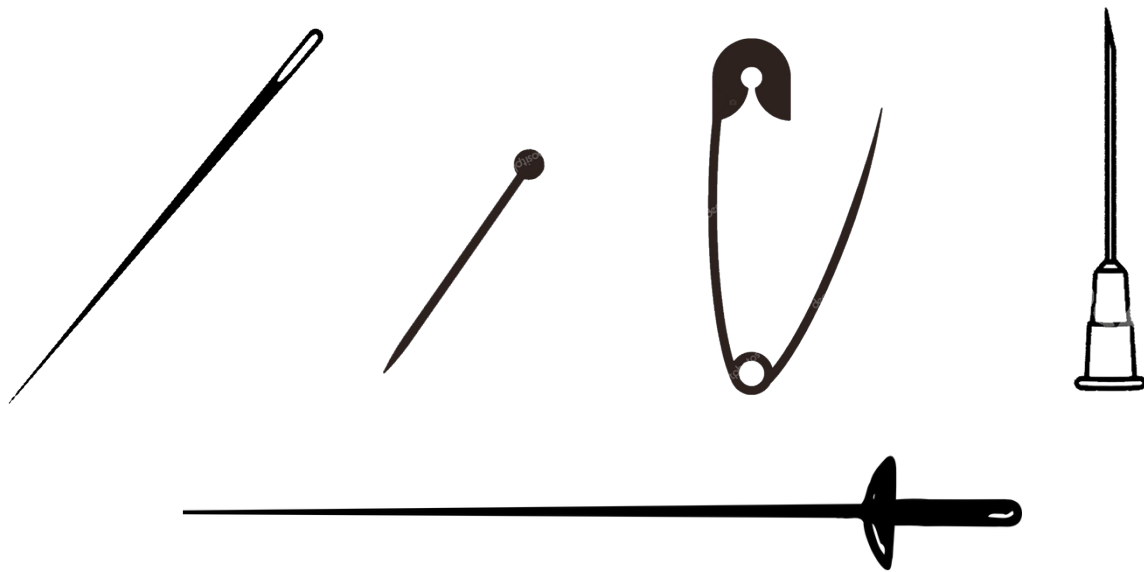
Esses instrumentos são geralmente constituídos de uma ponta anexa à uma haste. Assim, são puntiformes, finos; cilíndricos, cônicos ou cilindrocônicos; alongados, em que o **comprimento predomina** em relação à largura e à espessura.

De acordo com a espessura (ou diâmetro) transversal apresentada pela haste, os instrumentos podem ser considerados de **calibre pequeno ou médio**.

INSTRUMENTOS PERFURANTES	
CALIBRE PEQUENO	CALIBRE MÉDIO
AGULHA	FURADOR DE GELO
ALFINETE	SOVELA
ESPINHO	FLORETE



EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS PERFURANTES



Os instrumentos perfurantes de calibre médio podem dilacerar algumas fibras de tecido.



A **lesão** produzida por esses instrumentos perfurantes é denominada **punctória ou puntiforme**. Sua causa jurídica é, na **maioria das vezes, homicida** e, mais raramente, de origem acidental ou suicida.

Essas lesões podem variar conforme o calibre do instrumento, sendo **as produzidas por calibre pequeno** de **formato em ponto**, comumente menor que 1 mm.

Além disso, as lesões são de **pouco ou raro sangramento**, a depender da sua profundidade e dos planos atingidos, já que o sangue emana da rotura de vasos, e, geralmente, **apresentam diâmetro menor do que o do instrumento** (devido à elasticidade e à capacidade de retração dos tecidos cutâneos).

Nos casos em que há **ferimento de saída**, esse é apresentado com um **formato mais irregular e com diâmetro menor do que a entrada**. Isso ocorre por conta de sua produção ser realizada somente pela porção mais afilada do instrumento.

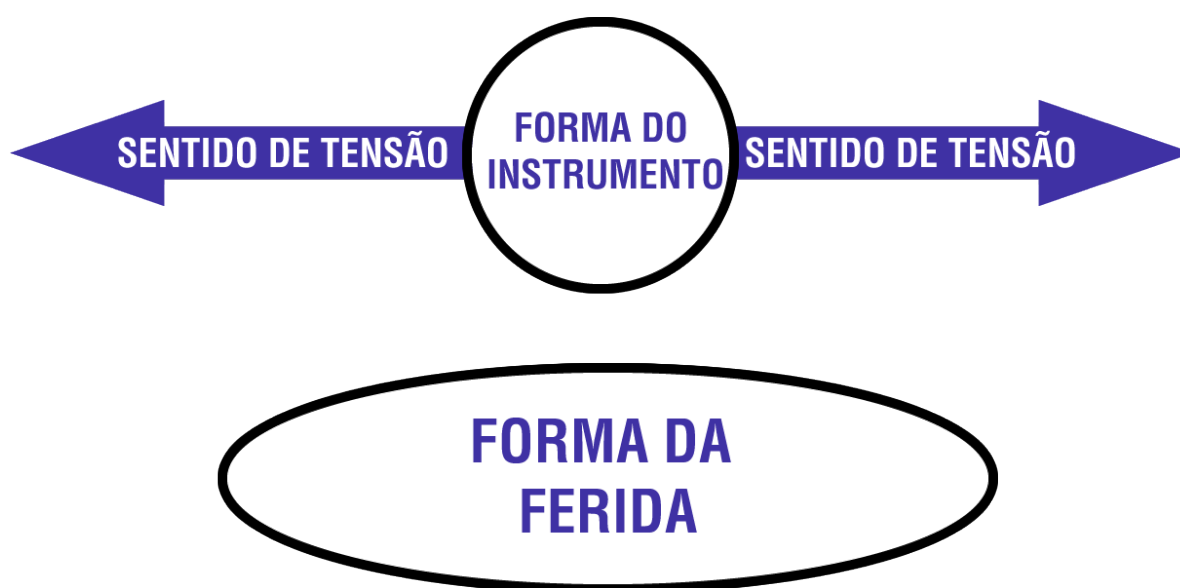
A gravidade da lesão está diretamente relacionada à profundidade e a quais estruturas foram atingidas e perfuradas pelo instrumento, facilitando a penetração de bactérias e a instalação de infecções.

Os instrumentos perfurantes de calibre médio produzem lesões em formato de "casa de botão", de botoeira, fusiforme. Essa forma está relacionada às linhas de tensão observadas na superfície corporal, além das fibras elásticas e colágenas dispostas na derme.



Figura do Livro Medicina Legal, 11ª edição - 2017 (Autor Genival Veloso de França). Lesões produzidas por instrumento de médio calibre (furador de gelo).

FORMAÇÃO DA FERIDA EM “CASA DE BOTÃO”





HORA DE PRATICAR!

(VUNESP/PC-RR – 2022 - ADAPTADA) Um perito descreveu uma lesão da seguinte maneira: "Trata-se de solução de continuidade circular, diâmetro pequeno, puntiforme, cuja profundidade é maior que a extensão e com pouco sangramento". Portanto, ele se referiu a uma lesão

- a) contusa.
- b) incisa.
- c) perfuroincisa.
- d) perfurocontusa.
- e) punctória.

Comentários:

Todas as características apresentadas são de uma lesão punctória.

Assim, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

Nesse ponto, devemos estudar as **Leis de Filhos e de Langer**, que explicam exatamente como se dá tal relação entre fibras e formatos nas lesões resultantes da ação de instrumentos perfurantes de calibre médio.



DESPENCA NA PROVA!

Primeiramente, **Edouard Filhos (1833)** produziu duas leis:

1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança): as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (pérfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão".

2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo): quando as feridas se localizam na mesma região do corpo que possua as linhas de força dispostas em uma só direção, seu maior eixo tem sempre a mesma direção.

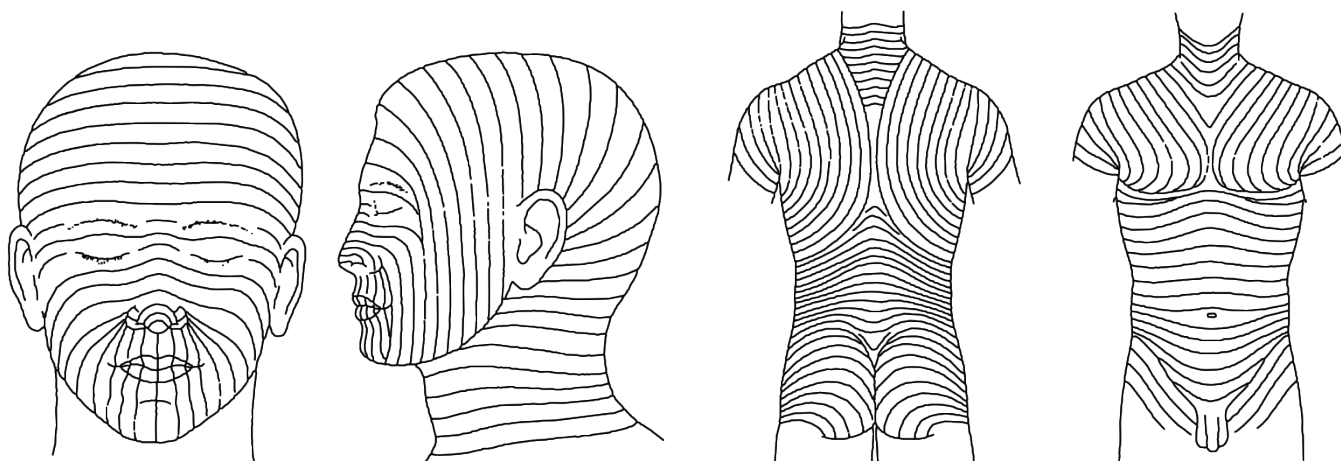


Em seguida, de maneira complementar, **Karl Ritter von Langer (1861)** desenvolveu a seguinte lei:

Lei de Langer (Lei do Polimorfismo ou da Elasticidade): Nas regiões em que ocorre cruzamento (convergência ou confluência) de fibras de sentidos diferentes, as extremidades da lesão assumem um aspecto de ponta de seta, de triângulo ou até de quadrilátero.

Teoricamente, as **linhas de Langer** estão situadas na pele e são **perpendiculares à direção da contração muscular** existente em determinada região e paralelas às linhas de flexão. Na prática, difere-se um pouco disso, ocorrendo até o aparecimento de figuras com triângulos e quadriláteros (explicados pela Lei de Langer).

LINHAS DE LANGERS

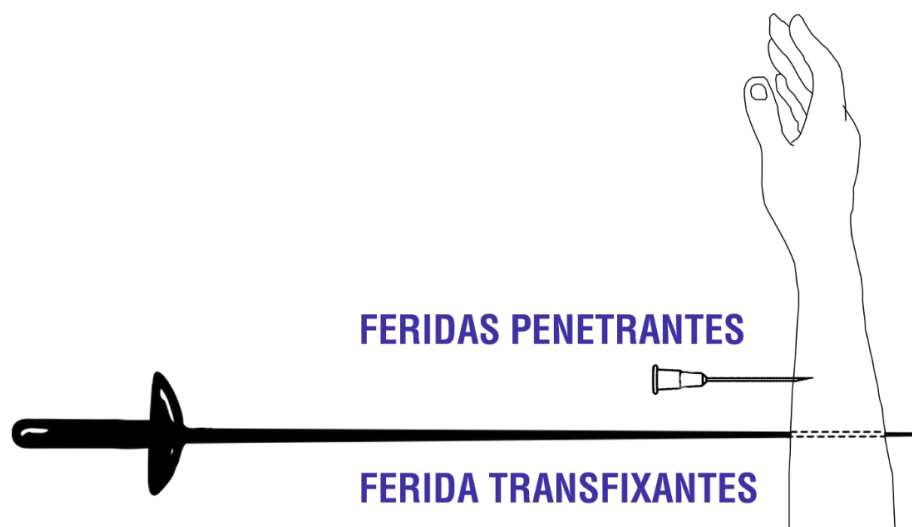


As feridas punctórias ainda podem ser **classificadas (segundo Hygino)** em:

Penetrantes (ou em fundo de saco): acontecem nos casos em que o instrumento penetra em um segmento qualquer do corpo sem transfixá-lo; ou

Transfixantes: ocorrem quando o instrumento transfixa (de um lado a outro) qualquer segmento, apresentando orifício de entrada e de saída. Nesses casos, os orifícios de saída apresentam as mesmas características do de entrada.

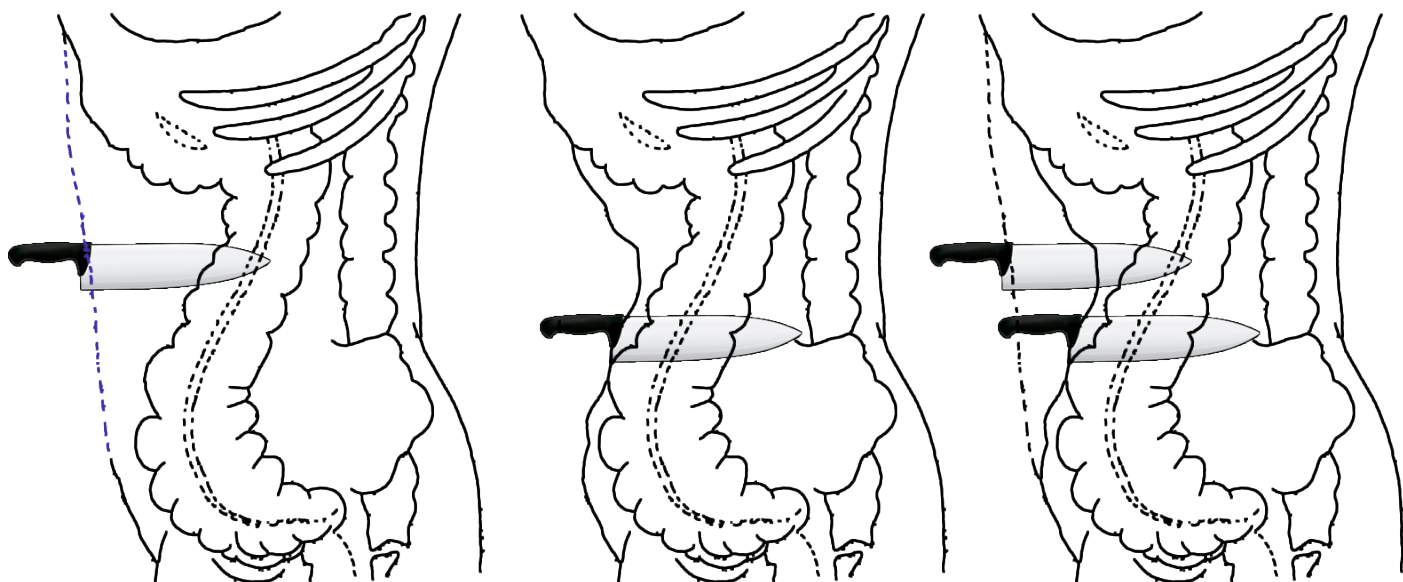
*O autor Hygino Hércules ainda adiciona o grupo das **superficiais**, que atingem apenas as primeiras camadas da pele.



Porém, devido a possibilidade de **depressão de alguns segmentos anatômicos**, o trajeto apresentado pela lesão pode ser maior que o comprimento do instrumento.

A esse mecanismo dá-se o nome de **Lesão em Acordeão (ou Sanfona) de Lacassagne**

LESÃO EM ACORDÃO DE LACASSAGNE



O exemplo mais comum é do abdômen que, ao ser atingido, flexiona-se, permitindo que o instrumento atinja órgãos ou estruturas mais profundas que o seu próprio comprimento.



O fenômeno observado na Lesão em Acordeão pode ocorrer tanto para instrumentos perfurocortantes (como na figura anterior apresenta) quanto para perfurantes.

Assim, a profundidade das feridas pode ser:

- Igual ao comprimento do instrumento: quando a haste penetra completamente
- Menor que o comprimento do instrumento: quando a penetração é apenas parcial
- Maior que o comprimento do instrumento: quando ocorrer em região passível de compressão



(NUCEPE UESPI/PC-PI - 2018) Com relação às lesões por ação perfurocortante, assinale a alternativa INCORRETA quanto à lesão e suas características:

- A) Penetrantes: entra em cavidades preexistente: pleural, pericárdica, peritoneal.
- B) Perfurantes: penetram numa parte maciça do corpo, sem saída.
- C) Transfixantes (atravessam um órgão ou uma parte do corpo.
- D) Em acordeão ou em sanfona [Lacassagne]: quando a superfície do corpo é depressível (parede de abdome) a lâmina produz uma lesão menos profunda que o seu próprio comprimento.
- E) Em fundo-de-saco: quando perfuram, atingem um obstáculo resistente e não penetram além do comprimento.

Comentários



De acordo com Vanrell, as lesões perfuroincisas podem ser:

- Penetrantes: entram em cavidade preexistente (pleural, pericárdica, peritoneal)
- Perfurantes: penetram em uma parte maciça do corpo, sem saída
- Transfixantes: atravessam um órgão ou uma parte do corpo
- Em fundo de saco: quando perfuram, atingem um obstáculo resistente e não penetram além do comprimento
- Em acordeão ou em sanfona (Lacassagne): quando a superfície do corpo é depressível (parede de abdome), a lâmina produz uma lesão **mais profunda** que o seu próprio comprimento

Gabarito: Letra D

3.2 – Instrumentos Cortantes

Os **instrumentos cortantes** agem através da ação de um ou mais gumes por meio de um **mecanismo de deslizamento e uma leve pressão**. Assim, enquanto as feridas punctórias afastam as **fibras**, as feridas produzidas pelos instrumentos cortantes acabam por **seccioná-las**.

Quando isso acontece, as lesões produzidas são denominadas de **incisas**, que são soluções de continuidades (feridas).

Entretanto, **Genival Veloso de França**, autor de vários livros de Medicina Legal, usa o termo **"ferida cortante"**. Vários autores (Hygino Hércules, Hélio Gomes, Delton Croce, Hermes Alcântara...) não concordam com essa nomenclatura, pois afirmam que o que é cortante é o instrumento e não a lesão.

Em contrapartida, o termo **"incisão"** é utilizado para nomear as **feridas cirúrgicas** provocadas por médico em ato operatório.

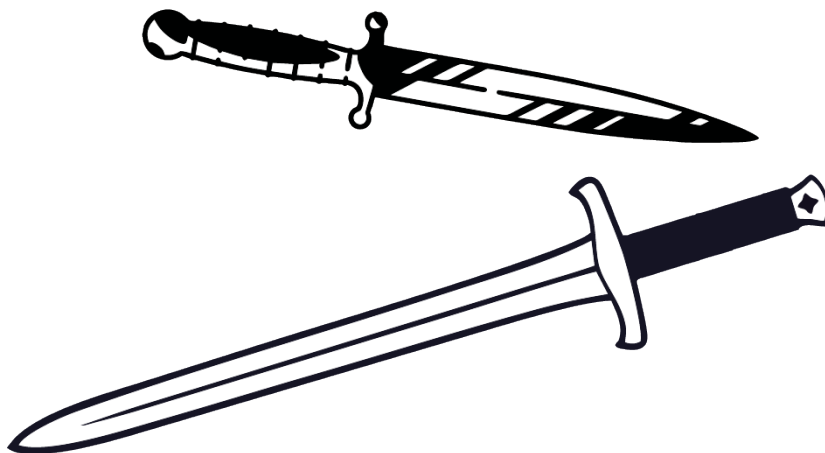
INSTRUMENTOS CORTANTES	
GUME ÚNICO	DOIS GUMES
FACA	PUNHAL
NAVALHA	ESPADA



EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS CORTANTES



DE 1 GUME



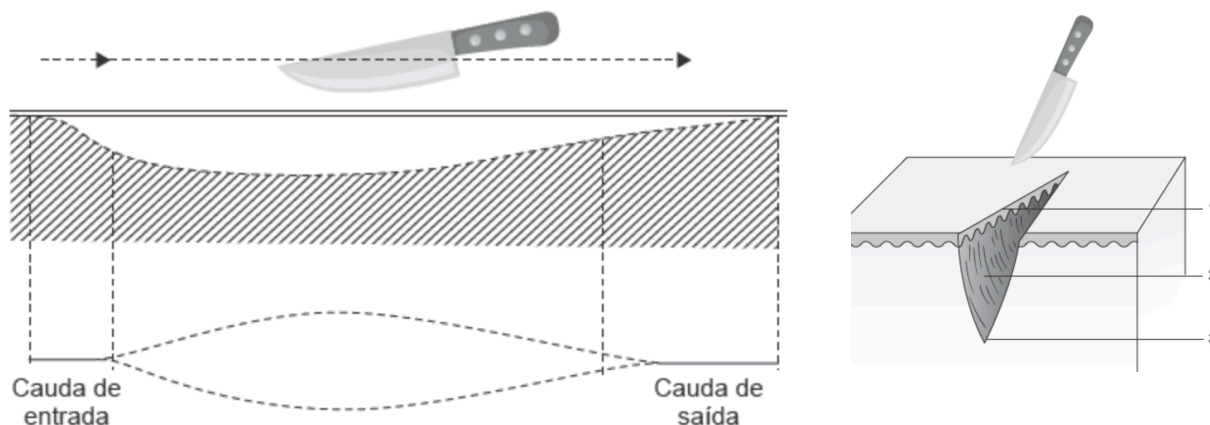
DE 2 GUMES



As **feridas incisas** possuem as seguintes características:

- **Bordas e vertentes regulares, lisas e afastadas**, que se coaptam quando são aproximadas. Se uma das bordas apresentar bisel em seu perfil de corte, esse indica que houve ação inclinada do gume para o lado da borda biselada. Por outro lado, a ausência de bisel remete à ação perpendicular do instrumento.
- **Formato fusiforme, linear e uniforme**
- **Comprimento da lesão prevalece** sobre a largura e a profundidade, sendo esta maior no centro (parte média) da ferida
- **Sangramento (hemorragia) abundante**
- **Fundo da lesão** apresenta-se **regular, limpo, sem trabéculas de tecido**
- **Sem sinais (vestígios) de contusão** ou traumatismos ao redor da ferida. Porém, quando produzidas sobre regiões em que há osso subjacente, devem ser analisadas e diferenciadas das lesões contusas.
- **Cauda de escoriação** (ou "cauda de rato", Sinal de Romanese ou de Lacassagne) pode estar **presente (ou não) na extremidade de término da ação do instrumento**, quando esse está se afastando do corpo da vítima. Alguns autores admitem a possibilidade de a cauda

também aparecer na extremidade de início da lesão, sendo a de término/saída, em geral, mais extensa.



Legenda: 1. Borda ou lábio. 2. Vertente. 3. Fundo. **Fonte:** Vanrell JP. Odontologia Legal e Antropologia Forense, 3ª edição. 2019.

LESÃO INCISA

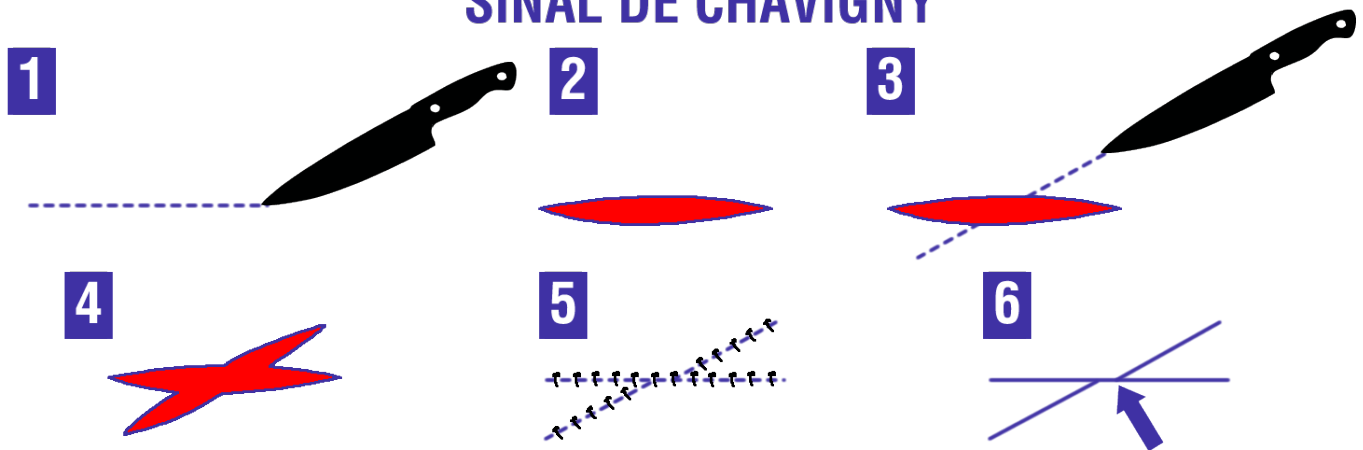


Quando duas feridas incisivas se sobrepõem em algum ponto, é possível determinar qual foi produzida primeiro através do **Sinal de Chavigny**:

A primeira ferida produzida **respeita as características esperadas de uma lesão incisiva**, tendo as bordas bem adaptadas ao serem aproximadas entre si. Já a segunda lesão, ao realizar a junção das bordas, **apresenta uma interrupção ou desvio de seu trajeto**.

Isso ocorre devido a segunda ser produzida após a primeira abrir as margens, impossibilitando uma produção regular dos ferimentos subsequentes.

SINAL DE CHAVIGNY



Geralmente, quando instrumentos cortantes são utilizados para o ataque e as vítimas possuem condição de se defender, ocorre a produção de lesões chamadas de "lesões de defesa". Essas feridas são observadas nos antebraços (face ulnar), mãos (principalmente nas palmas) e até nos pés.

Já nos casos de suicídio com o emprego desses instrumentos, a vítima costumeiramente hesita em se ferir, causando feridas chamadas de "lesões de hesitação". Nesses contextos, as lesões são geralmente múltiplas, de profundidade variada e localizadas em regiões acessíveis pela vítima.

Assim, a depender da localização, quantidade e profundidade das lesões, há mais informações que possam levar a configuração de um cenário de homicídio ou de suicídio.

Teoricamente, as feridas incisais estão mais associadas aos acidentes e homicídios do que os suicídios.



Fonte: França, Genival Veloso D. Medicina Legal, 11ª edição. 2017. Ferida produzida por meio cortante (cauda de escoriação voltada para baixo).

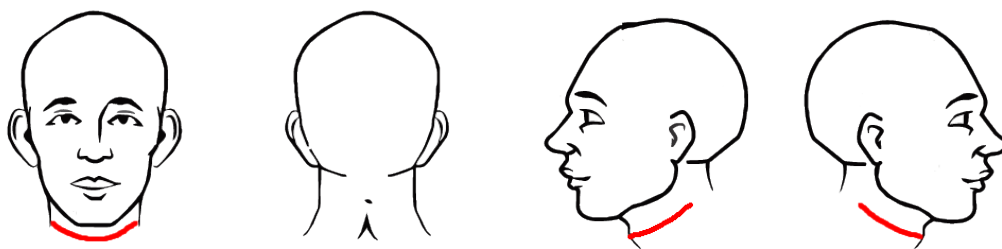
CURIOSIDADE

Entre os samurais da cultura japonesa havia um ritual de suicídio chamado de seppuku (ou harakiri) que consistia em um corte horizontal no abdômen da direita para esquerda, expondo as vísceras (estripação). Caso o samurai ainda tivesse forças, era realizado outro corte para cima. Em seguida, um indivíduo auxiliar (kaishakunin) decapitava a vítima com uma espada (katana) como um ato de misericórdia.

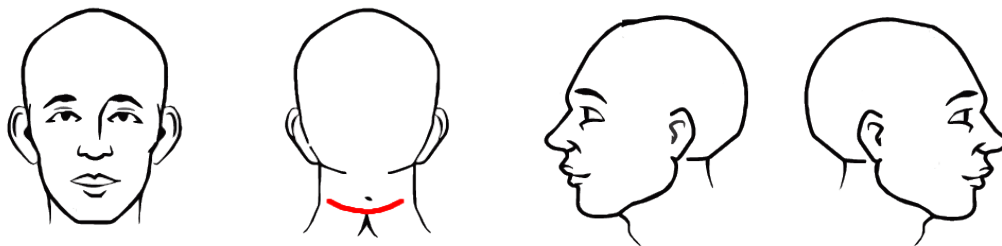


Algumas feridas incisas recebem **nomes especiais**:

- **Degolamento**: lesão observada na **face posterior do pescoço**. Assim, para ajudar a memorizar, é só lembrar da gola da camisa, que fica na parte posterior do pescoço.
- **Esgorjamento**: gorja significa garganta ou goela. O ato de esgorjar ocorre na **região anterior e/ou lateral do pescoço**, podendo lesionar superficialmente (pele) ou profundamente (músculos, feixes vasculonervosos, esôfago, laringe, traqueia). A morte ocorre por secção dos vasos calibrosos da região carotídea que podem causar anemia ou asfixia pela aspiração de sangue extravasado pela laringe ou traqueia.



ESGORJAMENTO



DEGOLA



Nos casos de esgorjamento, o perito deve estar atento para a **direção e sentido de produção da ferida**. Isso pode auxiliar na **determinação de um quadro homicida ou suicida**.

Nos **homicídios**, a ferida do esgorjado é **horizontal (transversal) e possui a mesma profundidade por toda a sua extensão**.

Em contrapartida, **nos suicídios**, a lesão se apresenta **oblíqua, com profundidade maior no início e descendente para o lado da mão utilizada**: para a direita nos destros e para a esquerda nos canhotos. Na maioria dos casos, há presença de lesões de hesitação e a arma permanece na mão da vítima, ainda suja de sangue.

Sinal do Espelho (de Bonnet): são respingos e/ou borrifos de sangue encontrados na superfície do espelho nos casos de suicídios por esgorjamento.

- **Decapitação**: palavra derivada do latim capitatus que significa cabeça. É quando ocorre a **separação total do segmento cefálico do restante do corpo**. Esses casos estão geralmente ligados aos acidentes e crimes de natureza homicida, raramente é suicida. A decapitação pode estar associada como uma forma de prejudicar a identificação da vítima, sendo então realizada após a morte dessa.

Esses ferimentos especiais podem ou não estarem associados a ação de energias além do deslizamento. Assim, **alguns autores consideram o degolamento, esgorjamento e decapitação como feridas cortocontusas**. Na mesma linha de pensamento, o esquartejamento e o espostejamento podem ser estudados tanto nas ações incisas quanto nas cortocontusas (que é onde abordaremos).



(VUNESP/PC-RR – 2022) Trata-se de um ferimento profundo e transversal em região cervical anterior, lesando além dos planos cutâneos, vasculonervosos e musculares, órgãos como laringe, traqueia e esôfago:

- a) decapitação.
- b) degolamento.
- c) esquartejamento.
- d) esgorjamento.
- e) espostejamento.



Comentários:

A **alternativa A está incorreta**. A decapitação corresponde à separação completa da cabeça do restante do corpo.

A **alternativa B está incorreta**. A degola é quando a lesão cortante for na porção posterior do pescoço.

A **alternativa C está incorreta**. Esquartejamento é a secção do corpo em partes (quartos).

A **alternativa D está correta** e é o gabarito da questão.

A **alternativa E está incorreta**. Espostejamento é quando o corpo é cortado em várias partes, ou postas, fatiado.

(IDECAN/PEFOCE – 2021) Lesões cortocontusas são produzidas por agentes vulnerantes de ordem física que atuam através da lâmina, sendo também necessária a massa do instrumento para produção de seu resultado final. Especificamente em relação às secções do pescoço, é correto afirmar que

- a) o esgorjamento ocorre quando o ferimento é em região posterior.
- b) a degola ocorre quando o ferimento é anterior.
- c) a degola corresponde à decapitação.
- d) a degola pode ser lateral.
- e) o esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço.

Comentários:

- a) **Incorreta. Esgorjamento:** gorja significa garganta ou goela. O ato de esgorjar ocorre na região anterior e/ou lateral do pescoço, podendo lesionar superficialmente (pele) ou profundamente (músculos, feixes vasculonervosos, esôfago, laringe, traqueia). A morte ocorre por secção dos vasos calibrosos da região carotídea que podem causar anemia ou asfixia pela aspiração de sangue extravasado pela laringe ou traqueia.
- b) **Incorreta. Degolamento:** lesão observada na **face posterior do pescoço**.
- c) **Incorreta. Decapitação:** **significa destacar a cabeça do restante do corpo**.
- d) **Incorreta. Degolamento:** lesão observada na **face posterior do pescoço**.
- e) **Correta**. O ato de esgorjar ocorre na **região anterior e/ou lateral do pescoço**, podendo lesionar superficialmente (pele) ou profundamente (músculos, feixes vasculonervosos, esôfago, laringe, traqueia).

Gabarito: Letra E.



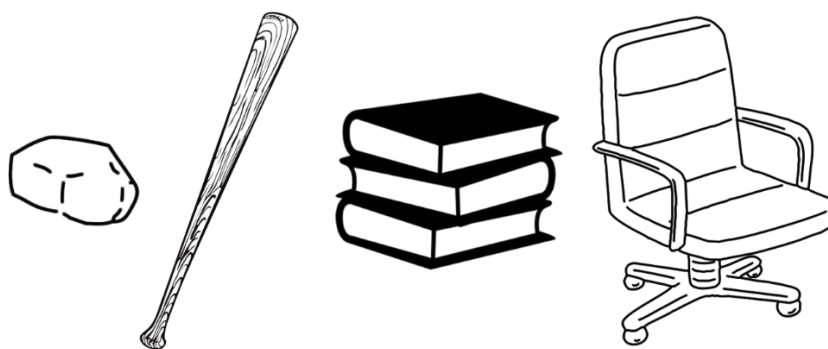
3.3 – Instrumentos Contundentes

Os instrumentos contundentes atuam por **pressão ou choque sobre uma superfície ou plano** e, dependendo da profundidade da lesão, há maior ou menor repercussão e probabilidade de infecção.

Você quer saber os exemplos de instrumentos contundentes?

Pode ser praticamente qualquer coisa! Uma pedra, um bastão, um livro, uma cadeira... Qualquer objeto que possua massa, sendo arremessado ou indo ao seu encontro com energia suficiente, é capaz de produzir um trauma.

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS CONTUNDENTES



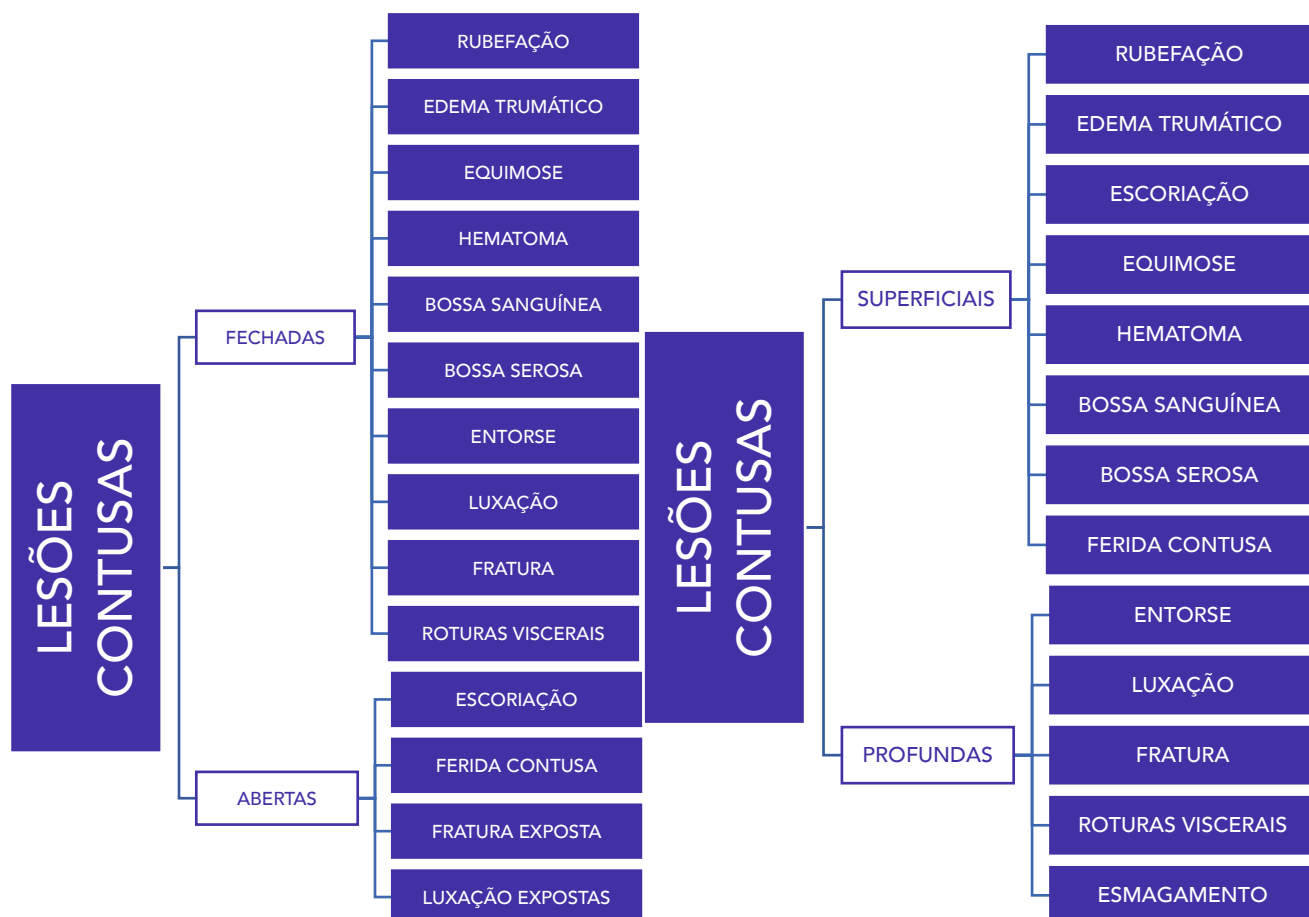
ACORDE!

As **lesões** produzidas são denominadas **contusas** e podem ser **abertas (feridas)** ou **fechadas (contusões)**.

As **contusões** são lesões que **conseguem manter a integridade da pele** ou que **a afeta apenas superficialmente**. São consideradas lesões fechadas: rubefação, tumefação (edema traumático), equimose, hematoma, bossa sanguínea, bossa serosa, entorse, luxação, fratura.

Já as **abertas**, que **provocam solução de continuidade da pele**, são representadas pela escoriação, ferida contusa e fraturas e luxações expostas.

Outra classificação possível divide as lesões em superficiais e profundas (conforme esquema a seguir).



Rubefação

A rubefação pode ou não ser considerada uma lesão para configurar o crime. Porém, no olhar da Medicina Legal, consiste **na lesão mais simples e fugaz da categoria contusa**, desaparecendo em alguns minutos ou horas.

Quando um instrumento contundente atua, a pressão no local promove a liberação de histamina que, por sua vez, promove a vasodilatação, consequentemente, ocorre hiperemia e vermelhidão (rubor) local, produzindo a rubefação.

ERITEMA X RUBIFICAÇÃO

Lembrar que o eritema é causado por simples vasodilatação decorrente de alteração emocional em comparação com a rubefação que tem origem do trauma contundente.

As rubefações são passíveis de se manifestarem como **lesões por assinatura**, que ocorre **quando o instrumento utilizado deixa impressões de seu formato na própria lesão produzida**. Isso pode ser de grande valia para dar pistas de qual foi o objeto usado. Porém, como as rubefações são de desaparecimento muito rápido, geralmente essa análise fica comprometida.



Tumefação (Edema Traumático)

Tumefação é o **acúmulo anormal de líquido no espaço intersticial** decorrente da ação contundente, consistindo em uma alteração mais duradoura que a rubefação. Esse líquido geralmente é composto por uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma, podendo variar de acordo com sua etiologia.

Nos casos de tumefação, **não há rompimento de vasos**. Esses estão preservados.

Na área afetada pela tumefação, observa-se palidez na área da pele, que se apresenta elevada, e, após 1 a 3 minutos, uma rubefação, que sempre costuma acompanhar a tumefação.

Ao contrário do que acontece no edema provocado por doença, o traumático mostra bordas bem definidas, sendo levemente maiores do que o instrumento produtor e, em alguns casos, com o formato desse.

Quando o trauma ocorre em região onde há superfície óssea subjacente, a lesão é chamada de bossa (o famoso "galo").



Escoriação

A escoriação ocorre **quando o instrumento, em ação contundente, age tangencialmente, por atrito e pressão, arranca a epiderme e expõe a derme, fluindo serosidade e/ou sangue**.

Alguns autores chamam de abrasão ou erosão epidérmica, mas pode também ser chamada vulgarmente de esfoladura ou arranhadura. Porém, o termo "erosão" é mais bem empregado para a perda de camadas superficiais da pele de origem patológica, portanto, sem causa traumática.

As escoriações são lesões consideradas superficiais e que não ultrapassam a derme. Entretanto, a profundidade do arrancamento define peculiaridades à lesão, por isso, podendo ser classificada em:



- **Escoriação típica:** quando apenas a epiderme é acometida. Nesses casos, a recuperação se dá por regeneração ou reepitelização. Não ocorre os fenômenos de cicatrização, não deixa marcas, apenas uma mancha de tonalidade rosa enquanto recente, meramente transitória.
- **Escoriação atípica:** quando se atinge a derme. Aqui já ocorre a cicatrização e pode haver a formação de marcas e manchas após a recuperação.

O autor de Medicina Legal, França, diz que, quando a derme é atingida, não se trata mais de escoriação, mas de ferida.

A coloração da crosta indica o nível de profundidade da lesão. Apresentando-se branca-amarelada (de conteúdo seroproteico), é sinal de que as papilas dérmicas não foram lesionadas (escoriação típica). Já a cor amarronzada (devido a presença de conteúdo sanguíneo — hemático) remete à secção das papilas dérmicas (escoriação atípica).



Essa crosta costuma se soltar por volta do 10º dia e a regeneração da pele se dá ao nível do 15º dia.

A formação de crosta é um sinal exclusivo decorrente do indivíduo em vida. Portanto, o cadáver não a apresenta quando ocorre escoriação.

As escoriações podem indicar a direção da força de ação do instrumento ao mostrar formatos em determinados sentidos.

Equimoses

As equimoses são geradas pela infiltração do sangue no interior dos tecidos, superficiais ou profundos, a partir do rompimento de vasos sanguíneos. Para que ocorra esse extravasamento e infiltração, é necessário que haja um plano mais resistente abaixo da região traumatizada.

Outra maneira de ocorrer a formação de equimose além do rompimento de vasos é por meio da diapedese (passagem das células sanguíneas através das paredes dos vasos).



Um instrumento forense recomendado para uma melhor visualização das equimoses é a **Lâmpada de Wood** (luz ultravioleta)

A intensidade e o tamanho expressado pela equimose variam de acordo com:

- o instrumento produtor
- grau de violência empregado
- condições anatômicas e de vascularização da região traumatizada
- constituição pessoal
- sexo, idade e higidez da vítima



As equimoses **podem assumir diversos formatos**, desde minúsculas até acometer grandes áreas. As formas de apresentação das equimoses estão representadas no esquema a seguir:



EQUIMOSSES	PETÉQUIAS	PUNTIFORMES, SENDO PEQUENOS PONTOS DO TAMANHO DA CABEÇA DE UM ALFINETE, GERALMENTE AGRUPADAS
	VÍBICES	FORMATO DE ESTRIAS OU LINHAS
	SUFUSÕES	AMPLA ÁREA DE INFILTRAÇÃO SANGUÍNEA EM FORMATO DE LENÇÓIS
	SUGILAÇÕES	EM FORMATO DE PEQUENOS GRÃOS ("GRÃOS DE AREIA") BEM PRÓXIMOS EM UM ÁREA BEM DELIMITADA, GERALMENTE ORIUNDOS DE ATOS LIBIDINOSOS (EXEMPLO: CHUPÃO)
	EQUIMONAS	EQUIMOSSES DE GRANDES PROPORÇÕES
	MANCHAS EQUIMÓTICAS LENTICULARES DE TARDIEU	SÃO PEQUENOS PONTOS QUE OCORREM NA REGIÃO SUBPLEURAL, SUBPERICÁRDIA E NO TECIDO PALPEBRAL. SUGEREM ASFIXIA, GERALMENTE DIRETA.
	MANCHAS SUBPLUERAIS DE PALTAUF	SUGEREM ASFIXIA POR AFOGAMENTO E SÃO MAIORES QUE AS DE TARDIEU
	CIANO CÉRVICO-FACIAL OU MÁSCARA EQUIMÓTICA DE MORESTIN	EXTENSA MANCHA NA FACE E PESCOÇO. SURGE QUANDO O SANGUE SOBE À CABEÇA MAS NÃO CONSEGUE DESCER. SUGEREM ASFIXIA POR SUFOCAÇÃO INDIRETA
	EQUIMOSSES PERIANAIS OU VULVOVAGINAIS	RELACIONADAS A CRIMES SEXUAIS
	DE ETIOLOGIA NÃO MECÂNICA	EQUIMOSSES ESPONTÂNEAS (EXEMPLO: DECORRENTE DE ESCORBUTO OU DE PÚRPURA) OU MANCHAS EMOTIVAS
	EQUIMOSE RETROFARÍNGEA DE BROUARDEL	LOCALIZADA NA PORÇÃO POSTERIOR DA FARINGE
	EQUIMOSSES RESULTANTES DE ENFORCAMENTOS	SE MANIFESTAM NOS TECIDOS MOLES ABAIXO DA PELE SUBMETIDA À CONSTRIÇÃO DO LAÇO USADO NO ENFORCAMENTO
	EQUIMOSSES A DISTÂNCIA	ORIUNDOS DO AUMENTO DA PERMEABILIDADE CAPILAR

Essas equimoses a distância são provenientes de traumatismos indiretos ou intrínsecos. Assim, são comumente decorrentes de fenômenos de asfixia mecânica.

A partir da coloração apresentada pela equimose, podemos **estimar o tempo que a lesão foi produzida**. Essa variação na cor recebe o nome de **Marcha Equimótica Colorimétrica** ou **Espectro Equimótico de Legrand du Saulle**.

A **esclerótica do olho** e a **região da bolsa escrotal** são dois exemplos em que as equimoses, quando exibidas nessas áreas, podem manter-se **vermelhas até o desaparecimento**. A explicação mais dada pelos autores é que isso ocorre pela **vascularização e oxigenação intensa** dessas regiões.





A análise do espectro funciona melhor em equimoses de **no máximo 5 cm de diâmetro** e a variação de cor observada costuma se dar **da periferia para o centro da lesão**.

A variação é resultado do metabolismo das proteínas de **hemoglobina**, liberadas pelos glóbulos vermelhos destruídos, que são fagocitadas por macrófagos, produzindo **hemossiderina** (que é o equivalente da fração da hemoglobina com ferro).

Isso ocorre porque a porção proteica da hemoglobina é separada do núcleo heme (contém ferro). Ao perder o núcleo heme, perde-se o ferro. Esse ferro passa a se agrupar em moléculas mais complexas (ferritinas), que, enquanto, na sequência, a parte proteica forma grãos de **hemossiderina**.

Posteriormente, o restante da porção heme é transformada em **biliverdina** (cor esverdeada) e em **bilirrubina** (cor amarelada). Já a porção proteica forma **hematoidina** (que é o equivalente da fração da hemoglobina sem ferro) e, por fim, **hematina**.

Detalhe: a hemoglobina só permanece nos glóbulos durante o primeiro dia, depois difunde-se nos tecidos. O surgimento da hemossiderina se dá no terceiro dia. A hematoidina só aparece muito mais tarde e pode permanecer cristalizada por até 60 dias.



Isoladamente, a **hemossiderina** possui **coloração amarelo-acastanhado** e a **hematoidina** é **amarelada**.

Os autores divergem em relação aos períodos em dias que as cores se apresentam. Porém, a sequência cromática é sempre a mesma.

COR	GENIVAL VELOSO DE FRANÇA	HÉLIO GOMES	HERMES DE ALCÂNTARA	LEGRAND DU SAULLE
VERMELHA	1º DIA	1º DIA	1º ao 3º DIA	1º ao 2º ao 3º DIA
VIOLÁCEA-AZULADA	2º ao 6º DIA	2º ao 6º DIA	4º ao 6º DIA	2º ao 3º ao 4º ao 6º DIA
ESVERDEADA	7º ao 12º DIA	7º ao 10º DIA	7º ao 12º DIA	4º ao 6º ao 7º ao 10º DIA
AMARELADA	13º ao 17º DIA	11º ao 20º DIA	13º ao 22º DIA	12º DIA





DICA!

Recomendo memorizar a sequência de dias de acordo com [Legrand du Saulle](#).
Costuma ser a mais cobrada em provas de concursos.

Caso seja feito um estudo histológico, as equimoses tendem a apresentar:

- Descoramento das hemácias nas primeiras 24h;
- Maior descoramento e deformação no 3º dia;
- Surgimento de células fagocitárias no 4º dia;
- Destruição das hemácias e os fagócitos digerem pigmentos e glóbulos no 9º dia;
- Rompimento de todos os glóbulos no 12º dia;
- Predominância de células pigmentárias e todas as hemácias estão destruídas no 18º dia.

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN ADAPTADA – 2021) Ao realizar uma análise de lesão corporal no IML, o médico legista verificou diversas lesões contusas na face, ao redor das órbitas, que apresentavam alterações cromáticas com coloração esverdeada. Com base no espectro equimótico de Legrand, aproximadamente há quantos dias aconteceram as lesões?

- a) 7 a 12.
- b) 2 a 3.
- c) Menos de 1 dia.
- d) 3 a 6.
- e) 13 a 20.

Comentários:

A alternativa A está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Com 2 a 3 dias, a lesão deveria estar vermelha ou roxa.

A **alternativa C** está incorreta. Com menos de 1 dia, a lesão deveria estar vermelha.

A **alternativa D** está incorreta. Com 3 a 6 dias, a lesão deveria estar roxa ou azul.

A **alternativa E** está incorreta. Com 13 a 20 dias, a lesão deveria estar amarelada.



A **Reação de Perls** é uma maneira de **pesquisar quimicamente se há hemossiderina**. Coleta-se uma amostra que é juntada ao ácido clorídrico e ferrocianeto de potássio. A reação resulta positiva para hemossiderina quando surge uma cor azul da Prússia.

Quando, mesmo após a equimose desaparecer, forem verificados **pigmentos da decomposição do sangue na rede ganglionar** próxima à referida lesão, dá-se o nome de **Sinal de Kunckel**.

Infelizmente, trata-se de uma estimativa bastante debatida pelos estudiosos de Medicina Legal, sendo seus **resultados controversos e devem ser considerados com um grau relativo de precisão**.

A marcha costuma ser mais rápida em crianças e, quanto mais extensa e profunda for a equimose, mais lento será o processo.

Além disso, sexo, estado geral da vítima, região atingida, elasticidade tecidual, calibre do vaso afetado e outros fatores são bastante influentes na evolução da tonalidade.



(FUNCAB/POLITEC-MT - 2013) A reação de Perls positiva ocorre na presença de:

- a) hemoglobina, entre o 3 e o 12 dias.
- b) hemoglobina, entre o 12 e o 60 dias.
- c) hematoína, entre o 3 e o 12 dias.
- d) hemossiderina, entre o 12 dia e o 60 dias.
- e) hemossiderina, entre o 3 e o 12 dias.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A reação de Perls não detecta hemoglobina.

A **alternativa B** está incorreta. A reação de Perls não detecta hemoglobina.

A **alternativa C** está incorreta. A reação de Perls não detecta hematoídina (hematoína).

A **alternativa D** está incorreta. A hemossiderina não aparece tão tarde.

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

Para se determinar se a lesão foi produzida com a vítima ainda em vida, pode-se verificar se ocorreu coagulação e a respectiva reação inflamatória. Uma forma de realizar tal verificação é através do **Índice de Verderau**, que é o resultado da **divisão entre o número de glóbulos vermelhos pelos brancos**.



Nos casos de produção da lesão após a morte, esse índice não sofre alteração. Enquanto nos traumatismos em vida, o resultado é uma diminuição de índice por causa do aumento no número de glóbulos brancos na região afetada.

As equimoses podem manifestar-se como **lesões por assinatura**, sendo seu valor maior do que as rubefações, por serem mais duradouras.

Um exemplo bastante comum de lesão por assinatura é o de quando objetos cilíndricos e roliços, como cassetetes e bastões, são utilizados e deixam duas equimoses longas e paralelas, com o centro claro e o extravasamento do sangue sendo pelas laterais do impacto.

Outro exemplo são as chamadas **estrias pneumáticas de Simonin** que são observadas quando um veículo passa por cima de uma vítima, deixando **estriações de formato peculiar e bastante semelhantes à trama do pneumático envolvido**.

Ressalta-se a importância forense que envolve as equimoses, que são suas **sugestões de ação criminosa** a partir da localização, multiplicidade e demais características das lesões. Como exemplos: esganaduras são sugeridas quando são observadas petéquias na face e **equimoses ungueais** (**produzidas por unhas**) na região cervical; e crimes sexuais são sinalizados com equimoses nas regiões genitais, perianal, peitoral e pescoço.

Uma diferenciação bastante importante é a de caracterizar a equimose frente aos livores de hipóstases, para que não ocorra constatações errôneas. Assim, temos:

LIVORES DE HIPÓSTASE

- O sangue permanece no interior dos vasos(não infiltrado em tecido) e não coagulado;
- Não há malhas de fibrina;
- São verificados nas regiões e declive depender da posição em que o cadáver se encontra.

EQUIMOSE

- Originada de sangue da infiltração de ruptura de vasos sanguíneos (infiltração hemorrágica)
- O sangue está fora dos vasos e costuma estar coagulado;
- Observa-se malhas de fibrina

Por fim, através da constatação e análise de uma equimose, é possível:

- Atestar a ocorrência de uma ação contundente;
- Estimar o tempo de produção da lesão;
- Aferir se a lesão foi provocada em vida;
- Sugerir o instrumento causador do trauma; e
- Sugerir o tipo de agressão (localização, quantidade de lesões e demais características).



Hematoma

O **hematoma** é a **coleção de sangue em uma cavidade neoformada decorrente da ruptura de vasos calibrosos após ação traumática**. O sangue extravasado desses vasos é acumulado e consegue promover a distensão do tecido.

Não se considera hematoma, o sangue que se acumula em cavidades naturais (exemplos: cavidades pleurais e pericárdio). É necessário que haja a formação de uma cavidade nova pelo próprio sangue extravasado.

Um sinal importante é aferido quando se apalpa a região afetada pelo hematoma. Ao toque, nota-se uma sensação de flutuação.



EQUIMOSE X HEMATOMA

Enquanto nas equimoses o sangue infiltra-se nos tecidos, no hematoma o tecido é deslocado pelo sangue. Assim, o hematoma é passível de ser drenado.

A absorção do sangue do hematoma pelo corpo é mais demorada nos casos de hematoma do que das equimoses.

Bossa

A **bossa** é determinada quando, frente a uma ação contundente, ocorre **aumento de volume tecidual por coleção de líquido infiltrativo** decorrente de um distúrbio circulatório. Geralmente, há a presença de planos ósseos subjacentes que favorecem a sua formação (exemplo: na cabeça).

As bossas podem ser **serosas ou sanguíneas**, a depender do seu conteúdo. As **serosas** possuem a cavidade preenchida por **conteúdo linfático** (exemplo: galo d'água) e as **sanguíneas**, como é de se esperar do nome, são **preenchidas por sangue**.

BOSSA X HEMATOMA

A bossa sanguínea difere-se do hematoma por apresentar-se sobre um plano ósseo, sendo bastante saliente na superfície cutânea. Além disso, a bossa não apresenta ruptura dos vasos, diferentemente do hematoma.

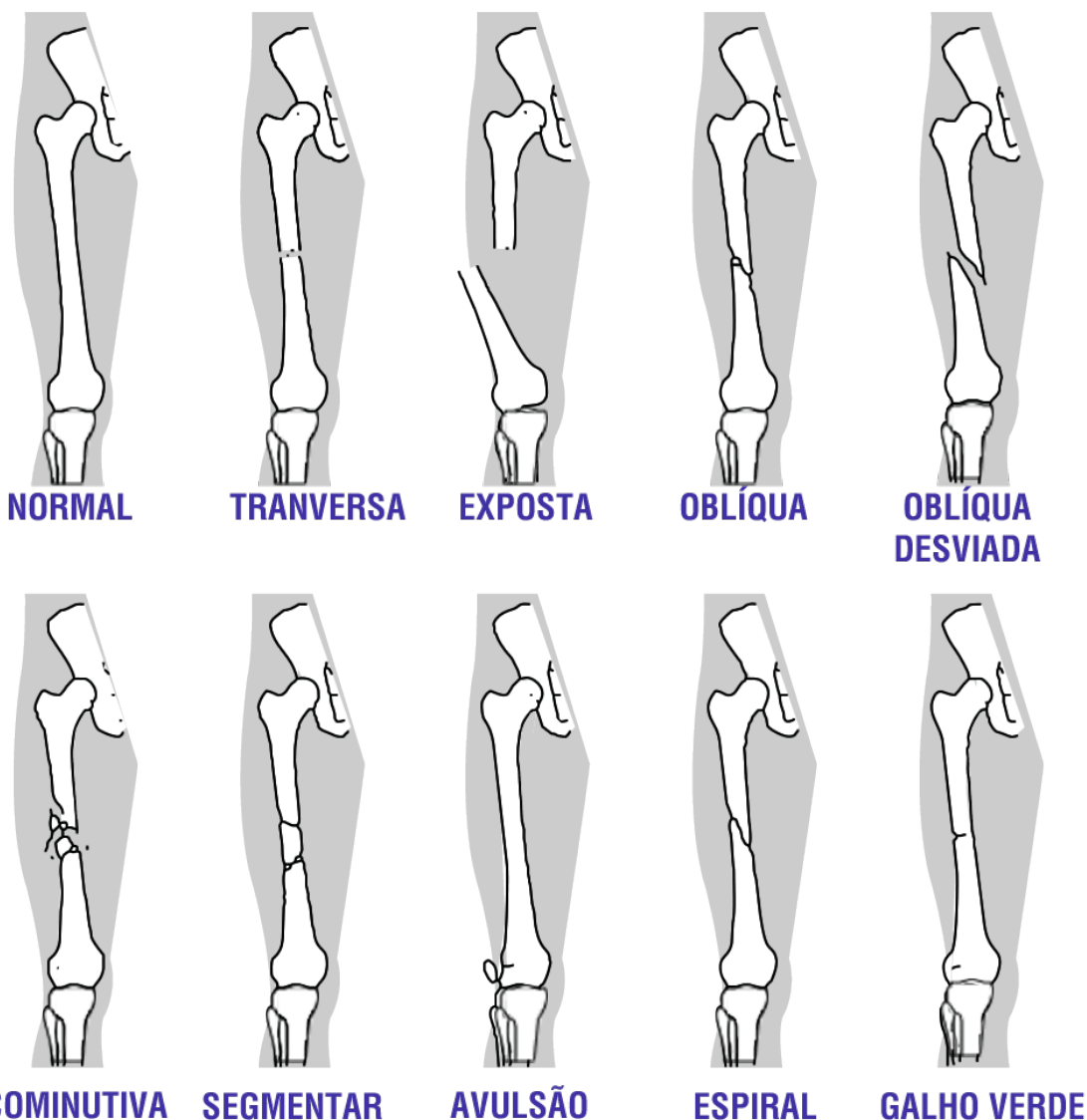


Fratura

Fratura é nada mais nada menos que a **solução de continuidade óssea** (quebra do osso), sendo geralmente relacionada aos mecanismos de compressão, flexão ou torção.

As fraturas podem se apresentar de diversas formas:

TIPOS DE FRATURA



Normalmente, a consolidação da fratura gira em torno de 20 a 30 dias aproximadamente. Após esse período, os fragmentos costumam estar reunidos por um **calo ósseo**, que é um **tecido ósseo formado a partir do hematoma no foco da fratura**.

Um sinal que costuma ser apresentado para indicar que a fratura foi realizada ainda em vida é a **infiltração hemorrágica no local de solução de continuidade**. Outras análises podem envolver estudos químicos (de histamina, catepsina D, serotonina, ferro, cobre e zinco), imuno-histoquímico (anticorpo monoclonal anti-humano/glicoforina A) ou a observação de diferenças no padrão de fratura nos ósteons de ossos frescos e secos.



Um tipo de fratura muito cobrada em concursos é a chamada **fratura em mapa-mundi de Carrara**. Nessa fratura, observa-se várias **fissuras arqueadas que parecem imitar os meridianos e paralelos de um mapa-múndi**.

Outra que merece destaque, mas é menos presente nas provas, é a **fratura "saca-bocado" de Strasmann ou em vazador**. Essa fratura ocorre quando o instrumento, **geralmente um martelo**, atua perpendicularmente à superfície óssea. Com isso, a fratura possui um **formato circular com o diâmetro semelhante ao do instrumento causador**.

Entorse

A **entorse** acontece quando se **ultrapassa a amplitude normal dos movimentos articulares**, geralmente em decorrência de forças externas, **causando o estiramento da cápsula de uma articulação**.

Nesses casos, as extremidades ósseas da articulação afastam-se temporariamente e, em seguida, retornam às suas relações normais. Portanto, incide sobre os ligamentos, podendo haver ruptura ou não, porém sem chegar à luxação.

O exemplo de entorse mais comum é a da articulação tibiotársica (famosa torção de tornozelo) ao haver um movimento repentino e intenso de adução do pé.

Luxação

A **luxação** é o **deslocamento permanente e repentino de superfícies articulares**, perdendo-se o alinhamento normal das peças que se articulam e provocando ruptura capsular.

Quando ainda há algum contato entre essas peças e a **separação articular é definida como incompleta**, chama-se de **subluxação**.

Além disso, podem ser **fechadas ou abertas (expostas)**, sendo essas de ocorrência mais rara.

A articulação mais acometida pela luxação é a escapuloumeral.



As luxações são consideradas **lesões mais graves do que as entorses**. Porém, não costumam acometer crianças, porque suas articulações possuem uma mobilidade maior; e idosos, porque como seus ossos são mais fracos, esses costumam ceder e fraturar antes mesmo da luxação acontecer.

Ferida Contusa

As **feridas contusas** são **lesões abertas em que a ação contundente chegou ao ponto de ultrapassar a resistência e elasticidade dos tecidos moles**, portanto, com solução de continuidade com planos subjacentes, havendo até rompimento de vasos sanguíneos.

Essas feridas são produzidas por mecanismos de compressão, pressão, percussão, explosão, arrastamento, tração ou torção.

Comumente as feridas contusas apresentam as seguintes **características**:

- **Bordas irregulares**, denteadas, indefinidas, tortuosas e equimосadas.
- **Fundo da lesão irregular**, profundidade variável, com algumas feridas mostrando **pontes de tecido** unindo as vertentes de um lado a outro da ferida
- **Pouco sangrante**, pois os vasos são geralmente esmagados, causando uma hemostasia mecânica
- Há **integridade dos vasos, nervos e tendões** no fundo da lesão
- Podem variar do **aspecto estrelado ao retilíneo**

Lembrar de que a ação de instrumentos cilíndricos sobre locais em que há planos ósseos subjacentes possuem a capacidade de produzir feridas contusas de bordas definidas e que **podem ser confundidas com lesões incisas**.

Alguns autores admitem a ocorrência de lacerações ou lesões lacerocontusas, que causa rompimento de tecidos e se apresentam como lesões amorfas. Porém outros, como França, não as consideram, acusando-as de **termo impróprio**.



Casos Especiais: Precipitação e Defenestração

- **Precipitação** é a queda de um corpo de um local de certa altura, geralmente apartamentos, torres, precipícios, etc. Enquanto defenestrar é o ato de atirar algo ou alguém pela janela.



- **Defenestração**, em âmbito de Medicina Legal, é quando um corpo é arremessado através da janela.

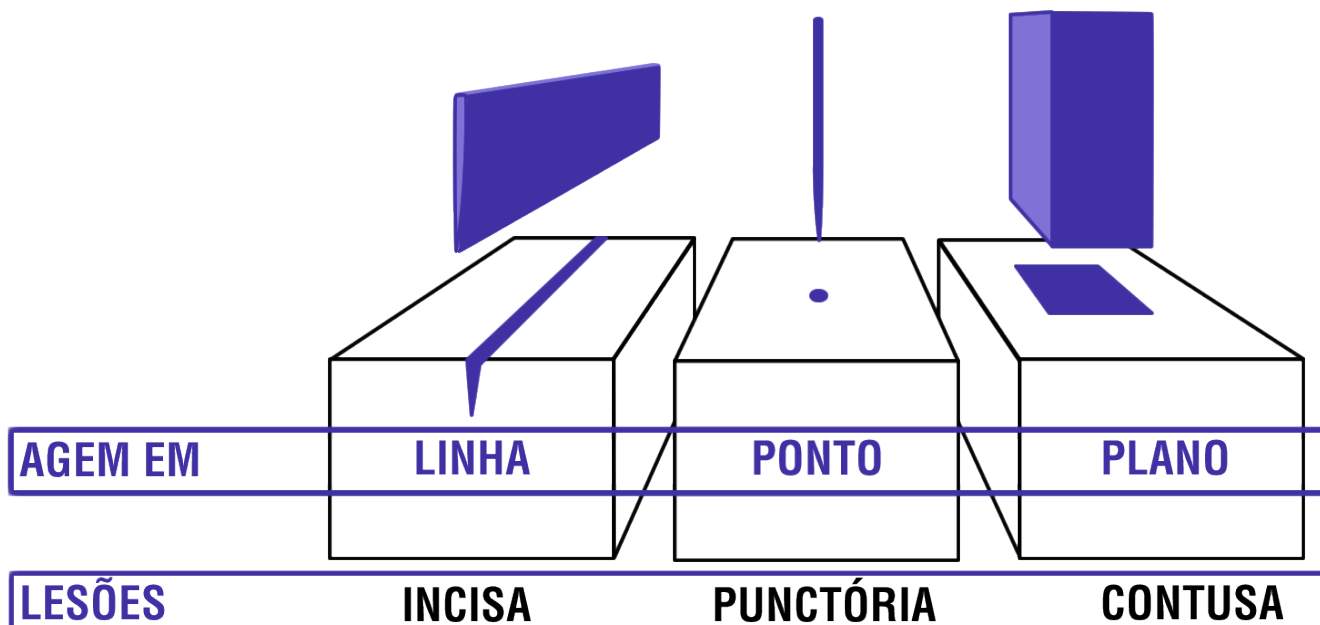
Em ambas as situações, precipitando ou defenestrando, caso a queda se dê de cabeça, observa-se a fratura do crânio do tipo "saco de noz", devido ao grau de fragmentação apresentado e a laceração da massa encefálica. Caso a queda seja em pé, os membros inferiores e a pélvis é que sofrem os maiores danos, tendo múltiplas fraturas. E naquele em que o indivíduo caia de lado, as costelas costumam fraturar.

Tanto nos casos de precipitação quanto de defenestração, é importante verificar a **distância entre o corpo e o local de lançamento**.

Nos **suicídios**, essa **distância tende a ser grande**, pois a vítima costuma se impulsionar para ter êxito na ação. Já nos **homicídios**, a **distância verificada é média**, levando-se em consideração que o corpo foi impulsionado por alguém. Por fim, nos **acidentes**, o corpo tende a estar bem próximo ou rente a base do local de lançamento, portanto, uma **distância pequena**.



INSTRUMENTOS	CORTANTE	PERFURANTE	CONTUNDENTE
--------------	----------	------------	-------------



HORA DE
PRATICAR!

(IADES/SPTC-GO – 2023) Em processamento de local de crime contra a pessoa, durante o exame perinecrocópico, são encontradas lesões típicas para cada instrumento usado no crime, como ferimentos punctórios, contusos, incisos e mistos. Analogamente, cada instrumento recebe uma classificação de acordo com a típica lesão que é capaz de provocar. Os instrumentos “punhal”, “barra metálica” e “projétil expelido por arma de fogo” são classificados, respectivamente, como agentes

- a) cortocontundente, contundente e cortante.
- b) perfurocortante, contundente e perfurocontundente.
- c) cortocontundente, perfurocontundente e contundente.
- d) contundente, cortante e perfurocontundente.
- e) perfurocortante, contundente e contundente

Comentários



Punhal - Instrumento perfurocortante
Barra metálica - Instrumento contundente
PAF - Instrumento perfurocontundente.

Gabarito: Letra B.

3.4 – Instrumentos Perfurocortantes

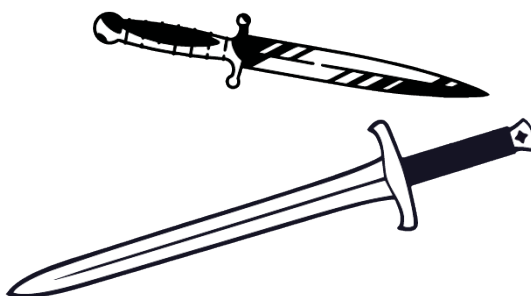
Os instrumentos perfurocortantes agem, ao mesmo tempo, por pressão (para perfurar) e deslizamento (corte/secção). Assim, devem possuir ponta (perfurante) e um ou mais gumes (cortantes).

INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES		
GUME ÚNICO	DOIS GUMES	TRÊS GUMES
FACA	PUNHAL	LIMA
CANIVETE	BAIONETA	ALGUMAS ADAGAS
	ESPADA	ESTOQUES FEITOS DE VERGALHÕES

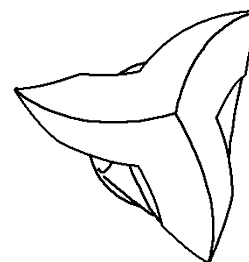
EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS PERFUROCORTANTES



DE 1 GUME



DE 2 GUMES



DE 3 GUMES

A lesão produzida é denominada **perfuroincisa** e possui como características:

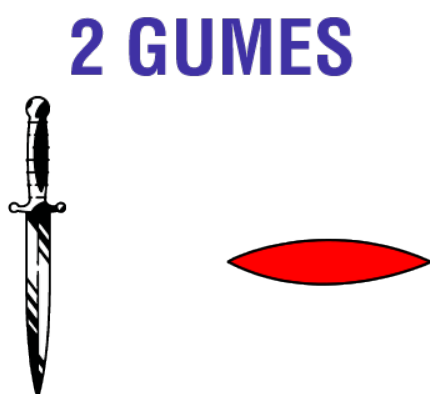
- o Bordas regulares
- o A hemorragia (sangramento) pode ser escassa externamente e intensa internamente
- o A profundidade da lesão tende a prevalecer sobre a extensão
- o O formato da lesão varia conforme o número de gumes

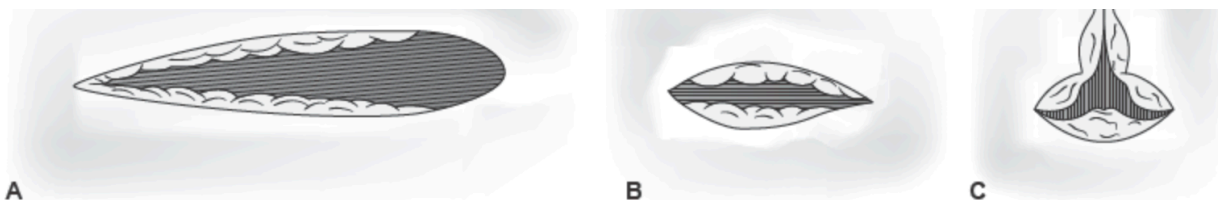
Os instrumentos de **gume único** produzem ferida em **forma de botoeira**. Porém, apresenta um ângulo agudo e outro arredondado, como se fosse um triângulo em que a base corresponde ao dorso do objeto/lâmina. Caso o dorso do instrumento não entre em contato com a pele após a ponta penetrar, a lesão pode se assemelhar com a causada por dois gumes.

As lesões produzidas por instrumento de **dois gumes** possuem **formato de fenda ou de botoeira**, com ângulos bastante agudos. Centralmente, o afastamento das bordas apresenta-se maior, sendo menor à medida que se aproxima dos ângulos.

Nos casos de instrumentos com **mais de dois gumes**, a lesão **tem formato poligonal ou estrelado, variando o número de pontas de acordo com a quantidade de gumes**. Enquanto o instrumento está perfurando os tecidos, as forças de suas faces estão sendo equilibradas pela elasticidade da pele. Ao ser removido, a resistência da pele é liberada e faz com que as bordas da ferida sejam parcialmente migradas em direção ao centro da lesão.

À medida que o número de gumes aumenta, a tendência da ferida é de seguir às leis de Filhos e Langer. Pois esse aumento faz com o que o instrumento se aproxime mais de um formato cilíndrico ou cônico, fazendo com que a lesão aparente ter sido causada por um instrumento perfurante de calibre médio.



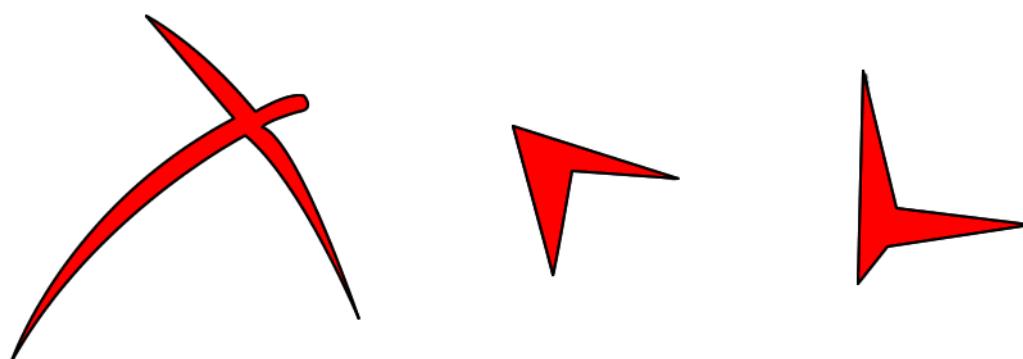


Fonte: Vanrell JP. Odontologia Legal e Antropologia Forense, 3ª edição. 2019. Lâmina com um gume (A), lâmina com dois gumes (B) e com três gumes (C).

Além dos ângulos normalmente visualizados, nos casos em que houver **movimento de rotação do instrumento durante sua saída**, podem ser observados **ângulos acessórios**.

Outras deformações podem ser causadas pela **movimentação do instrumento** durante a produção da lesão, podendo apresentar **alargamento ou ampliação da ferida**.

Um tipo especial de deformação, chamada de "**Cauda de Andorinha**", é quando, **sem remover o instrumento**, são realizados movimentos que aparentam produzir duas lesões diversas que **se cruzam**.



LESÕES “EM CAUDA DE ANDORINHA”



Agentes Perfurantes x Agentes Perfurocortantes



As lesões produzidas por agentes perfurantes possuem a orientação de fenda, obedecendo a direção das fibras do tecido. Caso o maior eixo da fenda não coincida com a direção das fibras afastadas da pele, essa lesão deve ter sido produzida por um agente perfurocortante.

A classificação das lesões perfuroincisas (dada por Vanrell) é feita em:

- **Penetrantes:** são as mais graves e entram em cavidades preexistentes (pleural, pericárdica, peritoneal...)
- **Perfurantes:** penetram em uma parte maciça do corpo e não possuem saída
- **Transfixantes:** atravessam órgão e estruturas corporais totalmente ou parcialmente
- **Em "fundo de saco" ou "fundo cego":** o instrumento ao entrar no corpo, encontra um obstáculo, causando uma limitação da sua ação., limitando-a
- **"Em acordeão" ou "em sanfona" (Lacassagne):** ocorrem quando a superfície do corpo é depressível, podendo produzir uma lesão mais profunda do que o próprio comprimento do instrumento

*O autor Hygino Hércules ainda adiciona o grupo das superficiais, que atingem apenas as primeiras camadas da pele.

As feridas perfuroincisas estão **geralmente relacionadas aos homicídios, sendo o suicídio e acidentes mais raros**. A fim de se realizar o diagnóstico diferencial, deve-se observar a quantidade, a localização, a direção das lesões e outros sinais de violência.

Nos casos de homicídio, é comum que a vítima apresente **lesões de defesa** nas palmas das mãos, nas bordas mediais dos antebraços, ombros e no dorso.

(CESPE/PC-MA - 2018) Uma vítima de agressão apresenta duas lesões no tórax: a primeira tem as bordas nítidas, definidas e regulares, sem nenhum sinal em torno da lesão; a segunda apresenta formato ovalado, com uma das bordas em ângulo agudo e a outra arredondada. Essas lesões são classificadas, respectivamente, como ferida

- a) perfurante, causada por instrumento perfurocortante e ferida cortante, causada por instrumento deslizante.
- b) incisa, causada por instrumento cortante e ferida perfurocortante, causada por instrumento perfurocortante com um gume.
- c) contusa, causada por instrumento contundente e ferida incisa, causada por instrumento deslizante.
- d) perfurocortante, causada por instrumento perfurante e ferida cortocontusa, causada por instrumento contundente.



e) incisa, causada por instrumento deslizante e ferida perfurocortante, causada por instrumento com dois gumes.

Comentários

Bordas regulares, definidas e nítidas são características de feridas incisas.

Formato ovalado, com uma borda arredondada e outra aguda é característica de uma ferida perfuroincisa em que foi utilizado um instrumento perfurocortante de um gume só (o gume fica voltado para a borda aguda).

Assim, a alternativa B está correta e é o gabarito da questão.

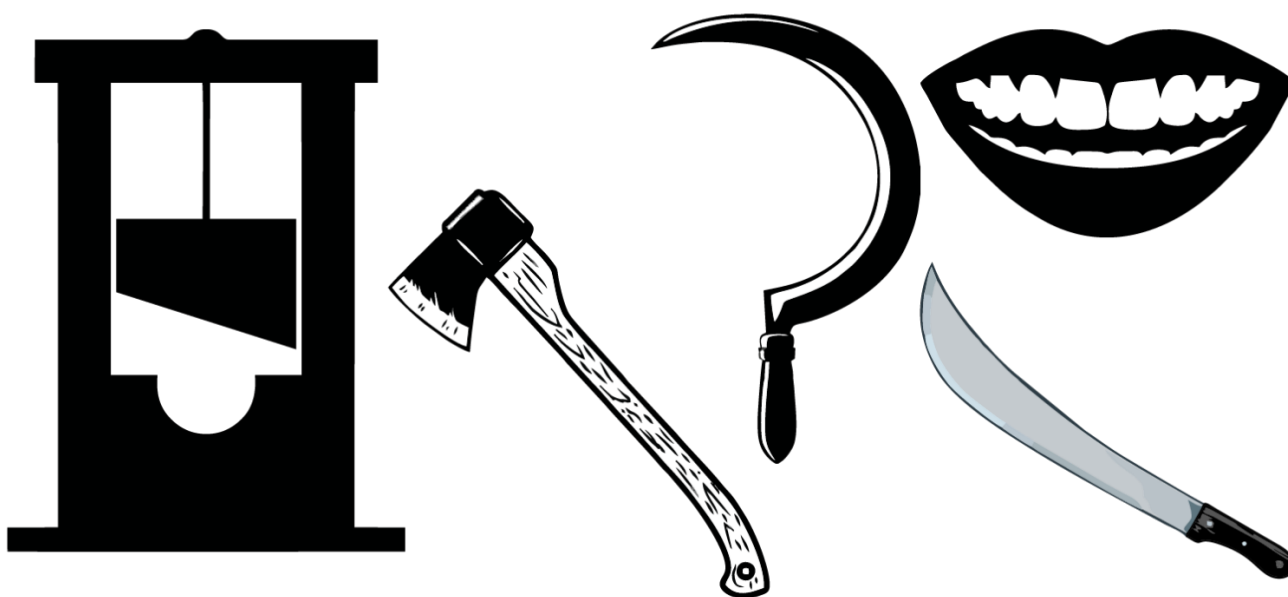
3.5 – Instrumentos Cortocontundentes

Os instrumentos cortocontundentes, ao mesmo tempo, agem cortando (deslizamento) e contundindo (percussão ou pressão). Assim, são instrumentos que, mesmo possuindo gume, são também influenciados pela ação contundente, causando lesões chamadas de cortocontusas.

Geralmente, a ação se dá mais pela ação contundente de pressão. Assim, são instrumentos com massa considerável que transferem sua energia por meio de um gume.

INSTRUMENTOS CORTOCONTUNDENTES			
FOICE	MACHADO	DENTES	GUILHOTINA
FACÃO	ENXADA	UNHAS	TESOURA

EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS CORTOCONTUNDENTES



(IDECAN/PEFOCE – 2021) Qual dos instrumentos a seguir geralmente está associado aos ferimentos cortocontusos?



- a) Prego.
- b) Gilete.
- c) Projétil de arma de fogo.
- d) Chave de fenda.
- e) Machado.

Comentários:

A alternativa A está incorreta. Instrumento perfurocontundente.

A alternativa B está incorreta. Instrumento cortante.

A alternativa C está incorreta. Instrumento perfurocontundente.

A alternativa D está incorreta. Instrumento perfurocontundente.

A alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

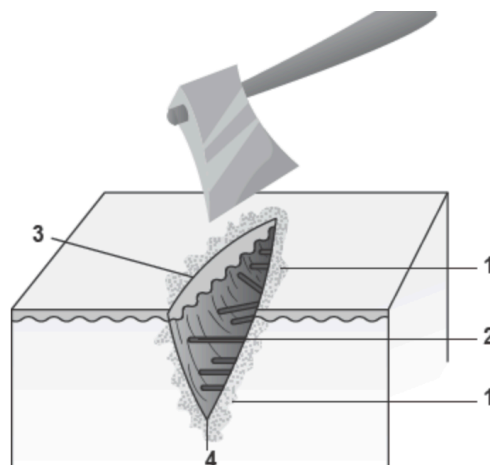
Os ferimentos podem variar bastante a depender do peso, força e velocidade em que os instrumentos são usados, ocorrendo mais ação contundente ou cortante. Pois a ação contundente pode agir pelo próprio peso do instrumento ou de maneira ativa através do seu manejo. Enquanto o corte vai depender de quão afiado está o gume.

Assim, caso prevaleça a ação cortante, o ferimento apresenta mais características de ferida incisa. Em contrapartida, nos casos em que a ação contundente seja enaltecida, as lesões possuem mais aspectos de ferimentos contusos.

No geral, as feridas cortocontusas apresentam as seguintes características:

- Retas e com bordas afastadas, regulares, porém escoriadas. Quanto mais afiado o gume, mais regular é o ferimento. Caso a ação contundente prevaleça, observa-se bordos irregulares.
- Vertentes planas, mas com certo grau de laceração nos diversos planos, principalmente nos musculares
- Sangramento abundante
- Não é comum apresentar cauda de escoriação
- Perda de substância é comum





Fonte: Vanrell JP. Odontologia Legal e Antropologia Forense, 3ª edição. 2019. 1. Equimoses em torno da lesão. 2. Trabéculas no fundo. 3. Borda irregular. 4. Fundo anfractuoso.

São lesões geralmente de gravidade considerável, profundas, atingindo vários planos, inclusive provocando fraturas (que costumam apresentar o traço de fratura que copia o gume do instrumento).

Alguns sinais indicam se as lesões foram produzidas em vida, como a infiltração sanguínea nas bordas da lesão e a retração tecidual das bordas do ferimento.



Os **exemplos especiais** de lesões cortocontusas são: decapitação, espostejamento, esquitejamento e as dentadas/mordidas.

- **Decapitação:** significa **destacar a cabeça do restante do corpo**. Já vimos essa classificação, em detalhe, nos instrumentos cortantes. Porém, também pode ser provocada por ação cortocontundente (Ex: no uso da guilhotina).
- **Espostejamento:** é a **redução do corpo em fragmentos diversos e irregulares**, sendo comum em acidentes ferroviários e aéreos.
- **Esquitejamento:** é a **redução do corpo em quartos** (fragmentos mais regulares que o espostejamento) por amputação ou desarticulação. Geralmente tem a finalidade de dificultar a identificação do cadáver.





HORA DE PRATICAR!

(IBFC/Polícia Científica-PR - 2017) Ferimentos cortocontundentes são causados por instrumentos que, mesmo apresentando gume, são influenciados pela ação contundente. Em relação a esses ferimentos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A dentada não é considerada um tipo de lesão cortocontusa.
- II. Quando o fio de corte for afiado, prevalecem os caracteres de contusão dos tecidos.
- III. A ação de uma foice tipicamente causa uma lesão cortocontusa.
- IV. As lesões cortocontusas apresentam forma bem variável, dependendo da região atingida, da inclinação, do peso, do gume e da força que atua.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) III e IV, apenas

Comentários

A afirmativa I está incorreta. Os dentes são instrumentos tipicamente cortocontudentes.

A afirmativa II está incorreta. Quando o fio de corte é afiado, prevalecem as características cortantes.

A afirmativa III está correta.

A afirmativa IV está correta.

Assim, a alternativa E está correta e é o gabarito da questão.

(AOCP/PC-ES - 2019) Em uma avaliação de lesão corporal em uma mãe e em seu filho, no IML, o médico- legista notou equimose e escoriação na face da mãe e uma marca de mordida no pescoço do filho. As ações/meios que causaram as lesões na mãe e no filho são, respectivamente:



- a) perfurante e contundente.
- b) contusa e cortocontusa.
- c) contundente e contusa.
- d) contundente e cortocontundente.
- e) contundente e cortante.

Comentários:

Equimoses e escoriações são lesões resultantes de ação contundente, enquanto que as marcas de mordida são resultado de ação cortocontundente.

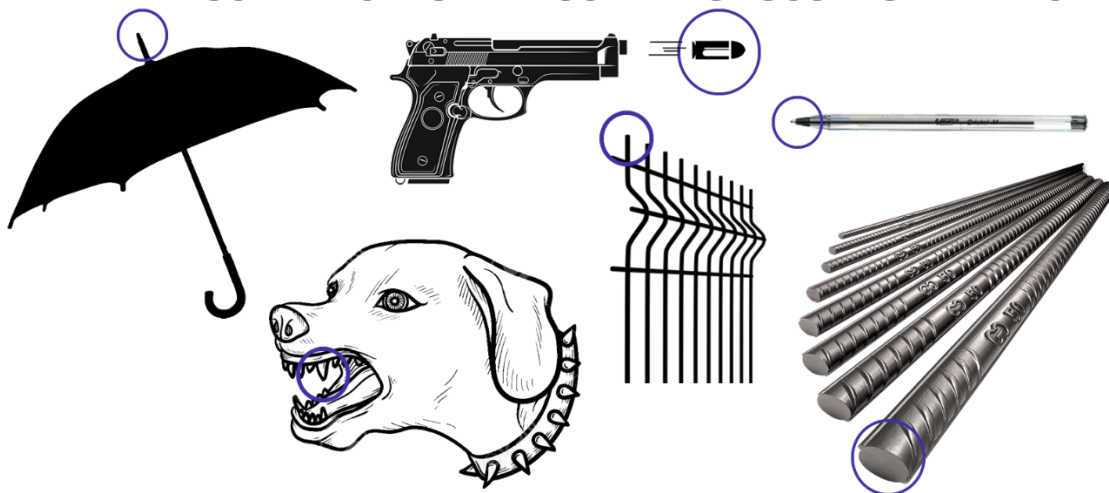
Gabarito: Letra D

3.6 – Instrumentos Perfurocontundentes

Os instrumentos perfurocontundentes atuam por mecanismos de ação que perfuram (age sobre um ponto) e contunde (age sobre um plano) ao mesmo tempo. Em sua maioria, a ação perfurante prevalece.

INSTRUMENTOS PERFUROCONTUNDENTES		
PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO (PAF)	DENTES CANINOS DE ANIMAIS	VERGALHÃO
PONTA DO GUARDA-CHUVA	CANETA ESFEROGRÁFICA	PONTA DE GRADE DE FERRO

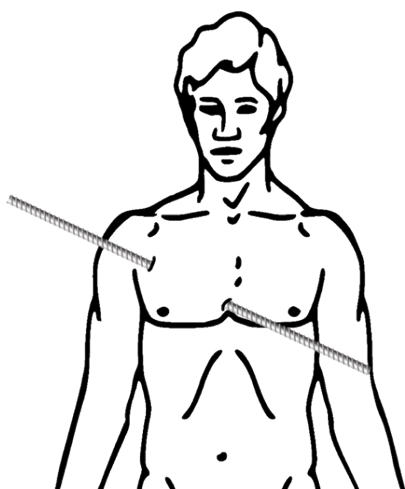
EXEMPLOS DE INSTRUMENTOS PERFUROCONTUNDENTES



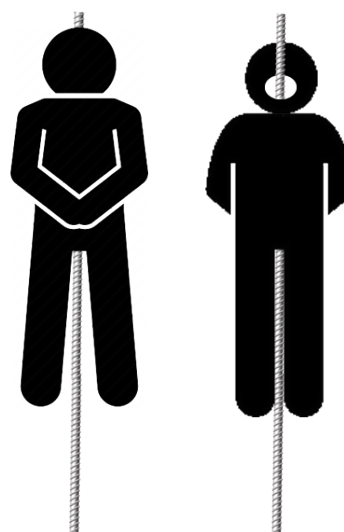
Os **exemplos especiais de lesões perfurocontusas** são o encravamento e o empalamento.

- **Encravamento:** é o processo de encravar um objeto consistente e afiado em qualquer parte de um corpo humano. São casos de grande impacto, em que o corpo com grande velocidade vai de encontro ao objeto ou ambos colidem em grande velocidade. É de natureza quase sempre acidental.
- **Empalamento:** é uma variante especial do encravamento em que o objeto, de comprimento considerável, penetra pelo ânus ou região perineal. Alguns autores admitem ser pela cicatriz umbilical e vagina. Originalmente, o instrumento acaba por sair pela cavidade oral.

ENCRAVAMENTO



EMPALAMENTO



Como o exemplo clássico de instrumento perfurocontundente é o projétil de arma de fogo (PAF), vamos dedicar especialmente uma parte para abordar a balística e outra para os aspectos relacionados a sua ação lesiva.

Assunto interessante demais, não acha? Pra facilitar, fiz um esquema resumindo alguns pontos importantes:

Com isso, finalizamos a aula de hoje. :) Vamos praticar com algumas questões?

- Lesões Punctórias / Puntiforme - Instrumento de calibre pequeno = lesão em formato de ponto - Instrumento de calibre médio = lesão em formato de "casa de botão" - Pouco/Raro sangramento - Diâmetro < Instrumento - Ferimento de saída irregular e menor que o de entrada	- Lesões Incisas - Bordas e vertentes regulares, lisas e afastadas - Formato fusiforme, linear e uniforme - Comprimento > Largura - Comprimento > Profundid. - Sangramento abundante - Fundo da lesão regular, limpo, sem trabéculas de tecido - Sem sinais de contusão - Cauda de escoriação (Sinal de Romanese ou de Lacassagne)	- Lesões contusas - Hematoma - Bossa - Fratura - Entorse - Luxação - Ferida Contusa - Solução de continuidade - Bordas irregulares - Fundo da lesão irregular - Pouco sangrante - Integridade de vasos, nervos e tendões - Aspecto estrelado e retilíneo	- Lesões perfuroincisas - Bordas regulares - Sangramento pode ser escasso externamente e intenso internamente - Profundidade > extensão - Formato variável (gumes) - 1 gume = lesão em botoeira - 2 gumes = fenda ou botoeira - 3 gumes = estrelado / poligonal - Quanto maior o n° de gumes mais se aproxima da Lei de Filhos e Langer	- Lesões cortocontusas - Retas e com bordas afastadas, regulares, porém escoriadas. - Vertentes planas - Sangramento abundante - Perda de substância - Gravidade considerável - Pode apresentar fraturas - Decapitação - Espostejamento - Esquartejamento - Mordidas	- Lesões perfurocontusas - Encravamento - Empalamento - Projétil de arma de fogo (PAF)
INSTRUMENTO PERFORANTE	INSTRUMENTO CORTANTE	INSTRUMENTO CONTUNDENTE	INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE	INSTRUMENTO CORTO-CONTUNDENTE	INSTRUMENTO PERFURO-CONTUNDENTE
					

QUESTÕES COMENTADAS



HORA DE
PRATICAR!

1. (FGV/PC-AM – 2022) Lesões produzidas por meio de lâminas têm bordas regulares e podem ter profundidade significativa dependendo da massa do objeto.

Assinale a afirmativa correta sobre feridas corto-contusas encontradas no pescoço por um perito na cena de crime.

- a) Chama-se degola quando o ferimento é anterior.
- b) Quando o ferimento é em região posterior do pescoço, chama-se esgorjamento.
- c) Degola corresponde a decapitação.
- d) Chama-se degola quando o ferimento é lateral.
- e) Esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Degola é na região posterior do pescoço.



- A **alternativa B** está incorreta. Esgorjamento é na região anterior ou lateral.
- A **alternativa C** está incorreta. Decapitação é a separação da cabeça do corpo.
- A **alternativa D** está incorreta. Degola é na região posterior do pescoço.
- A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

2. (FGV/PC-AM – 2022) No estudo das energias de ordem mecânica, a classificação médico-legal dos agentes pressupõe, invariavelmente, como primeira etapa, a análise da lesão para sua denominação. A literatura científica referencia que os arcos dentários humanos podem produzir vários tipos de feridas. Segundo Arbenz (1988) a dinâmica da mordida é habitualmente classificada como instrumento do tipo

- a) perfurante.
- b) contundente.
- c) corto-contundente.
- d) cortante.
- e) perfuro-contundente.

Comentários:

- A **alternativa A** está incorreta. Dentes humanos tipicamente não perfuram.
- A **alternativa B** está incorreta. Dentes humanos podem até só contundir, mas fazem mais...
- A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.
- A **alternativa D** está incorreta. Dentes humanos podem até só cortar, mas fazem mais...
- A **alternativa E** está incorreta. Dentes humanos tipicamente não perfuram.

3. (FGV/PC-AM – 2022) Entre as lesões contusas superficiais causadas por ação física mecânica, temos a equimose. Na sufusão ocorre a transformação química da hemoglobina fora do vaso determinando a mudança cromática no tecido traumatizado.

Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, indique a sequência de cores no processo evolutivo dessa lesão.

- a) Vermelho-violáceo, avermelhado, azulado, esverdeado e amarelado.
- b) Avermelhado, azulado, vermelho-violáceo, esverdeado e amarelado.
- c) Avermelhado, azulado, esverdeado, vermelho-violáceo e amarelado.



- d) Avermelhado, vermelho-violáceo, azulado, esverdeado e amarelado.
- e) Vermelho-violáceo, avermelhado, esverdeado, azulado e amarelado.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Do violáceo não vai para o vermelho.

A **alternativa B** está incorreta. Do azulado não vai para o vermelho.

A **alternativa C** está incorreta. Do esverdeado não vai para o vermelho.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. Do violáceo não vai para o vermelho... e do esverdeado não vai para o azulado.



4. (VUNESP/PC-RR – 2022) Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, a forma das lesões assume um aspecto diferente. Na confluência de regiões de linhas de força diferentes, a extremidade da lesão toma um aspecto triangular de ponta de seta obedecendo:

- a) 1ª Lei de Filhos.
- b) 2ª Lei de Filhos.
- c) Lei de Langer.
- d) Lei da Gravidade.
- e) Lei de Benassi.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A 1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança): as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (pérfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão".

A **alternativa B** está incorreta. A 2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo): quando as feridas se localizam na mesma região do corpo que possua as linhas de força dispostas em uma só direção, seu maior eixo tem sempre a mesma direção.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A Lei de Langer (**Lei do Polimorfismo ou da Elasticidade**) diz o seguinte: Nas regiões em que ocorre cruzamento (convergência ou confluência) de fibras de sentidos diferentes, as extremidades da lesão assumem um aspecto de ponta de seta, de triângulo ou até de quadrilátero.

A **alternativa D** está incorreta. Gravidade? Sério?



A **alternativa E** está incorreta. Conheço o Sinal de Benassi... Lei ainda não...

5. (VUNESP/PC-RR – 2022) São lesões provocadas, em geral, por pressão, compressão, distensão, torção e se constituem em danos muito comuns nas perícias médicas e odontológicas. Essas lesões são produzidas por agentes ou instrumentos denominados

- a) perfurantes.
- b) contundentes.
- c) cortantes.
- d) perfuro-cortantes.
- e) punctatos.

Comentários:

Todas as lesões descritas são do tipo contusa. Portanto, ação contundente.

Assim, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

6. (FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

() *Blast Injury* é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica, lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.

() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou antero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F, V e V.
- b) V, F e F.
- c) F, F e F.



d) V, F e V.

e) V, V e V.

Comentários:

O primeiro item está **correto**.

O segundo item está **incorreto**. O degolamento é na região posterior e o esgorjamento na região anterior ou na lateral.

O primeiro item está **correto**.

Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2022) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. À luz dessa premissa, julgue os itens a seguir.

7. Nas perícias médico e odonto-legais, o diagnóstico do instrumento causador da lesão deve observar o seguinte paradigma: é a lesão que denomina o instrumento, nunca o inverso.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Nas perícias médico e odonto-legais, a análise das características da lesão é utilizada para deduzir o tipo de instrumento ou agente causador. Por exemplo, uma lesão incisa sugere o uso de um instrumento cortante. Esta abordagem evita suposições incorretas sobre o instrumento baseadas apenas no seu tipo conhecido ou presumido, pois dependendo do uso (ação) pode gerar lesões diferentes.

Outro exemplo: uma arma de fogo pode ser usada para efetuar disparos, causando uma lesão perfuro-contusa ou pode ser usada para bater na cabeça de uma pessoa, causando uma lesão contusa através da ação contundente da arma de fogo. A observação das características da lesão permite uma classificação mais objetiva e científica do instrumento envolvido.

Gabarito: Certo.



8. Entre os instrumentos relacionados aos agentes mecânicos incluem-se os instrumentos perfurantes, os instrumentos bolhosos e os instrumentos maciços.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

De acordo com o autor Genival Veloso de França os meios mecânicos são classificados em:

- Perfurantes;
- Cortantes;
- Contudentes;
- Perfurocortantes;
- Perfurocontudentes;
- Cortocontudentes.

Não consta na literatura instrumentos bolhosos e maciços (embora entenda-se que a banca possivelmente esteja referindo-se a instrumentos contundentes como sinônimo de maciços).

Gabarito: **Errado**.

9. Na prática da medicina e da odontologia legal, são tipos de lesões (ferimentos) as puntiformes, as incisas, as contusas, as perfuroincisas, as cortocontusas, as perfurocontusas.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Isso mesmo! A partir da ação dos instrumentos abaixo descritos, podemos ter as seguintes lesões:

- Instrumentos perfurantes: lesões puntiformes (ou punctórias);
- Instrumentos cortantes: lesões incisas;
- Instrumentos contundentes: lesões contusas;
- Instrumentos perfurocortantes: lesões perfuroincisas;



- Instrumentos perfurocontundentes: lesões perfurocontusas;
- Instrumentos cortocontundentes: lesões cortocontusas.

Gabarito: Certo.

10. Instrumento cortante é todo objeto rombo capaz de agir traumáticamente sobre o organismo.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Objetos rombos são os que possuem ação contundente, causando lesões contusas. Os objetos cortantes causarão lesões incisas.

Gabarito: Errado.

11. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Sobre traumatologia forense, associe o mecanismo com o instrumento, levando-se em consideração as energias de ordem mecânica:

Mecanismo:

- I-) Pressão + Deslizamento;
- II-) Pressão + Penetração + Deslizamento;
- III-) Pressão + Linha + Esmagamento;
- IV-) Pressão + Penetração;
- V-) Pressão + Esmagamento;
- VI-) Pressão + Penetração.

Instrumento:

- () Perfurante;
- () Cortante;
- () Contundente;



- () Perfurocortante;
- () Perfurocontundente;
- () Corto-contundente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) I, VI, V, IV, II, III
- b) I, V, IV, VI, III, II
- c) VI, I, V, II, IV, III
- d) IV, V, I, III, IV, II
- e) VI, V, I, II, IV, III

Comentários:

- Instrumentos perfurantes: lesões puntiformes (ou punctórias) - mecanismo: pressão + penetração;
- Instrumentos cortantes: lesões incisas - mecanismo de pressão + deslizamento;
- Instrumentos contundentes: lesões contusas - mecanismo: pressão + esmagamento;
- Instrumentos perfurocortantes: lesões perfuroincisas - mecanismo: pressão + penetração + esmagamento;
- Instrumentos perfurocontundentes: lesões perfurocontusas - mecanismo: pressão + penetração;
- Instrumentos cortocontundentes: lesões cortocontusas - mecanismo: pressão + linha + esmagamento.

Com isso, temos o gabarito sendo a **alternativa C**.

12. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Dentre as lesões abaixo, assinale a alternativa que apresenta a lesão que tem como origem a ação tangencial de instrumentos contundentes.

- a) Rubefação
- b) Equimose
- c) Hematoma
- d) Escoriação
- e) Bossa sanguínea



Comentários:

Vamos rever cada uma das lesões:

Rubefação: A pressão libera histamina, que dá vasodilatação. Há autores que não a consideram lesão porque não há saída de sangue dos vasos. Encontram-se nas compressões e nas irritações agudas ou crônicas.

Equimose: Sufusão hemorrágica difusa que se infiltra na espessura dos tecidos, ocasionada pelo rompimento dos vasos em face de ação de instrumento contundente, cuja forma pode guardar. A transformação química da hemoglobina fora do vaso leva a mudanças cromáticas na evolução – espectro equimótico de Legrand du Saulle.

Hematoma: Lago sanguíneo, localizado, formado pelo rompimento de vasos. Além de superficial, pode ser em profundidade, em plena massa de órgãos (hematomas extradural, subdural, intramuscular), e em espaços teciduais (retroperitônio, mediastino).

Escoriação: Resulta da ação mecânica tangencial do instrumento que deixa a derme ao descoberto por arrancamento da epiderme. Não havendo secção das papilas, apenas flui serosidade, que forma crosta amarelada (melicérica) quando seca. Quando há secção das papilas, existe mistura de sangue na serosidade e a crosta que se forma ao secar é castanha ou amarronzada. Ao se destacar a crosta pode ficar uma mancha hipocrômica temporária. No cadáver, por não haver circulação, ainda que possam ocorrer escoriações, não se formarão crostas.

Bossa sanguínea: A bossa sanguínea diferencia-se do hematoma por apresentar-se sempre sobre um plano ósseo e pela sua saliência bem pronunciada na superfície cutânea. É muito comum nos traumatismos do couro cabeludo e é vulgarmente conhecida por “galo”.

Gabarito: Letra D.

13. (IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) No âmbito da traumatologia forense, distinguir se uma lesão foi produzida antes, próxima ou depois do momento da morte é fundamental para orientar a investigação criminal. Considerando as características de lesões vitais (*ante mortem*), *peri mortem* e pós-mortais (*post mortem*) que podem ser identificadas no exame cadavérico, analise as afirmativas a seguir.

- I. As lesões tanto em tecido mole quanto em tecido ósseo podem ser classificadas em *ante mortem*, *peri mortem* e *post mortem*.
- II. As lesões ósseas antemortem são aquelas em que é possível identificar a presença de coágulo aderido ao trabeculado ósseo.
- III. A presença de fragmentos ósseos aderidos ao foco da fratura é indicativa de lesão perimortem.



IV. Uma fratura em galho verde ou uma fratura com curvatura do osso indicam uma lesão postmortem.

Após análise, admite-se como correta(s)

- a) apenas a afirmativa III.
- b) apenas a afirmativa IV.
- c) apenas as afirmativas I e II.
- d) apenas as afirmativas I e IV.
- e) apenas as afirmativas III e IV.

Comentários:



Alternativa I - **Incorreta**. Apenas no tecido ósseo é possível fazer essa diferenciação. Aqui, temos uma certa polêmica, pois sabemos que as escoriações, por exemplo, se apresentam de formas distintas quando ocorrem em vida ou post mortem e são lesões em tecidos moles. Porém a banca baseou-se no livro do autor Rodrigo Camargos Couto que descreve o seguinte: *podemos classificar uma lesão óssea em ante mortem, peri mortem ou post mortem. Toda lesão diretamente relacionada com o evento morte é uma lesão peri mortem. As lesões ante mortem são anteriores e as post mortem, posteriores.*

Alternativa II - **Incorreta**. Segundo o mesmo autor: Para classificar uma lesão como ante mortem é necessário evidenciar, pelo menos, qualquer sinal de remodelação óssea. Evidências de cicatrização óssea precisam de, no mínimo, 7 dias para serem identificadas. Logo, o achado de uma lesão ante mortem indica que ela aconteceu ao menos 1 semana antes do óbito.

Alternativa III - **Correta**. De acordo com o autor: Uma fratura em galho verde ou uma fratura com curvatura do osso indicam uma lesão peri mortem, assim como a presença de fragmentos ósseos aderidos ao foco da fratura.

Alternativa IV - **Incorreta**. De acordo com o autor: Uma fratura em galho verde ou uma fratura com curvatura do osso indicam uma lesão peri mortem, assim como a presença de fragmentos ósseos aderidos ao foco da fratura.

Gabarito: Letra A.



14. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Uma mulher chegou até uma delegacia de polícia e alegou ter sido mordida no antebraço direito pelo seu vizinho, durante uma tentativa de violência sexual. Como havia uma lesão com formato oval, avermelhada e com pontos arroxeados no antebraço direito da vítima, que poderia ser uma mordedura, foi requisitado um exame pericial odontológico. Entretanto, a perícia nesta lesão só foi realizada cerca de 8 dias após a data da agressão e, pericialmente, não foi encontrada nenhuma evidência de trauma no corpo da vítima. Tendo em vista o caso hipotético descrito e os fundamentos de traumatologia forense inerentes à produção das mordeduras humanas, assinale a alternativa correta e que contém a classificação da lesão produzida no antebraço direito da vítima.

- a) Lesão perfurocortante.
- b) Lesão cortocontusa.
- c) Lesão perfurocontusa.
- d) Lesão cortante.
- e) Lesão contusa.

Comentários:

Lesões causadas por mordidas ou dentadas são lesões do tipo cortocontusa.

Gabarito: Letra B.

15. (IADES/POLITEC-GO – 2024) Na obra *Tratado de Odontologia Legal e Deontologia*, Daruge et al. (2017) explicam as características da equimose. Acerca desse sinal potencialmente detectável durante exame necroscópico, assinale a alternativa correta:

- a) Na equimose, os capilares sanguíneos são preservados, e observa-se um acúmulo anormal de líquido no meio intersticial, bem como aumento de volume.
- b) A equimose é o sinal clássico mais comumente observado a partir do exame de lesões por energias de ordem mecânica com ação perfurante.
- c) A análise do espectro equimótico (como proposto por Legrand Du Saulle) é empregada primeiramente para a aferição do instrumento que produziu a lesão.
- d) A equimose pode ser detectada em marcas de mordidas humanas, especialmente quando a mordida não supera a resistência da pele.
- e) A equimose deixada por marcas de mordidas humanas e proveniente do impacto exercido pela língua na pele impede a visualização dos arcos dentais



Comentários:

- a) **Incorreta.** De acordo com Daruge: Equimose é o extravasamento do sangue para o tecido pelo rompimento de capilares sanguíneos.
- b) **Incorreta.** De acordo com Daruge: Depreende-se que a ação contundente tem como resultante uma força maior que aquelas determinantes da rubefação e do edema traumático.
- c) **Incorreta.** Segundo Daruge: A cor da equimose (espectro equimótico) é alterada conforme a sucessão dos dias. Ou seja, emprega-se para saber o tempo e não o instrumento.
- d) **Correta.** Isso mesmo! Conforme descrito por Daruge: Quando a ação de oclusão dos dentes inferiores contra os superiores não superar a resistência da pele, ter-se-á uma ferida contusa qualificada como equimose.
- e) **Incorreta.** Daruge descreve que: A equimose produzida pela ação da mordida apresenta características específicas, podendo ser classificadas de acordo com o tipo do instrumento que a produziu, possibilitando ao perito afirmar sua origem.

16.(UFMT/POLITEC-MT – 2022) Considere o seguinte fenômeno: Deslocamento da massa encefálica móvel, chocando-se contra as paredes ou lesões vasculares provocadas pelo trauma, que levam a um derrame sanguíneo por extravasamento. Trata-se de

- a) laceração.
- b) traumatismo de crânio aberto.
- c) esmagamento.
- d) rotura Visceral.
- e) traumatismo de crânio fechado.

Comentários:

Vamos analisar cada uma das lesões, a partir da descrição de Vanrell:

- a) **Laceração (lesão lacerocontusa):** Resulta da ação mais ou menos tangencial do instrumento, que, pela força de arrasto ou de tração, acaba por provocar esgarçamentos ou dilacerações dos tecidos, gerando lesões que, por suas características gerais, podem parecer-se com as cortocontusas sem, contudo, exibirem a relativa nitidez provocada pelo impacto do gume daquelas sobre o corpo: suas bordas são irregulares em face da dilaceração. **Incorreta.**
- b) **Traumatismo de crânio aberto:** Quando o instrumento com ação contundente aplica sua energia diretamente sobre o crânio, em forma tangencial ou de maneira perpendicular, com afundamento (lesão em mapa-múndi, de Carrara). **Incorreta.**



- c) **Esmagamento:** Provocado por compressões violentas de grandes massas (desabamentos, acidentes de trânsito, com prisão entre as ferragens) ou por ondas de pressão/decompressão alternadas. **Incorreta.**
- d) **Rotura visceral:** Em geral, resulta de aumento de pressão, mais ou menos localizado, que faz explodir vísceras ocas com conteúdo líquido (bexiga, vesícula, estômago) ou dilacera vísceras maciças por tracionamento (arrancamentos, esgarçamentos) ou por penetração (perfuração, transfixação, secção). **Incorreta.**
- e) **Traumatismo de crânio fechado:** Quando a massa encefálica móvel se desloca dentro do crânio, chocando-se contra as paredes (lesões de desaceleração), ou quando o trauma provoca lesões vasculares que levam a um derrame sanguíneo, por extravasamento, como nos traumatismos cranioencefálicos (TCE) que provocam acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos (hemorragia extradural; hemorragia subdural; hemorragia intracerebral ou intracapsular). **Correta, portanto gabarito da questão!**

17.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) No que se refere à coloração das equimoses no trabalho de cronologia de uma agressão, assinale a opção correta.

- a) As equimoses, comumente, ocorrem devido à ação de instrumento cortante.
- b) O Índice de Verderau auxilia na análise das equimoses no que se refere à determinação da ocorrência de uma lesão *intravital* ou *post mortem*.
- c) As equimoses são classificadas como profundas porque se situam em tegumentos e massas musculares.
- d) A presença de equimose superficial de coloração amarelada, tendo como parâmetro o espectro equimótico de Le Grand du Saulle, sugere lesão ocorrida em, no máximo, sete dias.
- e) As equimoses profundas assumem coloração avermelhada durante toda a sua evolução.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Ocasionada pelo rompimento dos vasos em face de ação de instrumento contundente, cuja forma pode guardar.
- b) **Correta.** Segundo França: O diagnóstico diferencial entre as lesões produzidas em vida ou depois da morte possibilita a elucidação de muitas questões que possam surgir como decorrência das mais diversas modalidades de traumas, mortais ou não, proposital ou acidentalmente, em problemas que envolvem assuntos da traumatologia, sexologia, infelizmente e tanatologia. A prova de Verderau consiste em comparar a relação existente entre as hemácias e leucócitos da lesão suspeita, tomando como parâmetro esses elementos figurados do sangue de outra região qualquer do corpo. Se a relação dos glóbulos brancos e vermelhos se equivale nas duas contagens, diz-se que a lesão foi produzida após a morte. Se a primeira contagem é superior à segunda, conclui-se pelo diagnóstico de uma lesão *in vitam*.



- c) **Incorreta.** Segundo França: em geral, são superficiais, mas podem surgir nas massas musculares, nas vísceras e no periósteo. Thoinot dizia que a equimose era uma prova irrefutável de reação vital.
- d) **Incorreta.** Em geral, é vermelha no primeiro dia, violácea no segundo e no terceiro, azul do quarto ao sexto, esverdeada do sétimo ao 10º, amarelada por volta do 12º dia, desaparecendo em torno do 15º ao 20º.
- e) **Incorreta.** As equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, não permitindo que a oxihemoglobina se transforme e se decomponha. Esta se mantém de colorido vermelho até sua total reabsorção.

18.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) Diversos tipos de lesões corporais podem surgir quando das situações que envolvem a sua produção. Acerca desse tema e de assuntos correlatos, assinale a opção correta.

- a) Sugilação é uma escoriação em uma área não delineada com distribuição não confluenta.
- b) Víbices são lesões em forma de estrias.
- c) Sugilação pode ser utilizada para diferenciar lesões *intravitam* da *post mortem*, pois é característica de lesão no indivíduo vivo.
- d) Manchas equimóticas lenticulares de Tardieu são patognomônicas nas mortes violentas por asfixia.
- e) Fraturas ósseas são classificadas como lesões cortocontusas.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Sugilação é quando a equimose se apresenta em forma de pequenos grãos.
- b) **Correta.** Isso mesmo! Quando em forma de estrias, toma a denominação de víbice.
- c) **Incorreta.** Segundo França devemos considerar que para a formação de uma equimose é necessário que o indivíduo esteja vivo, permitindo assim que o fenômeno se processe e se organize por meio da homodinâmica. São necessários traumatismo, ruptura capilar, extravasamento sanguíneo, circulação ativa e sua infiltração progressiva através da pulsação continuada dos pequenos vasos nas malhas dos tecidos atingidos. Logo, a equimose só pode ser verificada em vida. A alternativa fala de sugilação.
- d) **Incorreta.** São equimoses diminutas, do tamanho da cabeça de um alfinete, localizando-se, não raro, sob a pleura visceral, mais notadamente nos sulcos interlobares e bordas dos pulmões, no pericárdio e no pericrânio, e, nas crianças, no timo. Diversas são as causas, dentre as teorias mais aceitas estão o aumento da pressão arterial pelo gás carbônico aumentado, descarga de adrenalina, lesão da parede capilar pelo acúmulo de gás carbônico no sangue, esforços respiratórios durante a asfixia. Percebemos que todas são causas de mortes por asfixia, porém nenhum autor fala de ser um sinal patognomônico.



- e) **Incorreta.** São classificadas como lesões contusas produzidas por ação contundente. Embora saibamos que ações cortocontundentes podem causar fraturas ósseas.

Questão bem chatinha né! Eventualmente temos questões assim. Mas, nada de se abalar, bora para a próxima :)

19.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) No que se refere à necessidade de conhecer diversas lesões em medicina legal, assinale a opção correta sobre o referido tema e assuntos correlatos.

- a) Sinal de Chavigny manifesta-se quando há lesões contusas sobrepostas (provocadas uma em cima da outra).
- b) Lei de Filhos e Langer é a lei aplicada em casos de lesões produzidas por instrumentos contundentes.
- c) Instrumentos como punhal e faca introduzidos em um corpo produzem lesão perfurocortante.
- d) Ferimentos produzidos por instrumentos perfurocortantes tendem, de maneira geral, a apresentar o formato do instrumento que os produziu.
- e) Degolamento caracteriza-se, em geral, por uma ferida incisa ou cortocontusa localizada na porção posterior do pescoço.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Manifesta-se quando há sobreposição de lesões incisas. Segundo França: Uma questão de suma importância é a ordem das lesões que se cruzam. Como a segunda lesão foi produzida sobre a primeira, de bordas já afastadas, coaptando-se às margens de uma das feridas, sendo ela a primeira a ser produzida, a outra não segue um trajeto em linha reta (sinal de Chavigny). Esse fato não interessa apenas ao legista, mas também ao cirurgião, no sentido de suturar as feridas pela ordem de agressão.
- b) **Incorreta.** As leis de Filhos e Langer aplicam-se às lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre.
- c) **Incorreta.** As lesões produzidas por instrumentos perfurocortantes são chamadas lesões perfuroincisas.
- d) **Incorreta.** As lesões por assinatura são produzidas por instrumentos contundentes.
- e) **Correta.** Isso mesmo! Lesão observada na **face posterior do pescoço**.

20.(VUNESP/PC-SP – 2022) No entendimento dos conceitos da traumatologia forense, assinale a alternativa correta.

- a) A equimose ocorre por ruptura de vasos calibrosos, resultando em coleção sanguínea, após ação por compressão, tração ou sucção.



- b) As feridas contusas são lesões determinadas por um agente capaz de vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles. Há pouco sangramento, e integridade de vasos, nervos e tendões no fundo.
- c) Na escoriação, a ação tangencial contundente promove avulsão da epiderme e derme reticular.
- d) O entorse é a lesão resultante do deslocamento de dois ossos cujas superfícies de articulação deixam de manter as relações de contato que lhes são comuns.
- e) As fraturas são determinadas por mecanismos de compressão, flexão ou torção incidindo diretamente na região da lesão.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Equimose é uma sufusão hemorrágica difusa que se infiltra na espessura dos tecidos, ocasionada pelo rompimento dos vasos de pequeno calibre em face de ação de instrumento contundente, cuja forma pode guardar.
- b) **Correta.** As feridas contusas são lesões abertas em que a ação contundente chegou ao ponto de ultrapassar a resistência e elasticidade dos tecidos moles, portanto, com solução de continuidade com planos subjacentes, havendo até rompimento de vasos sanguíneos. Há integridade dos vasos, nervos e tendões no fundo da lesão.
- c) **Incorreta.** Resulta da ação mecânica tangencial do instrumento que deixa a derme ao descoberto por arrancamento da epiderme.
- d) **Incorreta.** A entorse acontece quando se ultrapassa a amplitude normal dos movimentos articulares, geralmente em decorrência de forças externas, causando o estiramento da cápsula de uma articulação. A descrição da alternativa refere-se a luxação.
- e) **Incorreta.** Fratura é nada mais nada menos que a solução de continuidade óssea (quebra do osso), sendo geralmente relacionada aos mecanismos de compressão, flexão ou torção. Para que ocorram não há necessidade dos mecanismos ocorrerem exatamente na região da lesão, pois são chamadas de diretas, quando se verificam no próprio local do traumatismo, e indiretas, quando provêm de violência em uma região mais ou menos distante do local fraturado.

21. (VUNESP/PC-SP – 2022) Uma mulher foi encontrada em sua casa, com grande quantidade de lesões semelhantes localizadas no tórax, abdômen, coxas, antebraços e mãos. Um furador de gelo foi encontrado no local do crime. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Os instrumentos com ação semelhante à do furador de gelo atuam por secção das fibras do tecido por deslizamento, sendo a extensão maior que a profundidade das lesões.
- b) As lesões têm profundidade menor ou igual ao comprimento da haste do instrumento, independente mente da região atingida.



- c) As lesões apresentam direções no mesmo sentido nos pontos de encontro de linhas de força da pele.
- d) Sendo o furador de gelo de médio calibre, as soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumento perfurocortante de dois gumes.
- e) As feridas produzidas por instrumentos perfurantes se apresentam na superfície externa, em geral, com diâmetro maior do que a do instrumento causador, por conta da retração dos tecidos.

Comentários:

A questão refere-se às lesões causadas por instrumentos perfurantes de médio calibre e, portanto, seguem a Lei de Filhos e Langer.

- a) **Incorreta.** Os instrumentos que atuam por secção são os cortantes.
- b) **Incorreta.** Segundo França: O trajeto dependerá, no que diz respeito à sua profundidade, do tamanho do instrumento ou da pressão utilizada pelo agressor. No entanto, não se pode estabelecer o comprimento do meio perfurante pela profundidade de penetração. Além de nem sempre penetrar em toda a sua extensão, pode ainda variar essa profundidade com a posição da vítima. Pode acontecer de a profundidade de penetração ser maior que o próprio comprimento da arma quando esta, por exemplo, atinge uma região onde haja depressibilidade dos tecidos superficiais, como no ventre. Lacassagne chamou essas lesões de "feridas em acordeão".
- c) **Incorreta.** **2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo):** quando as feridas se localizam na mesma região do corpo que possua as linhas de força dispostas em uma só direção, seu maior eixo tem sempre a mesma direção. **Lei de Langer (Lei do Polimorfismo ou da Elasticidade):** Nas regiões em que ocorre cruzamento (convergência ou confluência) de fibras de sentidos diferentes, as extremidades da lesão assumem um aspecto de ponta de seta, de triângulo ou até de quadrilátero.
- d) **Correta.** **1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança):** as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão". **Portanto, a alternativa D está correta.**
- e) **Incorreta.** De acordo com França: As lesões puntiformes têm como características a abertura estreita; são de raro sangramento, de pouca nocividade na superfície e, às vezes, de certa gravidade na profundidade, em face desse ou daquele órgão atingido; e, por fim, quase sempre de menor diâmetro que o do instrumento causador, graças à elasticidade e à retratibilidade dos tecidos cutâneos.



22. (VUNESP/PC-SP – 2022) Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, assinale a alternativa correta.

- a) Os pigmentos residuais são degradados pela atividade citotóxica dos neutrófilos.
- b) A sucessão das diversas tonalidades do espectro tem como explicação a transformação da oxihemoglobina em metahemoglobina extravasados nos tecidos.
- c) As equimoses profundas mais habituais são observadas na forma de petéquias, vistas por transparência nas superfícies serosas das vísceras (sinal de tardieu).
- d) Em certas situações, a equimose é obscurecida pelos livores hipostáticos e não pode ser deste diferenciada.
- e) A sequência de tons sucessivos é vermelha – azul – violácea – esverdeada – acastanhada e amarelada, sendo esses os valores cronológicos relativos à quantidade e à profundidade do sangue extravasado e à elasticidade do tecido envolvido.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Segundo França: A absorção dos pigmentos verifica-se por atividade fagocitária. Esse dado é importante à perícia, pois algum tempo mais tarde pode esse pigmento ser encontrado na rede ganglionar da região atingida, mesmo após o desaparecimento da equimose (sinal de Kunckel).
- b) **Incorreta.** De acordo com França: A sucessão das diversas tonalidades tem como explicação a transformação da hemoglobina extravasada das hemácias em hematina e globina. A primeira vai-se reduzindo aos seus produtos finais de decomposição – a hematóidina e a hemossiderina.
- c) **Correta.** Isso mesmo! São equimoses diminutas, do tamanho da cabeça de um alfinete, localizando-se, não raro, sob a pleura visceral, mais notadamente nos sulcos interlobares e bordas dos pulmões, no pericárdio e no pericrânio, e, nas crianças, no timo.
- d) **Incorreta.** França descreve que o diagnóstico diferencial da equimose deve ser feito com o livor hipostático. A equimose apresenta sangue coagulado, presença de malhas de fibrina, infiltração hemorrágica, presença em qualquer lugar do corpo, sangue fora dos vasos, rupturas de vasos e mais particularmente de capilares, sinais de transformação de hemoglobina e ausência de meta-hemoglobina. O livor hipostático mostra sangue não coagulado, ausência de malhas de fibrina, ausência de infiltração hemorrágica, presença em locais específicos – é visível nas zonas de decúbito –, integridade de vasos capilares, sangue dentro dos vasos, ausência de transformação hemoglobínica, presença de meta-hemoglobina neutra e sulfídrica vista através da espectroscopia.
- e) **Incorreta.** Em geral, é vermelha no primeiro dia, violácea no segundo e no terceiro, azul do quarto ao sexto, esverdeada do sétimo ao 10º, amarelada por volta do 12º dia, desaparecendo em torno do 15º ao 20º.



23.(VUNESP/PC-SP – 2022) No que se refere às lesões causadas pela ação contundente, é correto afirmar que

- a) o hemotórax e o hemopericárdio são hematomas intracavitários.
- b) passado o período de expressão macroscópica da rubefação, o seu diagnóstico será feito pela avaliação histológica.
- c) a equimose expressa na forma de pequenos grãos recebe o nome de víbice, e a expressa na forma de estrias toma a denominação de sugilação.
- d) as equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, levando à rápida decomposição da oxihemoglobina.
- e) rastros escoriativos ungueais são irrelevantes para a inferência de lesões de defesa.

Comentários:

- a) **Correta.** Hemotórax é um acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica. Hemopericárdio é a acumulação de sangue dentro do pericárdio, membrana que envolve a parte externa do coração. Ambos localizados dentro de uma cavidade: a cavidade torácica, portanto intracavitários.
- b) **Incorreta.** A rubefação pode ou não ser considerada uma lesão para configurar o crime. Porém, no olhar da Medicina Legal, consiste na lesão mais simples e fugaz da categoria contusa, desaparecendo em alguns minutos ou horas. Quando um instrumento contundente atua, a pressão no local promove a liberação de histamina que, por sua vez, promove a vasodilatação, consequentemente, ocorre hiperemia e vermelhidão (rubor) local, produzindo a rubefação.
- c) **Incorreta.** Quando em forma de estrias, toma a denominação de víbice. Sugilação é quando a equimose se apresenta em forma de pequenos grãos.
- d) **Incorreta.** As equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, não permitindo que a oxihemoglobina se transforme e se decomponha. Esta se mantém de colorido vermelho até sua total reabsorção
- e) **Incorreta.** São os principais indícios de que houve uma tentativa de defesa por parte da vítima.

24.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Na análise de um cadáver no IML, o odontologista verificou duas lesões na face, uma com característica de “casa de botão” e outra apresentando uma “cauda de escoriação”. No laudo pericial, o que o odontologista provavelmente descreveu, respectivamente, quanto às ações que produziram tais lesões?



- a) Perfurocortante e perfurante.
- b) Perfurante e perfurocontundente.
- c) Cortante e perfurocortante.
- d) Perfurante e cortante.
- e) Perfurocontundente e cortante.

Comentários:

As lesões que apresentam as características de “casa de botão” são as causadas por instrumentos perfurantes de calibre médio. Já as lesões que apresentam “cauda de escoriação” são causadas pelos instrumentos de ação cortante.

Gabarito: Letra D

25. (IDECAN/PEFOCE – 2021) Em relação ao espectro equimótico de Legrand du Saulle, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) No primeiro dia, a alteração cromática se dá para o vermelho.
- b) Após o vigésimo dia, desaparece a alteração cromática.
- c) A equimose fica amarelada por volta do quinto dia.
- d) Perto do décimo dia, a alteração cromática se dá ao esverdeado.
- e) No quinto dia, a equimose se apresenta azul.

Comentários:

Lembrando que de acordo com o espectro equimótico de Legrand du Saulle, em geral, a equimose é vermelha no primeiro dia, violácea no segundo e no terceiro, azul do quarto ao sexto, esverdeada do sétimo ao 10º, amarelada por volta do 12º dia, desaparecendo em torno do 15º ao 20º.

Portanto, **gabarito é a letra C**. Observe que a questão pede a alternativa incorreta.

26. (IADES/POLITEC-GO – 2024) A importância do estudo de lesões produzidas por instrumentos contundentes reside no fato de que boa parte dos exames realizados nos institutos médico legais decorre desse tipo de violência. A respeito das lesões produzidas por instrumento contundente, assinale a alternativa correta:



- a) Uma das características mais marcantes das escoriações é que elas produzem cicatrizes hiperocrômicas.
- b) O sinal em terraça de Hoffman é caracterizado por um afundamento parcial e uniforme com inúmeras fissuras, em forma de arcos e meridianos, produzido por instrumento contundente ao atingir a calota craniana.
- c) A fratura em saca-noz é atribuída à precipitação com queda sobre a parte inferior do corpo.
- d) A fratura circular na base do crânio ocorre tipicamente em precipitações quando o corpo é impactado pela cabeça.
- e) O impacto direto de instrumentos de formato cilíndrico causa uma infiltração hemorrágica que margeia a linha de impacto, produzindo duas equimoses alongadas e paralelas, também chamadas víbices.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Nas escoriações, quando há secção das papilas, existe mistura de sangue na serosidade e a crosta que se forma ao secar é castanha ou amarronzada. Ao se destacar a crosta pode ficar uma mancha hipocrômica temporária.
- b) **Incorreta.** Quando o traumatismo se verifica tangencialmente e produz uma fratura de forma triangular com a base aderida à porção óssea vizinha e com o vértice solto e dirigido para dentro da cavidade craniana chama-se de sinal de terraça de Hoffman, já o afundamento parcial e uniforme com inúmeras fissuras, em forma de arcos e meridianos é denominado sinal do mapa-múndi de Carrara.
- c) **Incorreta.** Segundo França: Quando o corpo é impactado pela sua extremidade superior, ou seja, quando a cabeça choca-se com o solo, encontra-se geralmente um tipo de fratura chamado em “saco de noz”, caracterizada pela integridade ou quase integridade do couro cabeludo e de múltiplas fraturas da calvária, laceração da massa encefálica e herniamento do cérebro. Podem ocorrer também fraturas vertebrais e rupturas de vísceras maciças pela contusão e hiperflexão do corpo.
- d) **Incorreta.** A fratura circular ocorre por queda em que o indivíduo cai em pé, ajoelhado ou sentado, pelo impacto da coluna vertebral sobre o crânio.
- e) **Correta.** Quando a equimose é produzida por objetos cilíndricos, como bastões, cassetetes, bengalas, deixa, em vez de uma marca, duas equimoses longas e paralelas, conhecidas por víbices, em virtude de o extravasamento do sangue verificar-se ao lado do traumatismo e não na sua linha de impacto.

27. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Seguindo a classificação dos ferimentos provocados por energias mecânicas, assinale a alternativa que apresenta a correlação entre lesão e instrumento.



- a) Lesão contundente – Instrumento contuso
- b) Lesão punctória – Instrumento cortante
- c) Lesão perfurocontusa – Instrumento perfurocontundente
- d) Lesão cortante – Instrumento perfurante
- e) Lesão corto-contundente - Instrumento cortocontuso

Comentários:

- Instrumentos perfurantes: lesões puntiformes (ou punctórias);
- Instrumentos cortantes: lesões incisas;
- Instrumentos contundentes: lesões contusas;
- Instrumentos perfurocortantes: lesões perfuroincisas;
- Instrumentos perfurocontundentes: lesões perfurocontusas;
- Instrumentos cortocontundentes: lesões cortocontusas.

Atenção para não confundir instrumento com lesão.

Gabarito: Letra C.

28.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Assinale a alternativa correta sobre as características das lesões produzidas por ação cortante.

- a) Ação através de um gume por um mecanismo de pressão vertical sobre os tecidos
- b) Ação através de uma lâmina por um mecanismo de deslizamento sobre os tecidos
- c) Ação através de uma ponta pressionada sobre os tecidos
- d) Ação através de percussão de uma lâmina com afastamento das fibras dos tecidos
- e) Ação através de uma ponta romba, deslizando sobre os tecidos

Comentários:

Os instrumentos cortantes agem por ação de pressão + deslizamento.



Portanto, gabarito é a letra B.

29.(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento perfurocortante e produz uma lesão perfuroincisa.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Isso mesmo! As lesões perfuroincisas são provocadas por instrumentos com ponta e gume que atuam pela perfuração e cortam pela ação de deslizamento de sua(s) borda(s) afiada(s).

Gabarito: Certo.

30.(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, as soluções de continuidade das lesões, conforme a Primeira Lei de Filhos (Edouard Filhos), assemelham-se às produzidas por instrumento de dois gumes ou têm a aparência de casa de botão.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Isso mesmo! **1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança):** as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão".

Gabarito: Certo.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FGV/PC-AM – 2022) Lesões produzidas por meio de lâminas têm bordas regulares e podem ter profundidade significativa dependendo da massa do objeto.

Assinale a afirmativa correta sobre feridas corto-contusas encontradas no pescoço por um perito na cena de crime.

- a) Chama-se degola quando o ferimento é anterior.
- b) Quando o ferimento é em região posterior do pescoço, chama-se esgorjamento.
- c) Degola corresponde a decapitação.
- d) Chama-se degola quando o ferimento é lateral.
- e) Esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço.

2. (FGV/PC-AM – 2022) No estudo das energias de ordem mecânica, a classificação médico-legal dos agentes pressupõe, invariavelmente, como primeira etapa, a análise da lesão para sua denominação. A literatura científica referencia que os arcos dentários humanos podem produzir vários tipos de feridas. Segundo Arbenz (1988) a dinâmica da mordida é habitualmente classificada como instrumento do tipo

- a) perfurante.
- b) contundente.
- c) corto-contundente.
- d) cortante.
- e) perfuro-contundente.

3. (FGV/PC-AM – 2022) Entre as lesões contusas superficiais causadas por ação física mecânica, temos a equimose. Na sufusão ocorre a transformação química da hemoglobina fora do vaso determinando a mudança cromática no tecido traumatizado.

Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, indique a sequência de cores no processo evolutivo dessa lesão.

- a) Vermelho-violáceo, avermelhado, azulado, esverdeado e amarelado.



- b) Avermelhado, azulado, vermelho-violáceo, esverdeado e amarelado.
- c) Avermelhado, azulado, esverdeado, vermelho-violáceo e amarelado.
- d) Avermelhado, vermelho-violáceo, azulado, esverdeado e amarelado.
- e) Vermelho-violáceo, avermelhado, esverdeado, azulado e amarelado.

4. (VUNESP/PC-RR – 2022) Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, a forma das lesões assume um aspecto diferente. Na confluência de regiões de linhas de força diferentes, a extremidade da lesão toma um aspecto triangular de ponta de seta obedecendo:

- a) 1a Lei de Filhos.
- b) 2a Lei de Filhos.
- c) Lei de Langer.
- d) Lei da Gravidade.
- e) Lei de Benassi.

5. (VUNESP/PC-RR – 2022) São lesões provocadas, em geral, por pressão, compressão, distensão, torção e se constituem em danos muito comuns nas perícias médicas e odontológicas. Essas lesões são produzidas por agentes ou instrumentos denominados

- a) perfurantes.
- b) contundentes.
- c) cortantes.
- d) perfuro-cortantes.
- e) punctatos.

6. (FGV/POLITEC-AP – 2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

() *Blast Injury* é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica, lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.



() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou antero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) F, V e V.
- b) V, F e F.
- c) F, F e F.
- d) V, F e V.
- e) V, V e V.

(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2022) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. À luz dessa premissa, julgue os itens a seguir.

7. Nas perícias médico e odonto-legais, o diagnóstico do instrumento causador da lesão deve observar o seguinte paradigma: é a lesão que denomina o instrumento, nunca o inverso.

- (C) Certo
- (E) Errado

8. Entre os instrumentos relacionados aos agentes mecânicos incluem-se os instrumentos perfurantes, os instrumentos bolhosos e os instrumentos maciços.

- (C) Certo
- (E) Errado

9. Na prática da medicina e da odontologia legal, são tipos de lesões (ferimentos) as puntiformes, as incisas, as contusas, as perfuroincisas, as cortocontusas, as perfurocontusas.



(C) Certo

(E) Errado

10. Instrumento cortante é todo objeto rombo capaz de agir traumáticamente sobre o organismo.

(C) Certo

(E) Errado

11. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Sobre traumatologia forense, associe o mecanismo com o instrumento, levando-se em consideração as energias de ordem mecânica:

Mecanismo:

I-) Pressão + Deslizamento;

II-) Pressão + Penetração + Deslizamento;

III-) Pressão + Linha + Esmagamento;

IV-) Pressão + Penetração;

V-) Pressão + Esmagamento;

VI-) Pressão + Penetração.

Instrumento:

() Perfurante;

() Cortante;

() Contundente;

() Perfurocortante;

() Perfurocontundente;

() Corto-contundente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

a) I, VI, V, IV, II, III

b) I, V, IV, VI, III, II

c) VI, I, V, II, IV, III



- d) IV, V, I, III, IV, II
- e) VI, V, I, II, IV, III

12. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Dentre as lesões abaixo, assinale a alternativa que apresenta a lesão que tem como origem a ação tangencial de instrumentos contundentes.

- a) Rubefação
- b) Equimose
- c) Hematoma
- d) Escoriação
- e) Bossa sanguínea

13. (IDECAN/POLÍCIA CIENTÍFICA-SE – 2023) No âmbito da traumatologia forense, distinguir se uma lesão foi produzida antes, próxima ou depois do momento da morte é fundamental para orientar a investigação criminal. Considerando as características de lesões vitais (*ante mortem*), *peri mortem* e pós-mortais (*post mortem*) que podem ser identificadas no exame cadavérico, analise as afirmativas a seguir.

I. As lesões tanto em tecido mole quanto em tecido ósseo podem ser classificadas em *ante mortem*, *peri mortem* e *post mortem*.

II. As lesões ósseas antemortem são aquelas em que é possível identificar a presença de coágulo aderido ao trabeculado ósseo.

III. A presença de fragmentos ósseos aderidos ao foco da fratura é indicativa de lesão perimortem.

IV. Uma fratura em galho verde ou uma fratura com curvatura do osso indicam uma lesão postmortem.

Após análise, admite-se como correta(s)

- a) apenas a afirmativa III.
- b) apenas a afirmativa IV.
- c) apenas as afirmativas I e II.
- d) apenas as afirmativas I e IV.
- e) apenas as afirmativas III e IV.



14. (IDECAN/POLITEC-BA – 2022) Uma mulher chegou até uma delegacia de polícia e alegou ter sido mordida no antebraço direito pelo seu vizinho, durante uma tentativa de violência sexual. Como havia uma lesão com formato oval, avermelhada e com pontos arroxeados no antebraço direito da vítima, que poderia ser uma mordedura, foi requisitado um exame pericial odontológico. Entretanto, a perícia nesta lesão só foi realizada cerca de 8 dias após a data da agressão e, pericialmente, não foi encontrada nenhuma evidência de trauma no corpo da vítima. Tendo em vista o caso hipotético descrito e os fundamentos de traumatologia forense inerentes à produção das mordeduras humanas, assinale a alternativa correta e que contém a classificação da lesão produzida no antebraço direito da vítima.

- a) Lesão perfurocortante.
- b) Lesão cortocontusa.
- c) Lesão perfurocontusa.
- d) Lesão cortante.
- e) Lesão contusa.

15. (IADES/POLITEC-GO – 2024) Na obra *Tratado de Odontologia Legal e Deontologia*, Daruge et al. (2017) explicam as características da equimose. Acerca desse sinal potencialmente detectável durante exame necroscópico, assinale a alternativa correta:

- a) Na equimose, os capilares sanguíneos são preservados, e observa-se um acúmulo anormal de líquido no meio intersticial, bem como aumento de volume.
- b) A equimose é o sinal clássico mais comumente observado a partir do exame de lesões por energias de ordem mecânica com ação perfurante.
- c) A análise do espectro equimótico (como proposto por Legrand Du Saulle) é empregada primeiramente para a aferição do instrumento que produziu a lesão.
- d) A equimose pode ser detectada em marcas de mordidas humanas, especialmente quando a mordida não supera a resistência da pele.
- e) A equimose deixada por marcas de mordidas humanas e proveniente do impacto exercido pela língua na pele impede a visualização dos arcos dentais

16. (UFMT/POLITEC-MT – 2022) Considere o seguinte fenômeno: Deslocamento da massa encefálica móvel, chocando-se contra as paredes ou lesões vasculares provocadas pelo trauma, que levam a um derrame sanguíneo por extravasamento. Trata-se de

- a) laceração.



- b) traumatismo de crânio aberto.
- c) esmagamento.
- d) rotura Visceral.
- e) traumatismo de crânio fechado.

17.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) No que se refere à coloração das equimoses no trabalho de cronologia de uma agressão, assinale a opção correta.

- a) As equimoses, comumente, ocorrem devido à ação de instrumento cortante.
- b) O Índice de Verderau auxilia na análise das equimoses no que se refere à determinação da ocorrência de uma lesão *intravitam* ou *post mortem*.
- c) As equimoses são classificadas como profundas porque se situam em tegumentos e massas musculares.
- d) A presença de equimose superficial de coloração amarelada, tendo como parâmetro o espectro equimótico de Le Grand du Saulle, sugere lesão ocorrida em, no máximo, sete dias.
- e) As equimoses profundas assumem coloração avermelhada durante toda a sua evolução.

18.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) Diversos tipos de lesões corporais podem surgir quando das situações que envolvem a sua produção. Acerca desse tema e de assuntos correlatos, assinale a opção correta.

- a) Sugilação é uma escoriação em uma área não delimitada com distribuição não confluenta.
- b) Víbices são lesões em forma de estrias.
- c) Sugilação pode ser utilizada para diferenciar lesões *intravitam* da *post mortem*, pois é característica de lesão no indivíduo vivo.
- d) Manchas equimóticas lenticulares de Tardieu são patognomônicas nas mortes violentas por asfixia.
- e) Fraturas ósseas são classificadas como lesões cortocontusas.

19.(CEBRASPE/PC-RO – 2022) No que se refere à necessidade de conhecer diversas lesões em medicina legal, assinale a opção correta sobre o referido tema e assuntos correlatos.

- a) Sinal de Chavigny manifesta-se quando há lesões contusas sobrepostas (provocadas uma em cima da outra).
- b) Lei de Filhos e Langer é a lei aplicada em casos de lesões produzidas por instrumentos contundentes.
- c) Instrumentos como punhal e faca introduzidos em um corpo produzem lesão perfurocortante.



- d) Ferimentos produzidos por instrumentos perfurocortantes tendem, de maneira geral, a apresentar o formato do instrumento que os produziu.
- e) Degolamento caracteriza-se, em geral, por uma ferida incisa ou cortocontusa localizada na porção posterior do pescoço.

20. (VUNESP/PC-SP – 2022) No entendimento dos conceitos da traumatologia forense, assinale a alternativa correta.

- a) A equimose ocorre por ruptura de vasos calibrosos, resultando em coleção sanguínea, após ação por compressão, tração ou sucção.
- b) As feridas contusas são lesões determinadas por um agente capaz de vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles. Há pouco sangramento, e integridade de vasos, nervos e tendões no fundo.
- c) Na escoriação, a ação tangencial contundente promove avulsão da epiderme e derme reticular.
- d) O entorse é a lesão resultante do deslocamento de dois ossos cujas superfícies de articulação deixam de manter as relações de contato que lhes são comuns.
- e) As fraturas são determinadas por mecanismos de compressão, flexão ou torção incidindo diretamente na região da lesão.

21. (VUNESP/PC-SP – 2022) Uma mulher foi encontrada em sua casa, com grande quantidade de lesões semelhantes localizadas no tórax, abdômen, coxas, antebraços e mãos. Um furador de gelo foi encontrado no local do crime. Com referência a essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Os instrumentos com ação semelhante à do furador de gelo atuam por secção das fibras do tecido por deslizamento, sendo a extensão maior que a profundidade das lesões.
- b) As lesões têm profundidade menor ou igual ao comprimento da haste do instrumento, independente mente da região atingida.
- c) As lesões apresentam direções no mesmo sentido nos pontos de encontro de linhas de força da pele.
- d) Sendo o furador de gelo de médio calibre, as soluções de continuidade dessas feridas assemelham-se às produzidas por instrumento perfurocortante de dois gumes.
- e) As feridas produzidas por instrumentos perfurantes se apresentam na superfície externa, em geral, com diâmetro maior do que a do instrumento causador, por conta da retração dos tecidos.

22. (VUNESP/PC-SP – 2022) Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, assinale a alternativa correta.



- a) Os pigmentos residuais são degradados pela atividade citotóxica dos neutrófilos.
- b) A sucessão das diversas tonalidades do espectro tem como explicação a transformação da oxihemoglobina em metahemoglobina extravasados nos tecidos.
- c) As equimoses profundas mais habituais são observadas na forma de petéquias, vistas por transparência nas superfícies serosas das vísceras (sinal de Tardieu).
- d) Em certas situações, a equimose é obscurecida pelos livores hipostáticos e não pode ser deste diferenciada.
- e) A sequência de tons sucessivos é vermelha – azul – violácea – esverdeada – acastanhada e amarelada, sendo esses os valores cronológicos relativos à quantidade e à profundidade do sangue extravasado e à elasticidade do tecido envolvido.

23.(VUNESP/PC-SP – 2022) No que se refere às lesões causadas pela ação contundente, é correto afirmar que

- a) o hemotórax e o hemopericárdio são hematomas intracavitários.
- b) passado o período de expressão macroscópica da rubefação, o seu diagnóstico será feito pela avaliação histológica.
- c) a equimose expressa na forma de pequenos grãos recebe o nome de víbice, e a expressa na forma de estrias toma a denominação de sugilação.
- d) as equimoses da conjuntiva ocular não sofrem a sucessão de tonalidades em virtude de ser a conjuntiva muito porosa e de oxigenação fácil, levando à rápida decomposição da oxi-hemoglobina.
- e) rastros escoriativos ungueais são irrelevantes para a inferência de lesões de defesa.

24.(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Na análise de um cadáver no IML, o odontologista verificou duas lesões na face, uma com característica de “casa de botão” e outra apresentando uma “cauda de escoriação”. No laudo pericial, o que o odontologista provavelmente descreveu, respectivamente, quanto às ações que produziram tais lesões?

- a) Perfurocortante e perfurante.
- b) Perfurante e perfurocontundente.
- c) Cortante e perfurocortante.
- d) Perfurante e cortante.
- e) Perfurocontundente e cortante.



25. (IDECAN/PEFOCE – 2021) Em relação ao espectro equimótico de Legrand du Saulle, assinale a afirmativa INCORRETA.

- a) No primeiro dia, a alteração cromática se dá para o vermelho.
- b) Após o vigésimo dia, desaparece a alteração cromática.
- c) A equimose fica amarelada por volta do quinto dia.
- d) Perto do décimo dia, a alteração cromática se dá ao esverdeado.
- e) No quinto dia, a equimose se apresenta azul.

26. (IADES/POLITEC-GO – 2024) A importância do estudo de lesões produzidas por instrumentos contundentes reside no fato de que boa parte dos exames realizados nos institutos médico legais decorre desse tipo de violência. A respeito das lesões produzidas por instrumento contundente, assinale a alternativa correta:

- a) Uma das características mais marcantes das escoriações é que elas produzem cicatrizes hiperocrômicas.
- b) O sinal em terraza de Hoffman é caracterizado por um afundamento parcial e uniforme com inúmeras fissuras, em forma de arcos e meridianos, produzido por instrumento contundente ao atingir a calota craniana.
- c) A fratura em saca-noz é atribuída à precipitação com queda sobre a parte inferior do corpo.
- d) A fratura circular na base do crânio ocorre tipicamente em precipitações quando o corpo é impactado pela cabeça.
- e) O impacto direto de instrumentos de formato cilíndrico causa uma infiltração hemorrágica que margeia a linha de impacto, produzindo duas equimoses alongadas e paralelas, também chamadas víbices.

27. (IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Seguindo a classificação dos ferimentos provocados por energias mecânicas, assinale a alternativa que apresenta a correlação entre lesão e instrumento.

- a) Lesão contundente – Instrumento contuso
- b) Lesão punctória – Instrumento cortante
- c) Lesão perfurocontusa – Instrumento perfurocontundente
- d) Lesão cortante – Instrumento perfurante
- e) Lesão corto-contundente - Instrumento cortocontuso



28.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Assinale a alternativa correta sobre as características das lesões produzidas por ação cortante.

- a) Ação através de um gume por um mecanismo de pressão vertical sobre os tecidos
- b) Ação através de uma lâmina por um mecanismo de deslizamento sobre os tecidos
- c) Ação através de uma ponta pressionada sobre os tecidos
- d) Ação através de percussão de uma lâmina com afastamento das fibras dos tecidos
- e) Ação através de uma ponta romba, deslizando sobre os tecidos

29.(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento perfurocortante e produz uma lesão perfuroincisa.

(C) Certo

(E) Errado

30.(CEBRASPE/POLITEC-AL – 2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, as soluções de continuidade das lesões, conforme a Primeira Lei de Filhos (Edouard Filhos), assemelham-se às produzidas por instrumento de dois gumes ou têm a aparência de casa de botão.

(C) Certo

(E) Errado



GABARITO



GABARITO

1 - E	11 - C	21 - D
2 - C	12 - D	22 - C
3 - D	13 - A	23 - A
4 - C	14 - B	24 - D
5 - B	15 - D	25 - C
6 - D	16 - E	26 - E
7 - CERTO	17 - B	27 - C
8 - ERRADO	18 - B	28 - B
9 - CERTO	19 - E	29 - CERTO
10 - ERRADO	20 - B	30 - CERTO



RESUMO

Traumatologia Forense: É um ramo da Medicina Legal que estuda as lesões causadas por diferentes tipos de energias e instrumentos no corpo humano. Analisa o diagnóstico, prognóstico e as implicações legais das lesões corporais.

Lesonologia: Outro termo utilizado como sinônimo de Traumatologia Forense.

Conceitos-chave:

Trauma: Energia externa que provoca desvio da normalidade no organismo.

Traumatismo: Estado causado pela lesão ou ferimento.

Lesão: Alteração estrutural ou funcional no corpo devido a uma agressão.

Ferida: Lesão em que há interrupção na continuidade dos tecidos corporais.

Classificação das Energias Lesivas (Classificação de Borri)

As energias capazes de causar lesões no corpo são classificadas como:

Mecânica (Cinética): Energia transferida por impacto ou movimento, como em quedas ou batidas.

Física: Energia térmica, elétrica, radioativa, pressão, luz, som.

Química: Substâncias que reagem com o corpo e causam danos.

Mista: Combinação de diferentes formas de energia.

Energia Mecânica e Tipos de Instrumentos Lesivos

O estudo foca principalmente nos instrumentos que causam lesões por meio da energia mecânica, que é a mais comum em casos de traumatismos:

Instrumentos Perfurantes: Transferem energia cinética por meio de uma ponta fina, afastando os tecidos (ex.: agulha, espinho). As lesões causadas são chamadas de lesões punctórias.



Instrumentos Cortantes: Agem através do deslizamento de um gume sobre a superfície da pele, causando lesões incisais (ex.: faca, navalha). Essas lesões são fusiformes e produzem sangramento abundante.

Instrumentos Contundentes: Causam impacto por pressão ou choque, podendo provocar contusões, equimoses, hematomas, e fraturas (ex.: pedra, bastão).

Instrumentos Mistos - combinam dois tipos de ação:

Perfurocortantes: Atuam por pressão e deslizamento, como facas e punhais, causando lesões perfuroincisais.

Cortocontundentes: Atuam cortando e contundindo simultaneamente (ex.: machado, foice).

Perfurocontundentes: Atuam perfurando e contundindo (ex.: chave de fenda).

Características das Lesões por Tipos de Instrumentos

Lesões Perfurantes: São causadas por objetos pontiagudos e têm profundidade maior que sua extensão. A gravidade depende da profundidade e da região afetada.

Lesões Incisais: Resultantes de objetos com gume afiado. Apresentam bordas regulares e sangramento intenso, com comprimento maior que a profundidade.

Lesões Contusas: Causadas por impacto. Podem ser fechadas, como equimoses e hematomas, ou abertas, como fraturas expostas e lacerações.

Lesões Perfuroincisais: Apresentam características de lesões cortantes e perfurantes, com bordas regulares e profundidade prevalecendo sobre a extensão. O formato varia de acordo com o número de gumes do instrumento.

Mecanismos de Ação dos Instrumentos Lesivos

Os agentes lesivos podem atuar de diferentes formas:

Pressão: Instrumentos que aplicam força sobre uma superfície.

Percussão: Impacto direto de um objeto sobre o corpo.

Deslizamento: Corte causado pelo movimento de um gume.

Torção: Movimentos que torcem o corpo ou uma parte dele.



Exemplos de Lesões Especiais

Decapitação: Separação completa da cabeça do corpo, associada a crimes homicidas ou acidentes graves.

Esgorjamento: Lesão na garganta ou pescoço, comum em homicídios e suicídios, causando a interrupção dos grandes vasos e asfixia.

Fraturas: Soluções de continuidade óssea causadas por mecanismos de compressão ou impacto.



QUESTÕES EXTRAS - COMENTADAS

1. 4002238070 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

As feridas incisas tendem a apresentar bordas regulares, ausência de pontes de tecido no fundo da lesão e maior extensão no plano horizontal que na profundidade, sendo frequente a presença de lesões de defesa em membros superiores, quando associadas a homicídio.

() Certo

() Errado

Gabarito: Correta.

Comentário: As feridas incisas são produzidas por instrumentos cortantes que agem por deslizamento com leve pressão, e suas características são bordas regulares, lisas e afastadas, fundo limpo e sem pontes de tecido (isso é importante, porque as pontes de tecido no fundo são características das feridas contusas, e a banca adora essa distinção). O comprimento da lesão prevalece sobre a profundidade, que por sua vez é maior no centro da ferida. As lesões de defesa em membros superiores nos casos de homicídio são esperadas na face ulnar dos antebraços e nas palmas das mãos, indicando que a vítima tentou se proteger do instrumento.

2. 4002238069 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

Lesões do tipo contragolpe observadas em traumatismos cranianos apresentam-se obrigatoriamente no mesmo lado que sofreu o impacto direto, sendo indicativas de trauma contuso com fratura óssea subjacente.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado



Comentário: O contragolpe é o tipo de lesão que ocorre no lado oposto ao ponto de impacto. Isso acontece porque, no momento do trauma, o encéfalo se desloca e choca contra a parede craniana contralateral. Então, se o impacto é no lado direito, a lesão de contragolpe aparece do lado esquerdo. Além disso, também está errada a associação obrigatória com fratura óssea subjacente, que não é necessária para a ocorrência do contragolpe.

3. 4002238068 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

As lesões por ação contundente, como hematomas, equimoses e escoriações, produzem necessariamente solução de continuidade da pele, sendo consideradas obrigatoriamente lesões abertas, de acordo com a classificação médico-legal.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: As lesões contusas não produzem necessariamente solução de continuidade da pele. As lesões contusas fechadas, como rubefação, equimose, hematoma, bossa, entorse, luxação e fratura, mantêm a integridade da pele ou a afetam apenas superficialmente. Já as abertas, sim, rompem a continuidade da pele e são a escoriação, a ferida contusa e as fraturas e luxações expostas.

4. 4002150298 (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC CE)/PC CE/2025) Uma pessoa que sofreu lesão corporal dolosa alegou ter sido agredida com pauladas, socos, pontapés e tapas. A lesão mais grave dolorosa, que a incapacitava de deambular, era uma lesão na região inguinal (raiz da coxa) esquerda, provocada por chute. Durante o exame da vítima, que foi realizado mais de quatro dias após a violência, o médico-legista notou uma coleção de tonalidade azul-violácea no joelho do mesmo lado daquela lesão. O periciando referiu que neste local não havia sofrido agressão.

Pelas características da formação azul-violácea descrita na situação hipotética apresentada, é correto concluir a existência de

a) bossa sanguínea.

b) equimose profunda à distância.

c) fratura oculta.



- d) hematoma sinovial.
- e) equimose externa ou superficial.

Gabarito: B

Comentário:

a) Incorreta. A bossa sanguínea é um tipo de tumefação (edema traumático) que se apresenta sobre um plano ósseo, geralmente no crânio. Nos casos de tumefação, não há rompimento de vasos.

b) Correta. A equimose profunda à distância ocorre quando o impacto de um trauma atinge um local específico, mas a infiltração de sangue se manifesta na pele em uma região distante, seguindo a gravidade ou os planos anatômicos. Ela é fundamental na análise forense para identificar a verdadeira área de impacto. O trauma provoca o rompimento de vasos profundos. Como o sangue não consegue extravasar para fora da pele (devido à espessura dos tecidos), ele migra por entre as fáscias e músculos, surgindo visível na superfície em outra área do corpo. A cor azul-violácea (2º ao 3º - mais azulada e 4º ao 6º dia - mais violácea) com mais de quatro dias é compatível com o espectro equimótico de Legrand du Saulle.

c) Incorreta. A fratura oculta não justifica a coloração azul-violácea à distância sem trauma direto no local.

d) Incorreta. Hematoma sinovial ocorre dentro de uma articulação após trauma direto nela.

e) Incorreta. A equimose superficial ocorre por rompimento de pequenos vasos superficiais no local do impacto, e não à distância.

5. 4001318562 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As lesões oriundas de energia de etiologia mecânica podem ser provocadas por mecanismo de tração, torção, compressão ou sucção.

- () Certo
- () Errado

Gabarito: Certo



Comentário: Os agentes mecânicos podem se relacionar com o corpo e provocar transferência de energia de formas extremamente variadas. Os mecanismos de ação desses agentes incluem pressão, percussão, deslizamento, explosão, compressão, descompressão, torção, distensão, contragolpe e sucção.

6. 4001318971 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

O espectro de Legrand du Saulle é utilizado para avaliar a evolução das escoriações.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: O espectro de Legrand du Saulle é utilizado para avaliar a evolução cromática das equimoses, e não das escoriações. A sequência clássica vai do vermelho ao violáceo-azulado, passando pelo esverdeado e chegando ao amarelado, refletindo o metabolismo da hemoglobina extravasada nos tecidos.

COR	GENIVAL VELOSO DE FRANÇA	HÉLIO GOMES	HERMES DE ALCÂNTARA	LEGRAND DU SAULLE
VERMELHA	1º DIA	1º DIA	1º ao 3º DIA	1º ao 2º ao 3º DIA
VIOLÁCEA-AZULADA	2º ao 6º DIA	2º ao 6º DIA	4º ao 6º DIA	2º ao 3º ao 4º ao 6º DIA
ESVERDEADA	7º ao 12º DIA	7º ao 10º DIA	7º ao 12º DIA	4º ao 6º ao 7º ao 10º DIA
AMARELADA	13º ao 17º DIA	11º ao 20º DIA	13º ao 22º DIA	12º DIA

7. 4001318971 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Fratura óssea durante um jogo por parte de um jogador caracteriza-se como lesão contusa.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: Fratura é a solução de continuidade óssea, geralmente relacionada aos mecanismos de compressão, flexão ou torção, e está classificada dentro das lesões contusas. Independente



da situação de ocorrência, a natureza da lesão continua sendo contusa do ponto de vista médico-legal.

8. 4001318975 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento perfurocortante e produz uma lesão perfuroincisa.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A faca, quando introduzida em um corpo, age por pressão (para perfurar) e deslizamento (para cortar), atuando como instrumento perfurocortante. A lesão produzida é a perfuroincisa, com bordas regulares, profundidade que tende a prevalecer sobre a extensão e formato variando conforme o número de gumes.

9. 4001323373 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. À luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Nas perícias médico e odonto-legais, o diagnóstico do instrumento causador da lesão deve observar o seguinte paradigma: é a lesão que denomina o instrumento, nunca o inverso.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: Esse é um princípio fundamental da traumatologia forense: a lesão é que denomina o instrumento, e não o contrário. Isso porque um mesmo objeto pode produzir lesões de naturezas diferentes a depender de como é utilizado. Uma faca usada deslizando o gume produz lesão incisa (ação cortante), mas a mesma faca usada batendo com o cabo produz lesão contusa (ação contundente). Por isso, a análise das características da lesão é o que permite deduzir o tipo de instrumento ou ação envolvida.



10. 4001323390 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Entre os instrumentos relacionados aos agentes mecânicos incluem-se os instrumentos perfurantes, os instrumentos bolhosos e os instrumentos maciços.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: A classificação dos instrumentos mecânicos é perfurantes, cortantes, contundentes, perfurocortantes, cortocontundentes e perfurocontundentes. Os termos "instrumentos bolhosos" e "instrumentos maciços" não existem na classificação médico-legal. A banca inventou nomenclaturas inexistentes para confundir.

11. 4001323413 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Na prática da medicina e da odontologia legal, são tipos de lesões (ferimentos) as puntiformes, as incisas, as contusas, as perfuroincisas, as cortocontusas, as perfurocontusas.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A nomenclatura das lesões corresponde diretamente ao tipo de instrumento que as produz. As lesões punctórias (ou puntiformes) são produzidas por instrumentos perfurantes; as incisas, por cortantes; as contusas, por contundentes; as perfuroincisas, por perfurocortantes; as cortocontusas, por cortocontundentes; e as perfurocontusas, por perfurocontundentes.

12. 4001323486 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química,



bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Instrumento cortante é todo objeto rombo capaz de agir traumáticamente sobre o organismo.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: Aqui a banca trocou os conceitos. Objeto rombo é justamente o instrumento contundente, que age por pressão ou choque sobre uma superfície, produzindo lesões contusas. O instrumento cortante é aquele que possui gume e age por deslizamento com leve pressão, seccionando as fibras dos tecidos e produzindo lesões incisas. São conceitos diferentes que a questão tentou misturar.

13. 4001323094 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Em medicina legal, uma lesão tecidual ampla ocasionada por uma paulada é denominada contusodilacerante.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: A lesão tecidual ampla ocasionada por uma paulada é denominada ferida contusa, e não contusodilacerante. A nomenclatura correta dentro da classificação médico-legal é simplesmente lesão contusa, produzida por instrumento contundente. Alguns autores admitem o termo "lacrocontusa" para lesões com forte componente de dilaceração, mas autores como Genival Veloso de França consideram esse termo impróprio. "Contusodilacerante" não é uma classificação reconhecida na literatura médico-legal.

14. 4001318561 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.



As manchas roxas descritas por Maria Alice fazem referência às equimoses, que se conceituam como o extravasamento de sangue oriundo da rotura dos capilares sanguíneos nas malhas dos tecidos superficiais ou profundos, sem infiltração hemorrágica.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errada.

Comentário: A equimose é uma lesão contusa que ocorre pela ação de instrumento contundente, e sua característica definidora é exatamente a infiltração hemorrágica nos tecidos. Ela acontece pela ruptura de vasos de pequeno calibre (capilares), com o sangue extravasado se espalhando pelas malhas teciduais. A banca trocou o conceito no final do enunciado ao afirmar que não há infiltração hemorrágica, o que está incorreto.

Vale aproveitar para fixar a diferença com duas lesões parecidas. No hematoma, o rompimento é de um vaso de maior calibre, e o sangramento é tão intenso que descola os tecidos, formando uma verdadeira bolsa de sangue em uma cavidade neoformada. Ocorre principalmente em regiões de tecido frouxo e não se infiltra nas malhas. Já os livores de hipóstase não decorrem de trauma: o sangue se deposita por ação da gravidade nas regiões de declive do cadáver, permanecendo dentro dos vasos, sem extravasamento nem infiltração.

15. 4001318560 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Segundo a classificação de Borri, as energias vulnerantes de etiologia mecânica são estudadas separadamente das energias vulnerantes de ordem física.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A Classificação de Borri organiza as energias vulnerantes em categorias distintas: mecânica (cinética), física (térmica, elétrica, radioativa, por pressão, luz, som), química, físico-química, bioquímica, biodinâmica e mista. Portanto, a energia mecânica realmente é estudada separadamente da energia física.



16. 4001323096 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, as soluções de continuidade das lesões, conforme a Primeira Lei de Filhos (Edouard Filhos), assemelham-se às produzidas por instrumento de dois gumes ou têm a aparência de casa de botão.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A 1ª Lei de Filhos, também conhecida como Lei da Semelhança, estabelece exatamente isso: as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão". Esse formato ocorre por causa das linhas de tensão da pele e da disposição das fibras elásticas e colágenas na derme.



Figura do Livro Medicina Legal, 11ª edição - 2017 (Autor Genival Veloso de França). Lesões produzidas por instrumento de médio calibre (furador de gelo).

17. 4001323097 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Esgorjamento é uma lesão transversal abdominal que expõe o conteúdo visceral.

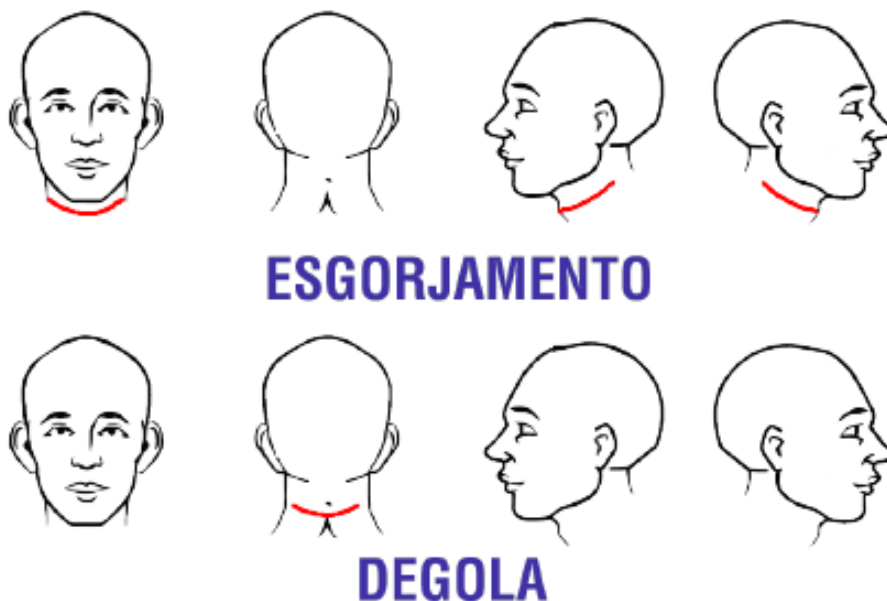
() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: O esgorjamento é uma lesão localizada na região anterior e/ou lateral do pescoço, não no abdômen. Pode atingir desde a pele até estruturas profundas como músculos, feixes

vasculonervosos, esôfago, laringe e traqueia, levando à morte por secção dos vasos calibrosos da região carotídea ou por asfixia pela aspiração de sangue.



18. 4001323098 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

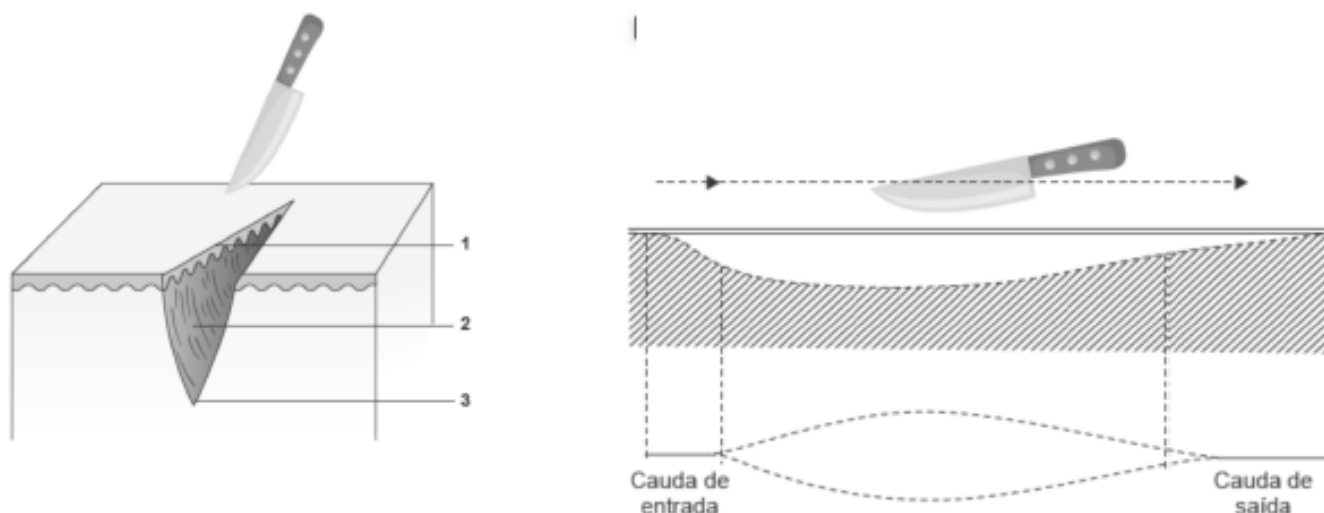
As feridas cortantes apresentam as extremidades mais superficiais e a parte mediana mais profunda, nem sempre de forma regular, além de terem, como característica principal, a chamada cauda de escoriação.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certa.

Comentário: Isso mesmo! As feridas incisivas apresentam extremidades mais superficiais e parte mediana mais profunda, com o comprimento prevalecendo sobre a largura e a profundidade. Isso decorre da forma como o instrumento cortante atua, com pressão maior no centro do movimento de deslizamento. A cauda de escoriação (também chamada de cauda de rato, sinal de Romanese ou de Lacassagne) é uma característica marcante dessas feridas, surgindo na extremidade de término da ação do instrumento, quando ele se afasta do corpo da vítima. Essa cauda é um importante sinal pericial porque ajuda a determinar o sentido e a direção da ação cortante.



Legenda: 1. Borda ou lábio. 2. Vertente. 3. Fundo.

Fonte: Vanrell JP. Odontologia Legal e Antropologia Forense, 3ª edição. 2019.

19. 4001323099 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A rubefação caracteriza-se pela congestão repentina e momentânea de uma região do corpo atingida pelo traumatismo, evidenciada por mancha avermelhada, efêmera e fugaz que desaparece em alguns minutos.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A rubefação é a lesão mais simples e fugaz da categoria contusa. Quando o instrumento contundente atua, a pressão no local promove liberação de histamina, que causa vasodilatação, hiperemia e vermelhidão local. É efêmera mesmo, desaparecendo em alguns minutos ou poucas horas, o que dificulta sua documentação pericial.

20. 4001323498 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano

tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue O item subsecutivo.

Fraturas correspondem a uma solução de continuidade dos ossos.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certa.

Comentário: Isso mesmo! Fratura é a solução de continuidade óssea, ou seja, a quebra do osso. Está geralmente relacionada aos mecanismos de compressão, flexão ou torção.

21. 4001323101 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

O desferimento de socos e pontapés em um indivíduo é considerado ação de instrumento contundente ativo, ao passo que a queda da própria altura no asfalto é ação de instrumento contundente passivo.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: Essa classificação refere-se às dinâmicas de ação do agente. Na forma ativa, o instrumento vai em direção ao corpo (como socos e pontapés desferidos contra a vítima). Na forma passiva, o corpo vai ao encontro do instrumento imóvel (como na queda da própria altura, em que o corpo vai de encontro ao asfalto).



22. 4001323500 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue o item subsecutivo.

As lesões, observando-se as suas características, podem fornecer informações relativas ao ponto ou área onde se produziu violência; à data provável do evento; à vida ou morte da vítima, quando da agressão; à forma do instrumento e à natureza do atentado ou ação.

() Certo

() Errado

Gabarito: Certo

Comentário: A análise minuciosa das lesões realmente permite extrair diversas informações periciais relevantes. A localização indica o ponto da violência; as características cromáticas e cicatriciais permitem estimar a data do evento; sinais como infiltração hemorrágica, formação de crosta e reação inflamatória ajudam a determinar se a lesão foi produzida em vida ou após a morte; o formato sugere o instrumento causador (lesões por assinatura); e a quantidade, localização e profundidade orientam quanto à natureza homicida, suicida ou acidental.

23. 4001323103 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A sequência evolutiva de cores do espectro equimótico de Legrand du Saulle é caracterizada, na ordem evolutiva, por vermelho- escuro, preto, azul, violeta, verde e amarelo.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: A sequência cromática correta do espectro equimótico de Legrand du Saulle é: vermelha, violácea-azulada, esverdeada e amarelada. Essa variação cromática reflete o metabolismo das proteínas da hemoglobina extravasada, com formação de hemossiderina, biliverdina, bilirrubina, hematoidina e hematina ao longo dos dias.



COR	GENIVAL VELOSO DE FRANÇA	HÉLIO GOMES	HERMES DE ALCÂNTARA	LEGRAND DU SAULLE
VERMELHA	1º DIA	1º DIA	1º ao 3º DIA	1º ao 2º ao 3º DIA
VIOLÁCEA-AZULADA	2º ao 6º DIA	2º ao 6º DIA	4º ao 6º DIA	2º ao 3º ao 4º ao 6º DIA
ESVERDEADA	7º ao 12º DIA	7º ao 10º DIA	7º ao 12º DIA	4º ao 6º ao 7º ao 10º DIA
AMARELADA	13º ao 17º DIA	11º ao 20º DIA	13º ao 22º DIA	12º DIA

24. 4001323501 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue O item subsequente.

As fraturas são exclusivamente consequências da ação de compressão.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: As fraturas não decorrem exclusivamente da compressão. Estão relacionadas aos mecanismos de compressão, flexão ou torção, e podem ainda ser diretas (no local do trauma) ou indiretas (à distância do ponto de impacto).

25. 4001323105 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as armas brancas podem ser empregadas de diversas formas e, assim, produzir lesões de diferentes tipos e com diversos graus de potencial lesivo, julgue o item que se segue.

De acordo com a lei de Langer, feridas produzidas em regiões de confluência de linhas de força são paralelas entre si.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: Lei de Langer (Lei do Polimorfismo ou da Elasticidade): Nas regiões em que ocorre cruzamento (convergência ou confluência) de fibras de sentidos diferentes, as extremidades da lesão assumem um aspecto de ponta de seta, de triângulo ou até de quadrilátero. Cuidado para



não confundir com a 2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo): quando as feridas se localizam na mesma região do corpo que possua as linhas de força dispostas em uma só direção, seu maior eixo tem sempre a mesma direção.

26. 4001323106 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as armas brancas podem ser empregadas de diversas formas e, assim, produzir lesões de diferentes tipos e com diversos graus de potencial lesivo, julgue o item que se segue.

Feridas causadas por armas brancas que alcançam grande profundidade são denominadas cortocontusas.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado.

Comentário: O que define a lesão cortocontusa é o mecanismo de ação misto e as características das bordas (regulares mas escoriadas, com vertentes planas e certo grau de laceração), não a profundidade. A profundidade da ferida não é critério para classificá-la como cortocontusa. As feridas perfuroincisas, por exemplo, são produzidas por armas brancas (como facas e punhais) e podem alcançar grande profundidade, sendo que justamente nelas a profundidade tende a prevalecer sobre a extensão. As feridas cortocontusas, por outro lado, são produzidas por instrumentos como foice, machado e facão, que combinam ação cortante (deslizamento) e contundente (percussão ou pressão).

27. 4001376953 (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023) No que diz respeito a lesões por ação contundente, por armas brancas e de fogo e por projéteis de arma de fogo comuns, julgue o próximo item.

Um bisturi, ao ser manipulado por ação em linha, deslizando e cortando um tecido, provoca uma lesão cortante.

() Certo

() Errado

Gabarito: Errado

Comentário: O termo correto para a lesão é incisa, e não cortante. Lembra da observação importante: o que é cortante é o instrumento, e a lesão produzida é incisa.



28. 4001087461 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Per (PC PB)/PC PB/Área Geral/2022) Uma criança foi levada ao IML após ter sido examinada na emergência infantil de um hospital pediátrico com suspeita de síndrome de Straus. Ao exame físico, constatou-se descolamento metafisário, provavelmente decorrente de trações e constrictões violentas, bem como trações e tensões ao nível de uma articulação. Considerando essas informações, é correto afirmar que houve ação de energia de ordem

- a) química.
- b) mecânica.
- c) biodinâmica.
- d) física.
- e) físico-química.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. A energia química envolve substâncias que reagem com o corpo causando danos (ácidos, bases, venenos).
- b) Correta. As trações, constrictões, tensões e o descolamento metafisário descritos são típicos da ação de energia mecânica (cinética), pois envolvem transferência de força e movimento. Os mecanismos de ação dos agentes mecânicos incluem pressão, percussão, deslizamento, compressão, descompressão, torção, distensão e tração.
- c) Incorreta. A energia biodinâmica refere-se a alterações funcionais por estímulos biológicos ou psíquicos, não a traumas físicos. Envolve o desequilíbrio das funções vitais. Abrange o choque anafilático, a inanição, a desidratação severa e os efeitos da fadiga extrema.
- d) Incorreta. A energia física na classificação de Borri abrange térmica, elétrica, radioativa, pressão atmosférica, luz e som.
- e) Incorreta. A energia físico-química combina reações químicas com fenômenos físicos, o que não se aplica ao caso.

29. 4001203403 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) A área da medicina legal que estuda as lesões e estados patológicos, imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano, nos seus aspectos de diagnóstico, prognóstico e implicações legais e socioeconômicas, assim como as diversas modalidades de energias causadoras desses danos, é denominada

- a) diceologia médica.



- b) antropologia forense.
- c) traumatologia forense.
- d) infortunistica.
- e) tanatologia forense.

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. A diceologia médica estuda os direitos e deveres profissionais do médico, não as lesões.
- b) Incorreta. A antropologia forense estuda a identificação de indivíduos a partir de remanescentes humanos, com foco em características esqueléticas.
- c) Correta. A traumatologia forense é o ramo que estuda as lesões e estados patológicos produzidos por violência sobre o corpo humano, analisando energias causadoras, diagnóstico, prognóstico e implicações legais.
- d) Incorreta. A infortunistica trata de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
- e) Incorreta. A tanatologia forense é o estudo da morte e dos fenômenos cadavéricos.

30. 4001229848 (CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2022) A traumatologia forense é um ramo da medicina legal

- a) que estuda a cronotanatognose.
- b) também conhecido como lesonologia.
- c) que estuda as asfixias sob o ponto de vista médico e jurídico.
- d) responsável por estudar a parte de identificação médico-legal.
- e) que define as características antropológicas do ser humano.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. A cronotanatognose é o estudo da estimativa do tempo de morte, integrante da tanatologia.
- b) Correta. Lesonologia é o termo sinônimo de traumatologia forense, ambos se referindo ao ramo que estuda as lesões corporais e suas implicações médico-legais.



- c) Incorreta. O estudo das asfixias, embora relacionado, faz parte de outro capítulo específico da medicina legal (asfixiologia).
- d) Incorreta. A identificação médico-legal é estudada pela antropologia forense e pela odontologia legal.
- e) Incorreta. As características antropológicas pertencem à antropologia forense, não à traumatologia.

31. 4001084576 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022)
Uma ferida de forma linear, bordas regulares, predominância do comprimento sobre a profundidade, afastamento das bordas da ferida, regularidade do fundo da lesão, hemorragia quase sempre abundante, presença de cauda de escoriação, centro da ferida mais profundo que as extremidades é denominada ferida

- a) contusa.
- b) perfurocontusa.
- c) punctória.
- d) cortante.
- e) perfurocortante.

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. A ferida contusa tem bordas irregulares e equimadas, fundo irregular com pontes de tecido e pouco sangramento.
- b) Incorreta. A perfurocontusa é produzida por projétil de arma de fogo e instrumentos semelhantes, com características próprias, como:

Orifício de Entrada: Apresenta formato circular ou ovalado, bordas invertidas (para dentro) e as marcas características Orla de escoriação (Pele escoriada devido à rotação e penetração do projétil) ; Orla de equimose (Zona arroxeadada pelo esmagamento dos tecidos); Orla de enxugo (Limpeza da sujeira do projétil na pele).

Orifício de Saída: Geralmente é maior e de formato irregular. Suas bordas são evertidas (viradas para fora) e não apresentam as orlas de escoriação ou enxugo.

Veremos isso de forma mais detalhada na aula de balística.

- c) Incorreta. A ferida punctória tem formato em ponto, profundidade maior que a extensão e pouco sangramento.



d) Correta. As características listadas correspondem à ferida incisa (cortante na nomenclatura da banca - já vimos que a maioria dos autores não considera essa nomenclatura): bordas regulares, comprimento prevalecendo sobre profundidade, fundo regular, sangramento abundante, cauda de escoriação e maior profundidade no centro.

e) Incorreta. A perfuroincisa tem profundidade prevalecendo sobre a extensão, com formato variando conforme o número de gumes.

32. 4001084862 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) Periciado vítima de acidente automobilístico apresentou fratura exposta de fêmur direito em ambas as tíbias, extensa equimose em tórax anterior, hematoma subgaleal em região frontoparietal direita. O instrumento que provocou as referidas lesões é do tipo

- a) perfurante.
- b) perfurocortante.
- c) perfurocontundente.
- d) contundente.
- e) cortante.

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. Instrumentos perfurantes produzem lesões punctórias por afastamento dos tecidos, não fraturas, equimoses e hematomas extensos.
- b) Incorreta. Os perfurocortantes produzem feridas perfuroincisas com bordas regulares.
- c) Incorreta. Os perfurocontundentes (como o projétil de arma de fogo) produzem lesões com características específicas como orla de enxugo e contusão.
- d) Correta. Fraturas, equimoses extensas e hematomas são lesões típicas da ação contundente. Em acidentes automobilísticos, o impacto contundente é o principal mecanismo lesivo, atuando por pressão, percussão e compressão sobre amplas superfícies do corpo.
- e) Incorreta. Instrumentos cortantes produzem feridas incisas com bordas regulares e sangramento abundante, não fraturas e hematomas.

33. 4001202587 (CEBRASPE (CESPE) - Med Leg (PC RO)/PC RO/2022) No que se refere à necessidade de conhecer diversas lesões em medicina legal, assinale a opção correta sobre o referido tema e assuntos correlatos.

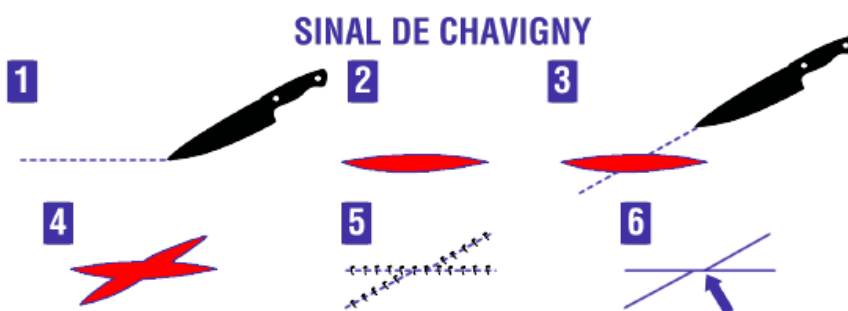


- a) Sinal de Chavigny manifesta-se quando há lesões contusas sobrepostas (provocadas uma em cima da outra).
- b) Lei de Filhos e Langer é a lei aplicada em casos de lesões produzidas por instrumentos contundentes.
- c) Instrumentos como punhal e faca introduzidos em um corpo produzem lesão perfurocortante.
- d) Ferimentos produzidos por instrumentos perfurocortantes tendem, de maneira geral, a apresentar o formato do instrumento que os produziu.
- e) Degolamento caracteriza-se, em geral, por uma ferida incisa ou cortocontusa localizada na porção posterior do pescoço.

Gabarito: E

Comentário:

- a) Incorreta. O Sinal de Chavigny manifesta-se quando há sobreposição de lesões incisais, e não contusas. Ele permite identificar qual ferida foi produzida primeiro, já que a segunda apresenta interrupção ou desvio de trajeto ao ter as bordas aproximadas.



- b) Incorreta. As Leis de Filhos e Langer aplicam-se às lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre, e não por contundentes.
- c) Incorreta. Punhal e faca introduzidos em um corpo produzem lesão perfuroincisa, e não perfurocortante. Perfurocortante é a classificação do instrumento, não da lesão.
- d) Incorreta. Lesões por assinatura, que reproduzem o formato do instrumento, são mais características das ações contundentes (como equimoses por cassetetes e estrias pneumáticas de Simonin), não das perfurocortantes.
- e) Correta. O degolamento é a lesão localizada na face posterior do pescoço e pode ter características de ferida incisa ou cortocontusa, dependendo do instrumento utilizado e do mecanismo de ação.

34. 4001202548 (CEBRASPE (CESPE) - Med Leg (PC RO)/PC RO/2022) No que se refere à coloração das equimoses no trabalho de cronologia de uma agressão, assinale a opção correta.

- a) As equimoses, comumente, ocorrem devido à ação de instrumento cortante.
- b) O Índice de Verderau auxilia na análise das equimoses no que se refere à determinação da ocorrência de uma lesão intra vitam e post mortem.
- c) As equimoses são classificadas como profundas porque se situam em tegumentos e massas musculares.
- d) A presença de equimose superficial de coloração amarelada, tendo como parâmetro o espectro equimótico de Le Grand du Saulle, sugere lesão ocorrida em, no máximo, sete dias.
- e) As equimoses profundas assumem coloração avermelhada durante toda a sua evolução.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. As equimoses são produzidas por ação contundente, e não cortante. A ação cortante produz feridas incisivas, caracterizadas por bordas regulares e sangramento abundante.
- b) Correta. O Índice de Verderau é a relação entre o número de glóbulos vermelhos e brancos. Nos traumatismos em vida, há aumento dos glóbulos brancos na região afetada (reação inflamatória), diminuindo o índice. Já nas lesões post mortem, esse índice permanece inalterado. É uma ferramenta importante para o diagnóstico diferencial entre lesão intra vitam e post mortem.
- c) Incorreta. As equimoses são classificadas como superficiais ou profundas conforme sua localização. As profundas situam-se em planos mais internos (vísceras, periósteo), e não nos tegumentos (tecidos de revestimento e seus anexos). Massas musculares podem ser sede tanto de equimoses superficiais quanto profundas.
- d) Incorreta. Segundo o espectro equimótico de Legrand du Saulle, a coloração amarelada surge por volta do 12º dia, e a lesão tende a desaparecer entre o 15º e o 20º dia. Portanto, uma equimose amarelada sugere lesão com pelo menos 12 dias, não no máximo sete.
- e) Incorreta. As equimoses profundas também sofrem alteração cromática conforme o metabolismo da hemoglobina. As que mantêm coloração avermelhada por toda a evolução são as da conjuntiva ocular, por sua oxigenação intensa, e não as equimoses profundas em geral.

35. 4001084580 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) São considerados instrumentos cortocontundentes

- a) projétil de arma de fogo, vergalhões de construção civil.



- b) furador de gelo, prego.
- c) punhal, faca peixeira.
- d) foice, facão.
- e) faca de cozinha, canivete.

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. Projétil de arma de fogo e vergalhões são instrumentos perfurocontundentes, que atuam perfurando e contundindo ao mesmo tempo.
- b) Incorreta. Furador de gelo é instrumento perfurante de médio calibre, e prego é perfurocontundente.
- c) Incorreta. Punhal e faca peixeira são instrumentos perfurocortantes, atuando por pressão e deslizamento.
- d) Correta. Foice e facão são exemplos clássicos de instrumentos cortocontundentes. Possuem gume, mas também massa considerável, atuando simultaneamente por deslizamento (corte) e percussão/pressão (contusão).
- e) Incorreta. Faca de cozinha e canivete são instrumentos perfurocortantes, com ponta e gume.

36. 4001084585 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022)
Julgue os itens a seguir, relativos à traumatologia forense.

- I A rubefação é considerada a menor e mais transitória lesão causada pela ação contundente.
- II O hematoma corresponde a discreto extravasamento de sangue dos capilares com sua difusão nas malhas dos tecidos moles.
- III A escoriação define-se como arrancamento da epiderme e o desnudamento da derme, de onde fluem serosidade e sangue.
- IV A equimose corresponde às lesões que se traduzem por coleções hemorrágicas que não se difundem nas malhas dos tecidos.

Estão certos apenas os itens

- A. I e II
- B. I e III.
- C. II e IV



D. I, III e IV

E. II, II e IV

Gabarito: B

Comentário:

Vamos a análise de cada afirmação:

O item I está certo. A rubefação é realmente a lesão mais simples e fugaz da categoria contusa, desaparecendo em alguns minutos ou poucas horas. Resulta da liberação de histamina pela pressão local, causando vasodilatação e vermelhidão transitória.

O item II está errado. O conceito apresentado descreve a equimose, não o hematoma. No hematoma, o sangue extravasa de vasos calibrosos e se acumula em uma cavidade neoformada, deslocando os tecidos, e não se difundindo entre eles.

O item III está certo. A escoriação ocorre quando o instrumento, em ação tangencial, arranca a epiderme e expõe a derme, fluindo serosidade e sangue. Quando atinge apenas a epiderme, é escoriação típica (apenas serosidade); quando atinge a derme com secção das papilas, é atípica (com sangue).

O item IV está errado. O conceito é invertido. A equimose se caracteriza pela difusão do sangue nas malhas dos tecidos. O que descreve coleção hemorrágica sem difusão é o hematoma, no qual o sangue forma um lago em cavidade neoformada.

Portanto, apenas I e III estão corretos.

37. 4001087469 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Per (PC PBJ/PC PB/Área Geral/2022) Dois agricultores agrediram-se mutuamente com facões e um deles feriu-se gravemente no antebraço direito, tendo trauma ósseo e secção de diversos tendões, após solução de continuidade na face anterior desse segmento. Com base nessa situação, é correto afirmar que o trauma descrito caracteriza lesão

a) incisa.

b) corto-contundente.

c) contusa.

d) perfuro-contusa.

e) perfuro-incisa.

Gabarito: B

Comentário:



a) Incorreta. A lesão incisa é produzida apenas por deslizamento de gume afiado, com bordas regulares e sangramento abundante, mas sem o componente contundente que provoca trauma ósseo significativo.

b) Correta. O facão é o exemplo clássico de instrumento cortocontundente. Possui gume (componente cortante) e massa considerável (componente contundente), produzindo lesões que combinam corte e contusão. O trauma ósseo associado à secção de tendões é compatível com esse tipo de ação, pois a massa do instrumento permite atingir planos profundos e provocar fraturas.

c) Incorreta. A lesão contusa é produzida por instrumento sem gume, com bordas irregulares e equimadas, não compatível com a secção de tendões.

d) Incorreta. A perfurocontusa é típica de projéteis de arma de fogo e instrumentos similares, com características próprias, como:

Orifício de Entrada: Apresenta formato circular ou ovalado, bordas invertidas (para dentro) e as marcas características Orla de escoriação (Pele escoriada devido à rotação e penetração do projétil) ; Orla de equimose (Zona arroxeadada pelo esmagamento dos tecidos); Orla de enxugo (Limpeza da sujeira do projétil na pele).

Orifício de Saída: Geralmente é maior e de formato irregular. Suas bordas são evertidas (viradas para fora) e não apresentam as orlas de escoriação ou enxugo.

Veremos isso de forma mais detalhada na aula de balística.

e) Incorreta. A perfuroincisa é produzida por instrumentos perfurocortantes (faca, punhal), com profundidade prevalecendo sobre extensão, sem o componente contundente capaz de provocar trauma ósseo extenso.

38. 4001203486 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) Assinale a opção que apresenta os meios produtores de lesões causadoras de danos em energias de ordem mecânica.

a) revólveres, punhais, machado, energia elétrica, radioatividade e venenos

b) punhais, pistolas elétricas (taser), dentes, máquinas, animais, venenos e asfixia

c) faca, machado, explosões, cáusticos, asfixia e choque

d) foice, pistolas elétricas (taser), animais, quedas, queimaduras e radioatividade

e) revólveres, soqueira, navalha, foice, punhos, dentes, máquinas, veículos, animais e quedas

Gabarito: E

Comentário:



- a) Incorreta. Energia elétrica, radioatividade e venenos não são mecânicos. Eletricidade e radiação são energias físicas, e venenos são energia química.
- b) Incorreta. Pistolas elétricas (taser) atuam por energia elétrica (física), venenos são químicos e asfixia é fenômeno físico-químico.
- c) Incorreta. Explosões podem envolver energia mista, cáusticos são químicos, asfixia é físico-químico e choque pode ser elétrico (energia física).
- d) Incorreta. Pistolas elétricas são físicas (elétrica), queimaduras são físicas (térmica) e radioatividade também é energia física.
- e) Correta. Todos os itens listados (revólveres, soqueira, navalha, foice, punhos, dentes, máquinas, veículos, animais e quedas) atuam por transferência de energia mecânica (cinética), seja por percussão, pressão, deslizamento, compressão ou outros mecanismos de ação mecânica.

39. 4001203497 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) Assinale a opção que corresponde às características das lesões produzidas por ação perfurante.

- a) forma estrelada, sinuosa ou retilínea; bordas irregulares, escoriadas e esquimosadas; vertentes irregulares, pouco sangrantes, retração das bordas da ferida
- b) forma linear; regularidade das bordas; regularidade do fundo da lesão; afastamento das bordas da ferida
- c) abertura estreita; raro sangramento; pouca nocividade na superfície; eventual gravidade na profundidade, em face do órgão atingido; diâmetro quase sempre menor que o do instrumento causador
- d) centro da ferida mais profundo que as extremidades; paredes da ferida lisas e regulares; vertentes cortadas obliquamente; hemorragia quase sempre abundante
- e) ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida; presença de cauda de escoriação voltada para o lado onde terminou a ação do instrumento; perfil de corte de aspecto angular

Gabarito: C

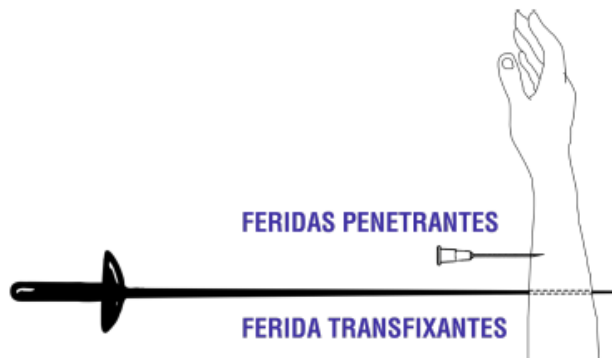
Comentário:

- a) Incorreta. A descrição corresponde às lesões contusas, com bordas irregulares e escoriadas, vertentes irregulares e pouco sangramento, características da ação contundente.
- b) Incorreta. A forma linear, regularidade de bordas e fundo, e afastamento das bordas remetem às lesões incisas, produzidas por instrumentos cortantes.



c) Correta. As lesões punctórias (produzidas por instrumentos perfurantes) têm abertura estreita, raro sangramento, pouca nocividade na superfície (mas gravidade variável na profundidade conforme os órgãos atingidos) e diâmetro menor que o do instrumento causador, devido à elasticidade e retratilidade dos tecidos cutâneos. Lembrando que elas podem ser penetrantes ou transfixantes.

d) Incorreta. Centro mais profundo, paredes lisas e regulares e hemorragia abundante são características das feridas incisais.



e) Incorreta. A cauda de escoriação e o perfil angular são marcas típicas das lesões incisais, produzidas por instrumentos cortantes.

40. 4001230397 (CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC RO)/PC RO/2022) O hematoma é caracterizado pela literatura médico-legal como uma lesão

- a) incisa, proveniente de energia de ordem física.
- b) contusa, proveniente de energia de ordem química.
- c) cortocontusa, proveniente de energia de ordem bioquímica.
- d) contusa, proveniente de energia de ordem mecânica.
- e) cortocontusa, proveniente de energia de ordem biodinâmica.

Gabarito: D

Comentário:

a) Incorreta. A lesão incisa é produzida por instrumento cortante. Além disso, a energia envolvida é mecânica, não física.

b) Incorreta. Embora o hematoma seja uma lesão contusa, sua origem é energia mecânica (cinética), e não química.

c) Incorreta. O hematoma não é cortocontuso. Lesões cortocontusas são produzidas por instrumentos com ação de corte e contundente, como foice e machado. Energia bioquímica também não se aplica.

d) Correta. O hematoma é uma lesão contusa, produzida por ação contundente, que se enquadra dentro das energias de ordem mecânica (cinética) na Classificação de Borri. Caracteriza-se pela coleção de sangue em cavidade neoformada por rotura de vasos calibrosos.

e) Incorreta. Hematoma não é cortocontuso, e energia biodinâmica refere-se refere-se aos fenômenos ou alterações fisiológicas, sejam de origem interna ou externa ao corpo, que desencadeiam respostas orgânicas internas. Ela atua perturbando o funcionamento normal dos órgãos, podendo resultar em falhas sistêmicas fatais sem, necessariamente, deixar marcas traumáticas externas evidentes.

41. 4000986580 (CEBRASPE (CESPE) - DP TO/DPE TO/2022) Um faxineiro de um hospital público, ao manusear o lixo da unidade cirúrgica, sofreu uma lesão que foi descrita no prontuário médico como incisa. Com base nessas informações, é correto afirmar que, na situação hipotética apresentada, a lesão foi causada por instrumento

a) cortocontundente.

b) perfurante.

c) perfurocontundente.

d) contundente.

e) cortante.

Gabarito: E

Comentário:

a) Incorreta. Instrumento cortocontundente (como foice ou machado) produz lesão cortocontusa, com bordas regulares mas escoriadas e perda de substância.

b) Incorreta. Instrumento perfurante (como agulha ou furador de gelo) produz lesão punctória, em forma de ponto ou "casa de botão".

c) Incorreta. Instrumento perfurocontundente (como projétil de arma de fogo) produz lesão perfurocontusa, com características específicas.

d) Incorreta. Instrumento contundente produz lesão contusa, com bordas irregulares e equimadas.



e) Correta. Instrumento cortante (como bisturi, lâminas e facas) produz lesão incisa. No contexto do enunciado, é altamente provável que o faxineiro tenha se ferido em uma lâmina ou bisturi descartado, característico de acidente em ambiente hospitalar.

42. 4002237251 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Atente para a seguinte descrição: Mulher de 42 anos procura a delegacia de Polícia Civil plantonista, por volta de meia-noite, após uma discussão com seu companheiro, que estava alcoolizado, há cerca de 6 horas. Declara que foi agredida fisicamente e moralmente. O policial que a atendeu percebe que ela apresenta equimoses avermelhadas e difusas em face, associadas com escoriações irregulares em membro superior direito e luxação em joelho esquerdo. Entre outros procedimentos, foi emitida guia policial para realização de perícia com o médico legista. Considerando as lesões descritas, quais sejam: equimoses, escoriações e luxação, é correto afirmar que os meios ou instrumentos promotores dessas lesões serão apresentados, no laudo pericial, respectivamente, como

- a) perfurocortante, contundente e cortante.
- b) cortante, contundente e contundente.
- c) contundente, perfurocortante e contundente.
- d) contundente, contundente e contundente.
- e) cortante, contundente e cortante.

Gabarito: D.

Comentário:

- a) Incorreta. Perfurocortante produziria lesão perfuroincisa com bordas regulares, o que não corresponde a equimose.
- b) Incorreta. Cortante produziria lesão incisa, não equimose. Escoriações e luxações também não são produzidas por instrumentos cortantes.
- c) Incorreta. Escoriações não são produzidas por instrumentos perfurocortantes, mas por ação tangencial contundente.
- d) Correta. Equimose, escoriação e luxação são lesões contusas. A equimose ocorre por rotura de capilares com infiltração nas malhas teciduais; a escoriação é o arrancamento da epiderme por ação tangencial contundente; a luxação é o deslocamento permanente das superfícies articulares, geralmente por ação mecânica contundente.
- e) Incorreta. Nem equimose nem luxação são produzidas por instrumentos cortantes.



43. 4001774247 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Na frase "indivíduo apresenta objeto perfurante penetrado em esclera" conclui-se que há um objeto perfurando o:

- a) Tórax.
- b) Abdome.
- c) Olho.
- d) Cérebro.
- e) Baço.

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. A esclera não pertence ao tórax. Lesão perfurante no tórax atingiria estruturas como pulmões, coração e grandes vasos.
- b) Incorreta. A esclera não está localizada no abdome. Lesões perfurantes abdominais comprometeriam vísceras como fígado, baço, estômago e intestinos.
- c) Correta. A esclera é a camada externa, fibrosa e esbranquiçada do globo ocular, conhecida popularmente como o "branco dos olhos". Portanto, um objeto perfurante penetrado na esclera está perfurando o olho.
- d) Incorreta. O cérebro é envolvido pelas meninges e pela calota craniana, não pela esclera.
- e) Incorreta. O baço é um órgão abdominal e não possui esclera.

44. 4002543244 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Considerando a traumatologia médico-legal:

- I. Esgorjamento, degola e decapitação são lesões localizadas no pescoço da vítima.
- II. As equimoses não são encontradas no cadáver em lesões produzidas após a morte.
- III. A desidratação é o quadro clínico provocado pela perda de água do organismo, podendo ocorrer somente pela via cutânea ou em razão da sudorese intensa.
- IV. Fica afastada a hipótese de suicídio quando a asfixia for por esganadura.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) II, III e IV.



c) I, III e IV.

d) I II e III.

e) I, II e IV.

Gabarito: E

Comentário:

Vamos analisar cada afirmação:

O item I está certo. Esgorjamento (região anterior/lateral do pescoço), degolamento (região posterior) e decapitação (separação completa da cabeça do corpo) são todas lesões localizadas no pescoço.

O item II está certo. As equimoses dependem de circulação ativa para se formarem, com pulsação que permite a infiltração progressiva do sangue nas malhas teciduais. Portanto, são consideradas sinal vital e não se formam em lesões produzidas após a morte.

O item III está errado. A desidratação pode ocorrer por diversas vias além da cutânea, incluindo perdas digestivas (vômitos, diarreia), urinárias (poliúria), respiratórias (hiperventilação) e por hemorragias.

O item IV está certo. A esganadura é a constrição do pescoço pelas mãos ou outras partes do corpo do agressor, sendo impossível de ser realizada pela própria vítima (diferentemente do enforcamento e do estrangulamento, que podem ter natureza suicida). Portanto, esganadura afasta a hipótese de suicídio.

Estão corretos os itens I, II e IV.

45. 4001237035 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) O ramo da Medicina Legal que estuda as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano, bem como os aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais é a:

a) Asfixiologia.

b) Antropologia forense.

c) Deontologia.

d) Traumatologia forense.

e) Tanatologia.

Gabarito: D



Comentário:

- a) Incorreta. A asfixiologia estuda especificamente as asfixias mecânicas, não as lesões corporais em geral.
- b) Incorreta. A antropologia forense estuda a identificação de indivíduos a partir de características esqueléticas e antropométricas.
- c) Incorreta. A deontologia trata dos deveres e da ética profissional.
- d) Correta. A traumatologia forense é o ramo da medicina legal que estuda as lesões corporais, as energias causadoras dos danos, e os aspectos de diagnóstico, prognóstico e implicações legais. Também é conhecida como lesonologia.
- e) Incorreta. A tanatologia estuda a morte e os fenômenos cadavéricos.

46. 4000955077 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) A Traumatologia Médico-Legal estuda as lesões e condições patológicas, imediatas ou tardias, geradas por violência sobre o corpo humano, nos seus aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas consequências legais e socioeconômicas. As causas de mortes por trauma têm relação direta com a idade. Assim, em adolescentes, a principal causa de morte por trauma é causada por:

- a) Afogamentos.
- b) Queimaduras.
- c) Quedas de bicicletas.
- d) Quedas da própria altura.
- e) Acidentes automobilísticos.

Gabarito: E.

Comentário:

- a) Incorreta. Afogamentos são causas relevantes de morte em crianças pequenas, mas não predominam em adolescentes.
- b) Incorreta. Queimaduras estão mais associadas a faixas etárias mais jovens (crianças) e a contextos específicos, não sendo a principal causa em adolescentes.
- c) Incorreta. Quedas de bicicletas geram traumas, mas não figuram como principal causa de morte por trauma nessa faixa.
- d) Incorreta. Quedas da própria altura são mais relevantes em idosos.



e) Correta. Em adolescentes e adultos jovens, os acidentes automobilísticos são a principal causa de morte por trauma, dado o início da fase de condução de veículos, exposição ao trânsito e comportamentos de risco característicos dessa fase da vida.

47. 4001237033 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Na traumatologia forense, a identificação de equimoses pode ser caracterizada:

- a) Pela forma mais simples das lesões, hiperemiada e edemaciada, sendo fugaz, efêmera, passageira, e, por isso, o exame de corpo de delito deve ser feito rapidamente, sob risco de desaparecimento.
- b) Pelo arrancamento traumático da epiderme, com exposição da derme, sem, contudo, ultrapassá-la e com cicatrização por reepitelização.
- c) Pelas soluções de continuidade dos tecidos com bordos regulares, superficiais e profundos e hemorragia profusa.
- d) Pelas soluções de continuidade dos tecidos com esmagamento da epiderme e derme, de forma contusa e irregular.
- e) Pela infiltração do sangue nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão. Em regra, ocorre pela ruptura de capilares, vênulas e arteríolas.

Gabarito: E

Comentário:

- a) Incorreta. A descrição corresponde à rubefação, lesão fugaz e efêmera, não à equimose.
- b) Incorreta. O arrancamento da epiderme com exposição da derme caracteriza a escoriação.
- c) Incorreta. Soluções de continuidade com bordas regulares e hemorragia profusa descrevem as feridas incisas.
- d) Incorreta. Soluções de continuidade com esmagamento da epiderme e derme, de forma irregular, são típicas das feridas contusas.
- e) Correta. A equimose é a infiltração de sangue nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão, decorrente da ruptura de pequenos vasos (capilares, vênulas e arteríolas). A presença dessa infiltração hemorrágica é o que diferencia a equimose do hematoma (que forma cavidade neoformada) e dos livores hipostáticos (em que o sangue permanece intravascular).

48. 4001237050 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Uma ferida que apresenta uma forma linear, regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida, hemorragia quase sempre abundante e



predominância do comprimento sobre a profundidade é uma característica das lesões produzidas por:

- a) ação cortante.
- b) ação perfurante.
- c) ações contundentes.
- d) ação mista abrasiva e cortante.
- e) ação mista perfuro-contundentes.

Gabarito: A

Comentário:

- a) Correta. As características descritas correspondem à ferida incisa, produzida por ação cortante, apresentando forma linear, bordas regulares, fundo regular, ausência de vestígios traumáticos ao redor, hemorragia abundante e comprimento prevalecendo sobre profundidade.
- b) Incorreta. A ação perfurante produz lesão punctória, com formato em ponto, pouco sangramento e profundidade prevalecendo sobre extensão.
- c) Incorreta. Ações contundentes produzem lesões com bordas irregulares, equimadas, pouco sangrantes e com vestígios traumáticos no entorno.
- d) Incorreta. Lesão por abrasão refere-se a escoriações.
- e) Incorreta. A ação perfurocontundente produz lesão perfurocontusa, típica de projéteis de arma de fogo, com características próprias.

49. 4000955062 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) As lesões simples causadas por instrumentos externos, como no atrito por deslizamento, que lesa a superfície da pele removendo camadas da epiderme (1º grau), epiderme e derme (2º grau) ou toda a espessura da pele (3º grau), usualmente vistas em quedas, atropelamentos, etc, caracterizam a:

- a) Ferida incisa.
- b) Ferida punctória.
- c) Ferida contusa tipo equimose.
- d) Ferida contusa tipo escoriação.
- e) Ferida contusa tipo bossas e hematomas.

Gabarito: D



Comentário:

- a) Incorreta. A ferida incisa é produzida por instrumentos cortantes através de deslizamento de gume, com bordas regulares e sangramento abundante, não por atrito.
- b) Incorreta. A ferida punctória é produzida por instrumentos perfurantes, com formato em ponto e profundidade maior que extensão.
- c) Incorreta. A equimose é o extravasamento de sangue nas malhas teciduais sem ruptura da pele, não envolvendo remoção de camadas cutâneas.
- d) Correta. A escoriação é o tipo de lesão que apresenta arrancamento das camadas da pele por ação tangencial contundente, geralmente vista em quedas, atropelamentos e atrito por deslizamento. Pode atingir apenas a epiderme (escoriação típica), ou ultrapassar para a derme (escoriação atípica), com a profundidade definindo as características da crosta formada, apresentando-se branca amarelada (de conteúdo seroproteico), é sinal de que as papilas dérmicas não foram lesionadas (escoriação típica). Já a cor amarronzada (devido a presença de conteúdo sanguíneo — hemático) remete à secção das papilas dérmicas (escoriação atípica).
- e) Incorreta. Bossas e hematomas envolvem coleção de líquido ou sangue, não remoção de camadas da pele por atrito.

50. 4000955073 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) As lesões complexas ou mistas são geralmente causadas por um instrumento cujas características de atuação têm mais de um mecanismo de lesão. Por exemplo, lesões causadas por punhais, estiletes, facas e similares, caracterizam uma lesão por:

- a) Instrumento corto-contundente, produzindo lesão corto contusa.
- b) Instrumento perfuro-contundente, produzindo lesão perfuro contusa.
- c) Instrumento contundente, produzindo fraturas e luxações.
- d) Instrumento perfurocortante, produzindo lesão perfuro incisa.
- e) Instrumento contundente, produzindo hematomas e equimoses.

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. Instrumentos cortocontundentes (foice, machado, facão) atuam por combinação de corte e contusão, não correspondendo a punhais e estiletes (perfurocortantes).
- b) Incorreta. Instrumentos perfurocontundentes (projétil de arma de fogo, vergalhão) atuam perfurando e contundindo, com características diferentes de facas e punhais.



- c) Incorreta. Instrumentos contundentes não possuem ponta nem gume, produzindo fraturas e luxações por pressão ou percussão.
- d) Correta. Punhais, estiletes e facas são exemplos clássicos de instrumentos perfurocortantes, que atuam simultaneamente por pressão (perfurando com a ponta) e deslizamento (cortando com o gume). A lesão produzida é a perfuroincisa, com bordas regulares e profundidade prevalecendo sobre extensão.
- e) Incorreta. Esses instrumentos não são meramente contundentes, possuem ponta e gume que caracterizam a ação perfurocortante.

51. 4002424822 (FGV - Of Inv Pol (PC PI)/PC PI/2026) Os agentes vulnerantes são classificados de acordo com seu mecanismo de ação. As energias de ordem física causam grande parte das lesões observadas no cotidiano das investigações e perícias. Sobre os tipos de ferimentos encontrados, assinale a opção correta.

- a) As lesões causadas por objetos perfurantes causam sangramento intenso.
- b) As feridas causadas por projéteis de arma de fogo têm a largura proporcional à profundidade.
- c) Objetos perfurantes de calibre médio podem causar feridas com aspecto de casa de botão.
- d) As feridas com aspecto de casa de botão só podem ser causadas por objetos perfurocortantes de dois gumes.
- e) Objetos cortantes são capazes de causar desarticulação de um membro.

Gabarito: C

Comentários:

- a) Incorreta. Objetos perfurantes produzem abertura cutânea pequena, por isso o sangramento externo costuma ser discreto.
- b) Incorreta. Nos projéteis de arma de fogo, a ferida de entrada é pequena e o trajeto interno pode ser muito extenso, portanto a largura não é proporcional à profundidade.
- c) Correta. Objetos perfurantes de calibre médio, como estiletes ou facas de lâmina estreita, podem produzir a ferida em "casa de botão" (abertura elíptica, pequena e regular na pele).
- d) Incorreta. A ferida em casa de botão não é exclusividade dos perfurocortantes de dois gumes; Lembre-se da 1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança): as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão".
- e) Incorreta. A desarticulação de membros é característica dos instrumentos corto-contusos (como o machado), porém muitos autores incluem ferimentos especiais como degolamento (que



desarticula a cabeça do restante do corpo) como uma lesão incisa, causada por instrumento cortante.

52. 4002429623 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Odontologista/2026) Quando ocorre tracionamento e contusão que distendem ligamentos, mas sem perda do contato articular, a lesão é classificada como

- a) fratura.
- b) luxação.
- c) entorse.
- d) ruptura visceral.
- e) equimose.

Gabarito: C

Comentários:

- a) Incorreta. A fratura compromete a continuidade óssea, não os ligamentos articulares.
- b) Incorreta. A luxação é o deslocamento permanente e repentino de superfícies articulares, perdendo-se o alinhamento normal das peças que se articulam e provocando ruptura capsular.
- c) Correta. A entorse acontece quando se ultrapassa a amplitude normal dos movimentos articulares, geralmente em decorrência de forças externas, causando o estiramento da cápsula de uma articulação. Nesses casos, as extremidades ósseas da articulação afastam-se temporariamente e, em seguida, retornam às suas relações normais. Portanto, incide sobre os ligamentos, podendo haver ruptura ou não, porém sem chegar à luxação.
- d) Incorreta. Ruptura visceral envolve órgãos internos.
- e) Incorreta. Equimose é extravasamento de sangue para o tecido subcutâneo, não uma lesão articular.

53. 4002428705 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Psiquiatria/2026) Durante uma briga em via pública, um homem é golpeado na região frontal da cabeça por um bastão de madeira de superfície larga. No atendimento pericial, observa-se no local do impacto uma lesão aberta, de forma estrelada, com bordas irregulares, escoriadas e levemente equimosadas, presença de pontes de tecido íntegro entre as margens e pouco sangramento. O fundo da lesão é irregular, mas apresenta vasos e estruturas profundas preservadas, e os ângulos da ferida tendem à obtusidade. Considerando o mecanismo da agressão e as características morfológicas descritas, o tipo de lesão apresentada é denominada



- a) equimose.
- b) ferida punctória.
- c) ferida contusa.
- d) rubefação.
- e) escoriação

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. Equimose é apenas o extravasamento hemorrágico subcutâneo, sem abertura da pele.
- b) Incorreta. A ferida punctória é produzida por instrumento perfurante de pequeno calibre, com orifício puntiforme e regular, incompatível com a descrição estrelada e de bordas irregulares.
- c) Correta. A ferida contusa resulta do impacto de objeto de superfície larga e irregular, como um bastão de madeira. Suas características clássicas são exatamente as descritas: forma estrelada, bordas irregulares e escoriadas, presença de pontes de tecido íntegro entre as margens, pouco sangramento, fundo irregular e ângulos tendendo à obtusidade.



Fonte: AVELAR, Luiz Eduardo T.; BORDONI, Leonardo S.; CASTRO, Marcelo Mari de. Atlas de medicina legal. Rio de Janeiro: MedBook Editora, 2014.

- d) Incorreta. A rubefação é apenas um eritema superficial por hiperemia local, sem abertura da pele.
- e) Incorreta. A escoriação é uma lesão superficial que acomete apenas a epiderme, sem a profundidade e as características morfológicas descritas.

54. 4002429436 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Patologia/2026) As lesões perforantes de médio calibre deixam feridas fusiformes características na pele, e que seguem as Leis de Filhos e de Langer. Assim sendo, duas lesões desse tipo, nas regiões lateral e posterior do pescoço, deixam, respectivamente, feridas com o seu sentido (maior eixo) dirigido pelas seguintes estruturas:

- a) Músculo esternocleidomastóideo e músculo trapézio
- b) Artéria carótida e músculo grande dorsal
- c) Plano horizontal e plano sagital
- d) Músculo platisma e músculos hióideos
- e) Eixo vertical e coluna vertebral cérvico-dorsal

Gabarito: A

Comentário:

A questão explora as Leis de Filhos e de Langer, que estabelecem que feridas fusiformes produzidas por instrumentos perforantes seguem a orientação das linhas de tensão da pele, as quais por sua vez acompanham a direção das fibras musculares subjacentes. Na região lateral do pescoço, o músculo de maior influência sobre essas linhas de tensão é o esternocleidomastóideo, que determina o sentido oblíquo da ferida. Na região posterior do pescoço, é o músculo trapézio que orienta essas linhas, determinando o sentido da lesão.

- b) Incorreta. A artéria carótida e o grande dorsal não determinam as linhas de tensão cutânea nessas regiões.
- c) Incorreta. Os planos horizontal e sagital são referências anatômicas, não estruturas que condicionem as linhas de Langer.
- d) Incorreta. O platisma e os músculos hióideos não são os principais determinantes das linhas de tensão nessas localizações específicas.
- e) Incorreta. O eixo vertical e a coluna cervical não correspondem à orientação das linhas de tensão nas regiões lateral e posterior do pescoço conforme descrito.

55. 4002429437 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Patologia/2026) Um exame cadavérico revela uma ferida alongada, fusiforme, com bordas lisas e extremidades agudas, com comprimento superior à profundidade, muito sangrante, com cauda de escoriação longa em uma das extremidades. Lesões dessa natureza são produzidas por ações do tipo

- a) perfurante de médio calibre.
- b) perfurocortante de um gume.



- c) cortante.
- d) cortocontundente
- e) perfurocortante de dois gumes

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. As feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (pérfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão" (1ª Lei de Filhos - Lei da Semelhança).
- b) Incorreta. O instrumento perfurocortante de um gume produz ferida com formato ovalado, com uma borda arredondada e outra aguda (o gume fica voltado para a borda aguda).
- c) Correta. O instrumento cortante (como uma faca ou navalha atuando de forma deslizante) produz ferida alongada, fusiforme, com bordas lisas, extremidades agudas, comprimento superior à profundidade, sangramento abundante (por seccionar vasos sem os comprimir) e, quando há movimento de arrastamento, uma cauda de escoriação em uma das extremidades.



Fonte: França, Genival Veloso D. Medicina Legal, 11ª edição. 2017. Ferida produzida por meio cortante (cauda de escoriação voltada para baixo).

- d) Incorreta. O instrumento cortocontundente produz lesões com bordas irregulares e escoriadas.
- e) Incorreta. As lesões produzidas por instrumento de dois gumes possuem formato de fenda ou de botoeira, com ângulos bastante agudos. Centralmente, o afastamento das bordas apresenta-se maior, sendo menor à medida que se aproxima dos ângulos.

56. 4001947013 (FGV - Med Leg (PC MG)/PC MG/2025) Sobre as lesões causadas por objetos perfurantes, que apresentam características diferentes de acordo com o calibre do mesmo, assinale a afirmativa correta

- a) Todas as lesões produzidas por objetos perfurantes têm formato de casa de botão
- b) As leis de Filhos e Langer se reportam apenas a objetos perfurantes de calibre médio.
- c) As lesões causadas por objetos perfurocortantes obedecem à lei do paralelismo (Lei do Paralelismo).
- d) As lesões causadas por objetos cortocontundentes podem ter aspecto de ponta de seta ou de quadrilátero.
- e) De acordo com a primeira lei de Filhos, as lesões causadas por instrumentos de pequeno calibre tendem a ser semelhantes entre si (Lei da Semelhança).

Gabarito: B

Comentários:

a) Incorreta. Apenas os objetos perfurantes de calibre médio produzem ferida em casa de botão. Os de pequeno calibre geram lesão puntiforme e os de grande calibre produzem lesões com bordas irregulares.

b) Correta. As Leis de Filhos e Langer se aplicam especificamente aos objetos perfurantes de calibre médio, que produzem feridas fusiformes orientadas pelas linhas de tensão da pele.

1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança): as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes (perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão".

2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo): quando as feridas se localizam na mesma região do corpo que possua as linhas de força dispostas em uma só direção, seu maior eixo tem sempre a mesma direção.

Lei de Langer (Lei do Polimorfismo ou da Elasticidade): Nas regiões em que ocorre cruzamento (convergência ou confluência) de fibras de sentidos diferentes, as extremidades da lesão assumem um aspecto de ponta de seta, de triângulo ou até de quadrilátero.

c) Incorreta. São as lesões causadas por objetos perfurantes de calibre médio que obedecem à Lei do Paralelismo, ou seja, duas lesões paralelas tendem a ser semelhantes entre si.

d) Incorreta. As lesões em ponta de seta ou quadrilátero são características dos objetos perfurantes de grande calibre, não dos cortocontundentes.

e) Incorreta. A primeira Lei de Filhos estabelece que as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às geradas por instrumentos de dois gumes



(perfurocortantes), apresentando o formato de "casa de botão". A semelhança entre lesões paralelas corresponde à Lei do Paralelismo, que integra as leis relativas ao calibre médio (e não pequeno).

57. 4001947015 (FGV - Med Leg (PC MG)/PC MG/2025) Sobre as características das lesões causadas por ação contundente, as mais frequentemente observadas na prática pericial, assinale a afirmativa correta.

- a) As bordas são regulares.
- b) A profundidade predomina sobre a largura.
- c) A extensão predomina sobre a profundidade.
- d) As bordas são invertidas na entrada e evertidas na saída.
- e) As bordas são irregulares com traves de tecido íntegro no fundo.

Gabarito: E

Comentários:

De acordo com França: Ferida contusa. Trata-se de lesões abertas cuja ação contundente foi capaz de vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles. São produzidas por compressão, pressão, percussão, arrastamento, explosão e tração. Como as feridas contusas são produzidas por meios ou instrumentos de superfície e não de gume, mais ou menos afiados, apresentam elas as seguintes características: forma estrelada, sinuosa ou retilínea bordas irregulares, escoriadas e equimosadas fundo irregular vertentes irregulares pontes de tecido íntegro ligando as vertentes retração das bordas da ferida pouco sangrantes, integridade de vasos, nervos e tendões no fundo da lesão ângulo tendendo à obtusidade.

- a) Incorreta. As bordas nas lesões contusas são irregulares, escoriadas e equimosadas.
- b) Incorreta. Nas lesões contusas a extensão supera a profundidade.
- c) Incorreta. Embora a extensão realmente predomine sobre a profundidade nas lesões contusas, essa alternativa está incompleta, portanto a banca a considerou incorreta pela banca.
- d) Incorreta. Bordas invertidas na entrada e evertidas na saída são características das feridas produzidas por projéteis de arma de fogo, não de lesões contusas.
- e) Correta. A característica mais marcante e diagnóstica das feridas contusas é justamente a irregularidade das bordas associada à presença de traves ou pontes de tecido íntegro no fundo da lesão, resultantes da ação do instrumento de superfície larga que não secciona completamente os tecidos.



58. 4001522823 (FGV - Del Pol (PC SC)/PC SC/2024) No dia 05/11/2023, Miguel conduzia seu veículo automotor dentro da velocidade permitida em determinada via pública de Blumenau quando, em certo momento, atingiu Jamiles, que atravessava a rua na faixa de pedestres, lesionando-a. Após o socorro médico, os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para lavratura do procedimento cabível.

No mesmo dia, por ocasião da realização da perícia pertinente, ficou comprovado que Jamiles estava com uma equimose de coloração amarelada, de formato circular, na região pélvica, medindo cerca de quarenta milímetros de diâmetro, além de apresentar fraturas cominutivas no terço médio do fêmur da perna esquerda, escoriações nos dois cotovelos e uma lesão cortocontusa na região da glabella.

Acerca dessas lesões constatadas em Jamiles, é correto afirmar que

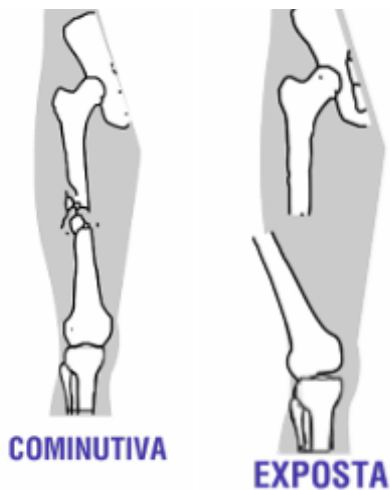
- a) as fraturas cominutivas são assim chamadas, pois apenas uma das suas duas partes fragmentadas é projetada para além de uma abertura da pele, razão pela qual também é compreendida como “fratura incompleta”.
- b) a lesão cortocontusa na glabella representa uma forma clássica do emprego de energia vulnerante de etiologia físico-química.
- c) a escoriação é representada pela literatura médico-legal como “lesão em acordeão ou sanfona”, com sangramento abundante, abertura estreita e de menor diâmetro de entrada em comparação com o agente vulnerante.
- d) a equimose percebida não guarda nexos de causalidade com o evento traumático referente ao acidente provocado por Miguel.
- e) a escoriação é representada pela literatura médico-legal como uma vasodilatação exclusivamente vital, causando o eritema, que é uma mancha avermelhada, efêmera e fugaz.

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. Fratura cominutiva é aquela em que o osso se fragmenta em múltiplos pedaços. A projeção de fragmentos para além da pele é característico de fratura exposta e fratura incompleta é quando não houve a solução de continuidade.





- b) Incorreta. A lesão cortocontusa na glabella decorre de energia vulnerante de etiologia mecânica, não físico-química. Energia físico-química estaria relacionada a agentes como o frio, o calor ou substâncias cáusticas.
- c) Incorreta. A lesão "Em acordeão" ou "em sanfona" (Lacassagne) ocorre quando a superfície do corpo é depressível, podendo produzir uma lesão mais profunda do que o próprio comprimento do instrumento.
- d) Correta. A equimose de coloração amarelada indica lesão em fase avançada de reabsorção, correspondendo a um trauma com pelo menos 12 dias de evolução, de acordo com o espectro equimótico de Legrand du Saulle. Com isso, o período é incompatível com o acidente ocorrido no mesmo dia da perícia. Portanto, essa equimose não guarda nexos causal com o evento descrito.
- e) Incorreta. A vasodilatação efêmera e a mancha avermelhada fugaz descrevem a rubefação, não a escoriação.

59. 4001015981 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/43 Classe/2022) Dependendo dos fatores envolvidos, principalmente a forma e força de agressão, existirão diversas modalidades de lesões com repercussões e consequências diferentes. Partindo dessa premissa, relacione a condição com suas respectivas particularidades:

1. Rubefação.
2. Escoriação.
3. Equimose.
4. Hematoma.
5. Esmagamento.

- () Congestão local passageira.
- () Coleção sanguínea localizada.
- () Síndrome de Crush.
- () Derrame sanguíneo na malha tecidual.
- () Exposição do córion.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

- A. 1, 4, 5, 3 e 2.
- B. 1, 4, 3, 5 e 2.
- C. 4, 1, 5, 3 e 2.
- D. 4, 1, 2, 5 e 3.
- E. 3, 4, 5, 2 e 1.

Gabarito: A

Comentários:

A correspondência correta é:

congestão local passageira → Rubefação (1);

coleção sanguínea localizada → Hematoma (4);

Síndrome de Crush → Esmagamento (5);

derrame sanguíneo na malha tecidual → Equimose (3);

exposição do córion → Escoriação (2), resultando na sequência 1, 4, 5, 3 e 2.

Vale reforçar as distinções: a rubefação é apenas uma hiperemia passageira sem extravasamento sanguíneo; a equimose é o extravasamento difuso de sangue pela malha tecidual sem formar coleção; o hematoma, ao contrário, forma uma coleção localizada e palpável; a escoriação expõe o córion (camada profunda da derme) pela remoção da epiderme; e o esmagamento, quando extenso, pode evoluir para a Síndrome de Crush, com liberação de mioglobina e comprometimento renal.

Algumas informações adicionais acerca da Síndrome de Crush (que era a opção mais difícil nessa questão):

A Síndrome de Crush (ou síndrome do esmagamento) é uma condição sistêmica grave que ocorre após a compressão prolongada dos músculos, geralmente em desabamentos ou



acidentes. Causa a destruição muscular (rabdomiólise) e a liberação de toxinas na corrente sanguínea, provocando insuficiência renal aguda, arritmias cardíacas e choque.

O trauma por esmagamento interrompe o fluxo sanguíneo local, causando a morte das células musculares. Quando a pressão é aliviada e o sangue volta a circular, o corpo é inundado por substâncias tóxicas:

Mioglobina: Proteína muscular que entope os rins, levando à falência renal aguda.

Potássio: Sua liberação maciça causa hipercalemia, que pode gerar paradas cardíacas fulminantes.

Ácido lático e Fosfato: Contribuem para uma acidose metabólica grave.

Sintomas e Sinais:

Urina escura: Cor de "coca-cola", devido à presença de mioglobina.

Inchaço e dor severa: O membro afetado fica inchado, duro e sem pulso, caracterizando também a síndrome compartimental.

Alterações sistêmicas: Queda de pressão (choque), fraqueza muscular e confusão mental.

60. 4001015997 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) No estudo das energias de ordem mecânica, a classificação médico-legal dos agentes pressupõe, invariavelmente, como primeira etapa, a análise da lesão para sua denominação. A literatura científica referencia que os arcos dentários humanos podem produzir vários tipos de feridas. Segundo Arbenz (1988) a dinâmica da mordida é habitualmente classificada como instrumento do tipo

- a) perfurante.
- b) contundente.
- c) corto-contundente.
- d) cortante.
- e) perfuro-contundente,

Gabarito: C

Comentários:

a) Incorreta. O instrumento perfurante atua em profundidade por meio de ponta, incompatível com a dinâmica da mordida.

b) Incorreta. O instrumento contundente age por pressão em superfície larga, incompatível com a dinâmica da mordida.



- c) Correta. Segundo Arbenz, a mordida humana é classificada como instrumento cortocontundente porque os arcos dentários combinam ação cortante (bordas dos dentes) com ação contundente (pressão e esmagamento), produzindo lesões com bordas irregulares, escoriadas e equimосadas características desse mecanismo.
- d) Incorreta. O instrumento cortante age por deslizamento de gume afiado, produzindo bordas lisas e regulares, incompatível com a dinâmica da mordida..
- e) Incorreta. O instrumento perfurocontundente combina perfuração e contusão, como projéteis de arma de fogo, incompatível com a dinâmica da mordida.

61. 4001016429 (FGV - Per Leg (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Armas brancas podem produzir feridas de diferentes tipos, a depender da atuação de outros componentes. Quando a ferida é produzida por meio do deslizamento da lâmina sobre o tecido, seccionando vasos sanguíneos e causando hemorragia volumosa, ela é denominada

- a) contusa.
- b) corto-contusa.
- c) perfuro-contusa.
- d) cortante.
- e) perfurante,

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. A ferida contusa resulta da ação de instrumento contundente por pressão ou choque, com bordas irregulares e pontes de tecido no fundo.
- b) Incorreta. A ferida cortocontusa é produzida por instrumentos que combinam gume e massa considerável (como machado ou facão), com bordas escoriadas e ação predominantemente contundente, não por deslizamento de lâmina.
- c) Incorreta. A ferida perfurocontusa resulta da ação de instrumentos que perfuram e contundem simultaneamente, como o projétil de arma de fogo.
- d) Correta. A lesão produzida por instrumento cortante, denominada ferida incisa, resulta exatamente do mecanismo descrito: deslizamento do gume sobre o tecido, seccionando as fibras e os vasos sanguíneos, com sangramento abundante, bordas regulares e comprimento prevalecendo sobre a profundidade.
- e) Incorreta. O instrumento perfurante age por pressão de uma ponta, afastando os tecidos sem seccioná-los, produzindo lesão punctória com pouco sangramento.



62. 4001016069 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Entre as lesões contusas superficiais causadas por ação física mecânica, temos a equimose. Na sufusão ocorre a transformação química da hemoglobina fora do vaso, determinando a mudança cromática no tecido traumatizado. Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, indique a sequência de cores no processo evolutivo dessa lesão.

- a) Vermelho-violáceo, avermelhado, azulado, esverdeado e amarelado.
- b) Avermelhado, azulado, vermelho-violáceo, esverdeado e amarelado.
- c) Avermelhado, azulado, esverdeado, vermelho-violáceo e amarelado.
- d) Avermelhado, vermelho-violáceo, azulado, esverdeado e amarelado.
- e) Vermelho-violáceo, avermelhado, esverdeado, azulado e amarelado

Gabarito: D

Comentário:

COR	GENIVAL VELOSO DE FRANÇA	HÉLIO GOMES	HERMES DE ALCÂNTARA	LEGRAND DU SAULLE
VERMELHA	1º DIA	1º DIA	1º ao 3º DIA	1º ao 2º ao 3º DIA
VIOLÁCEA-AZULADA	2º ao 6º DIA	2º ao 6º DIA	4º ao 6º DIA	2º ao 3º ao 4º ao 6º DIA
ESVERDEADA	7º ao 12º DIA	7º ao 10º DIA	7º ao 12º DIA	4º ao 6º ao 7º ao 10º DIA
AMARELADA	13º ao 17º DIA	11º ao 20º DIA	13º ao 22º DIA	12º DIA

- a) Incorreta. A sequência não começa com vermelho-violáceo; a cor inicial é o avermelhado, correspondente ao primeiro dia.
- b) Incorreta. Do azulado não se retorna ao vermelho-violáceo; a marcha é progressiva e não admite retorno a tonalidades anteriores.
- c) Incorreta. Do esverdeado não se retorna ao vermelho-violáceo pela mesma razão, a sequência cromática é sempre progressiva.
- d) Correta. De acordo com o espectro equimótico de Legrand du Saulle, a sequência é: avermelhado (1º dia) → vermelho-violáceo (2º ao 3º dia) → azulado (4º ao 6º dia) → esverdeado (7º ao 10º dia) → amarelado (a partir do 12º dia), desaparecendo entre o 15º e o 20º dia.
- e) Incorreta. Inverte a ordem entre vermelho-violáceo e avermelhado e coloca o esverdeado antes do azulado.



63. 4001007177 (FGV - Del Pol (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) O conhecimento das características das feridas é fundamental para que a Autoridade Policial compreenda a dinâmica dos eventos criminosos que causam lesões corporais. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de ferida elencada às suas características.

- a) Ferida contusa: apresenta bordas regulares e fundo com traves de tecido íntegro.
- b) Ferida corto-contusa: é produzida por objetos que têm massa e gume e tem bordas regulares.
- c) Ferida perfuro-contusa: é causada exclusivamente por projéteis de arma de fogo.
- d) Ferida perfuro-cortante: apresenta grande profundidade sem sangramento, pois é causada pelo afastamento dos tecidos.
- e) Ferida cortante: tem profundidade maior do que a extensão, independente de ter um ou mais gumes.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. A ferida contusa apresenta bordas irregulares, denteadas e escoriadas. As traves de tecido íntegro no fundo são características corretas.
- b) Correta. O instrumento cortocontundente possui massa e gume simultaneamente, atuando por corte e contusão ao mesmo tempo. As bordas da ferida resultante são retas e afastadas, mas com certo grau de escoriação; quanto mais afiado o gume, mais regulares serão as bordas, aproximando-se das características de uma ferida incisa.
- c) Incorreta. A ferida perfurocontusa não é causada exclusivamente por projéteis de arma de fogo. Outros exemplos de instrumentos perfurocontundentes incluem dentes caninos de animais, vergalhões, pontas de grade de ferro e canetas esferográficas.
- d) Incorreta. A ferida perfuroincisa (produzida por instrumento perfurocortante) tem profundidade prevalecendo sobre a extensão, mas não é caracterizada por ausência de sangramento. O sangramento pode ser intenso internamente, mesmo que escasso externamente. Além disso, o afastamento de tecidos é mecanismo dos perfurantes, não dos perfurocortantes, que também cortam.
- e) Incorreta. Na ferida cortante (incisa), o comprimento é que prevalece sobre a profundidade, não o contrário. A profundidade maior que a extensão é característica das feridas perfuroincisas.

64. 4001016077 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Após uma contusão aparece uma lesão superficial do tipo equimose que pode assumir diversas formas no tecido. Partindo dessa premissa, relacione a lesão com suas respectivas características.



1. Forma de lençóis.
2. Forma de estriações.
3. Forma de grãos de areia sobre uma área.
4. Forma de pontos de 1mm ou mais de diâmetro.

- () Sufusões.
() Sugilações.
() Petéquias.
() Víbices.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

- a) 1,2,3 e 4.
- b) 1,4,3 e 2.
- c) 2,1,3 e 4.
- d) 4,1,2 e 3.
- e) 1,3,4 e 2.

Gabarito: E

Comentários:

A correspondência correta é:

forma de lençóis → Sufusões (1);

forma de grãos de areia sobre uma área → Sugilações (3);

forma de pontos de 1 mm ou mais de diâmetro → Petéquias (4);

forma de estriações → Víbices (2), resultando na sequência 1, 3, 4 e 2.

Vale reforçar as distinções:

as sufusões são grandes áreas de infiltração sanguínea em formato de lençol;

as sugilações apresentam-se como pequenos grãos agrupados em área delimitada, frequentemente associadas a atos libidinosos;

as petéquias são pontos puntiformes do tamanho da cabeça de um alfinete, geralmente agrupadas;

e as víbices têm formato de estrias ou linhas, comumente produzidas por objetos cilíndricos.



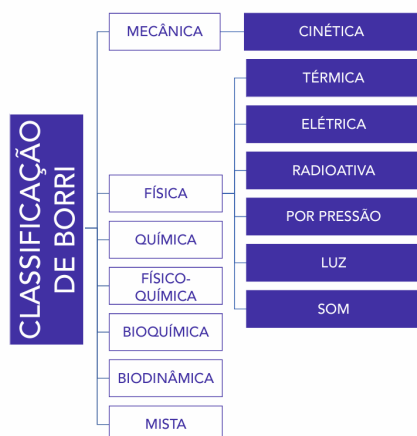
65. 4001274509 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) A Traumatologia Forense estuda as lesões e as condições patológicas, imediatas ou tardias, decorrentes da violência sobre o corpo humano, nas perspectivas do diagnóstico, do prognóstico e das suas consequências, sobretudo, legais. Considerando que tal estudo inclui a análise das diversas modalidades de energias causadoras de danos, assinale a afirmativa correta.

- a) Lesão é a denominação dada à alteração morfológica ou funcional do corpo humano no local em que ocorreu transferência de energia.
- b) Os agentes lesivos podem ser divididos em instrumentos e meios, sendo esses últimos exemplificados pelos objetos ou estruturas que transferem energia cinética (mecânica).
- c) Energias sonoras, elétricas, térmicas e radioativas são exemplos de energia de ordem química.
- d) As asfixias consistem na modalidade de energia de ordem biodinâmica.
- e) A fadiga e a inanição representam, respectivamente, as energias de ordem bioquímica e mista.

Gabarito: A

Comentário:

- a) Correta. Lesão é a alteração morfológica ou funcional resultante de uma agressão ao organismo mediante transferência de energia. Pode ser visível macro ou microscópicamente, no local em que ocorreu a transferência.
- b) Incorreta. A definição está invertida. Os instrumentos são os objetos ou estruturas que transferem energia cinética (mecânica), enquanto os meios correspondem às formas de energia não cinética, como a eletricidade ou o calor.
- c) Incorreta. Energias sonoras, elétricas, térmicas e radioativas são exemplos de energia de ordem física, conforme a Classificação de Borri.



d) Incorreta. As asfixias consistem em modalidade de energia de ordem físico-química.

e) Incorreta. Fadiga caracteriza-se pela instabilidade orgânica originada por um conjunto de alterações bioquímicas, biofísicas e psíquicas, podendo ser aguda ou crônica (exemplo: Síndrome de Burnout ou do Esgotamento Profissional). Portanto, a fadiga é a energia de ordem mista. A energia mista produz lesões ou até a morte em que há o envolvimento da ação conjunta das energias bioquímica e biodinâmica. Já a inanição refere-se a privação do corpo de alimentação adequada, causando o impedimento do metabolismo e desenvolvimento adequado. Pode ser aguda ou crônica, acidental (exemplo: abandono) ou voluntária (exemplo: greve de fome). Refere-se a energia de ordem bioquímica.

66. 4001274510 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) Cerca de 80% das perícias traumatológicas realizadas nos institutos oficiais de perícia são decorrentes de violência por instrumentos contundentes. Diante da importância do estudo desses agentes, relacione as lesões produzidas por eles às suas respectivas definições.

1. Rubefação
2. Hematoma
3. Equimose
4. Escoriação
5. Bossa

() Coleção sanguínea, localizada, formada pelo rompimento de vasos de grande ou médio calibre. Além de superficial, pode acontecer em profundidade, em massa de órgãos ou em espaços teciduais (retroperitônio, mediastino).

() Ocasionado pela vasodilatação no local da transferência de energia mecânica, guardando a assinatura do instrumento, porém de duração efêmera.

() Produzida pelo acúmulo de líquido linfático ou de sangue, quando a região do corpo atingida apresenta um plano subjacente resistente e impermeável.

() Sufusão hemorrágica difusa decorrente da infiltração tecidual de sangue extravasado pelo rompimento de vasos.

() Resultante da ação tangencial do instrumento que ocasiona o arrancamento da epiderme. Sua forma pode indicar o instrumento que a produziu. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

a. 3 – 1 – 5 – 2 – 4.

B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.



C. 2 – 1 – 5 – 3 – 4.

D. 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

E. 2 – 5 – 1 – 4 – 3.

Gabarito: C

Comentário:

A correspondência correta é:

coleção sanguínea localizada por rompimento de vasos de médio ou grande calibre → Hematoma (2);

vasodilatação efêmera com assinatura do instrumento → Rubefação (1);

acúmulo de líquido linfático ou sanguíneo sobre plano ósseo subjacente → Bossa (5);

sufusão hemorrágica difusa por infiltração tecidual → Equimose (3);

arrancamento tangencial da epiderme com forma indicativa do instrumento → Escoriação (4),
resultando na sequência 2, 1, 5, 3 e 4.

Vale reforçar as distinções mais cobradas: na equimose o sangue infiltra-se difusamente pelas malhas do tecido, enquanto no hematoma ele se acumula em uma cavidade neoformada, sendo passível de drenagem. A bossa diferencia-se do hematoma por assentar sobre plano ósseo subjacente e por não haver rotura de vasos, sendo preenchida por linfa (bossa serosa) ou sangue (bossa sanguínea).

67. 4001274514 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

() Blast Injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica, lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.

() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou ântero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,



- A. F, V e V.
- B. V, F e F.
- C. F, F e F.
- D. V, F e V.
- E. V, V e V.

Gabarito: D

Comentário:

Primeira afirmativa — Verdadeira. De acordo com Vanrell: As lesões decorrentes da explosão (blast injury) encontram-se em relação com a proximidade das pessoas ao local do evento, ao local em que a explosão se deu e à potência da carga explosiva. Trata-se, em todos os casos, de lesões contusas generalizadas, de grande extensão, a que podem acrescer-se queimaduras de graus diversos em face da deflagração do explosivo.

Segunda afirmativa — Falsa. O degolamento é a ferida localizada na região posterior do pescoço (lembre-se da gola da camisa), enquanto o esgorjamento ocorre na região anterior e/ou lateral, podendo lesar estruturas como laringe, traqueia, esôfago e vasos carotídeos.

Terceira afirmativa — Verdadeira. A lesão em "buraco de fechadura" é um traumatismo craniano tangencial produzido por projétil de arma de fogo com inclinação mínima suficiente para penetrar na calota craniana, deixando um sulco ou canal característico.

68. 4001015976 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Em termos conceituais, a traumatologia forense estuda os traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Sabendo-se que o trauma é resultado da ação vulnerante que possui energia capaz de produzir a lesão, correlacione a energia/ordem (causa) com seu respectivo sinal (efeito) sobre o corpo humano.

1. Ordem Mecânica.

2. Ordem Elétrica.

3. Ordem Térmica.

() Escara negra.

() Bossa linfática.

() Sinal de Lichtenberg.

() Sinal de Chambert positivo.



() Sinal de Jellinek.

() Sinal de Bonnet.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

A. 3, 1, 2, 3, 2 e 1.

B. 3, 2, 1, 3, 1 e 2.

C. 2, 1, 2, 1, 3 e 3.

D. 3, 1, 2, 1, 2 e 3.

E. 1, 2, 3, 2, 3 e 1.

Gabarito: A

Comentário:

A correspondência correta é:

escara negra → Ordem Térmica (3);

bossa linfática → Ordem Mecânica (1);

Sinal de Lichtenberg → Ordem Elétrica (2);

Sinal de Chambert positivo → Ordem Térmica (3);

Sinal de Jellinek → Ordem Elétrica (2);

Sinal de Bonnet → Ordem Mecânica (1), resultando na sequência 3, 1, 2, 3, 2 e 1.

Alguns esclarecimentos importantes:

a escara negra é a lesão cutânea carbonizada de origem térmica;

a bossa linfática (bossa serosa) resulta de trauma contundente mecânico sobre região com plano ósseo subjacente;

o Sinal de Lichtenberg é o padrão dendrítico em samambaia produzido por descarga elétrica de raio;

o Sinal de Chambert positivo é caracterizado por bolhas provocadas pelas queimaduras. Como são reações vitais, apresentam líquido seroso com conteúdo leucocitário, proteico, principalmente albumina, e cloretos (Sinal de Chambert positivo), podendo ter coloração que varia do "límpido" ao amarelo-citrino. ;

o Sinal de Jellinek indica o local de entrada da corrente elétrica no corpo, geralmente na pele ou em mucosa. Essa marca se apresenta como uma lesão arredondada ou elíptica, tenta imitar a forma do condutor, com contornos nítidos, de coloração acinzentada, castanha ou rósea, de



consistência endurecida ao tato e com centro encovado/em baixo relevo (bordas altas e centro deprimido);

e o Sinal (funil) de Bonnet refere-se a alteração no osso do crânio que permite identificar o orifício de entrada do tiro.

69. 4001281245 (FGV - Tec Per (PCA AP)/PCA AP/Biomédico/2022) No que tange aos exames no âmbito da Medicina Legal, assinale a afirmativa incorreta.

a) Instrumentos perfuro-contundentes são aqueles que atuam por meio de uma ponta romba, por pressão, e produzem lesão em forma de túnel. São exclusivamente representados pelos projéteis de arma de fogo.

b) Instrumentos perfurantes são os que transferem sua energia cinética por meio de uma ponta, pressionando e afastando os elementos dos tecidos. O modo de ação dos instrumentos perfurantes está implícito em sua conceituação: a ponta atua por pressão e vai afastando as fibras dos tecidos à medida que se faz a penetração da haste.

c) Instrumentos cortantes são os que transferem sua energia cinética por deslizamento e leve pressão através de uma borda aguçada a que se dá o nome de gume ou fio. Qualquer objeto provido de gume pode atuar como instrumento cortante, sendo exemplos a navalha, cacos de vidro, folhas metálicas e até mesmo folhas de papel.

d) Instrumentos perfuro-cortantes são os que transferem sua energia cinética por pressão, através de uma ponta, e por deslizamento, por meio de um ou mais gumes que seccionam as fibras dos tecidos.

e) Instrumentos cortocontundentes são os que, dotados de grande massa, transferem sua energia por meio de um gume. Ao contrário dos instrumentos cortantes, que atuam mais por deslizamento, os cortocontundentes agem principalmente por pressão. O gume força os tecidos perpendicular ou obliquamente, penetra e abre caminho para a cunha que constitui o instrumento.

Gabarito: A

Comentário:

Queremos a afirmativa ERRADA.

a) Incorreta. Os instrumentos perfurocontundentes não são exclusivamente representados pelos projéteis de arma de fogo. Outros exemplos incluem dentes caninos de animais, vergalhões, pontas de grade de ferro, canetas esferográficas e pontas de guarda-chuva.



- b) Correta. Os instrumentos perfurantes transferem energia cinética por meio de uma ponta que pressiona e afasta as fibras dos tecidos progressivamente à medida que a haste penetra, sem seccioná-las, com consequente pouco sangramento externo, resultando em lesão punctória.
- c) Correta. Os instrumentos cortantes atuam por deslizamento de um gume sobre o tecido com leve pressão, seccionando as fibras. Qualquer objeto provido de borda aguçada pode exercer essa função, como navalhas, cacos de vidro, folhas metálicas e até papel.
- d) Correta. Os instrumentos perfurocortantes combinam os dois mecanismos: a ponta perfura por pressão e o gume (um ou mais) corta por deslizamento, seccionando as fibras dos tecidos e produzindo a lesão perfuroincisa.
- e) Correta. Os instrumentos cortocontundentes possuem massa considerável e transferem energia por meio de um gume que age principalmente por pressão perpendicular ou oblíqua, forçando e abrindo os tecidos, ao contrário dos cortantes, que dependem fundamentalmente do deslizamento do gume.

70. 4001272806 (FGV - Aux TP (PCA AP)/PCA AP/Técnico em Agrimensura/2022) No que tange aos exames no âmbito da medicina legal, em relação às contusões, assinale a afirmativa incorreta.

- a) A rubefação é a lesão mais simples das produzidas por ação contundente.
- b) A tumefação é causada por um trauma mais intenso e se traduz por elevação e palidez da pele na área do impacto.
- c) A equimose é a infiltração do sangue nas malhas dos tecidos e, em geral, deve-se à rotura de capilares, vênulas e arteríolas, mas pode se formar também por diapedese.
- d) As equimoses são resultantes de lesões apenas superficiais, e, portanto, não podem ser profundas nem viscerais.
- e) A equimose é chamada de petéquia, sugilação ou sufusão de acordo com a sua forma.

Gabarito: D

Comentário:

Queremos a afirmativa ERRADA.

- a) Correta. A rubefação é a lesão mais simples produzida por ação contundente, resultando de vasodilatação por liberação de histamina, de caráter efêmero e sem extravasamento sanguíneo.
- b) Correta. A tumefação (edema traumático) ocorre por acúmulo de líquido intersticial após trauma mais intenso, manifestando-se como elevação e palidez da pele na área afetada, sem rompimento de vasos.



c) Correta. A equimose resulta da infiltração difusa de sangue nas malhas teciduais por rotura de vasos de pequeno calibre, podendo também formar-se por diapedese, que é a passagem das células sanguíneas através da parede íntegra dos vasos.

d) Incorreta. As equimoses não são restritas a lesões superficiais. Conforme a literatura, elas podem ser superficiais (tegumentos) ou profundas (massas musculares, vísceras e periósteo), sendo as equimoses viscerais exemplo clássico de equimoses profundas de grande relevância forense.

e) Correta. A equimose recebe denominações específicas conforme sua apresentação morfológica: petéquia (puntiforme, tamanho de cabeça de alfinete), sugilação (formato de grãos de areia agrupados) e sufusão (grande área em formato de lençol). As víbices, em formato de estrias, também integram essa classificação.

71. (FGV - Per (PC AM)/PC AM/42 Classe/Biologia/2022) Sabemos que a cronologia das lesões e o tempo de morte são estimados através de fenômenos cadavéricos e de decomposição de substâncias orgânicas.

O espectro equimótico de Legrand du Saulle corresponde

- a) ao depósito de sangue nos tecidos moles.
- b) à degradação da hemoglobina.
- c) ao início do estado de putrefação.
- d) ao estado de putrefação em fase avançada.
- e) à presença de mancha hipercrômica na esclera.

Gabarito: B

Comentário:

a) Incorreta. O depósito de sangue nos tecidos moles descreve o mecanismo de formação da equimose, não o espectro equimótico, que é o fenômeno subsequente de mudança de coloração.

b) Correta. O espectro equimótico de Legrand du Saulle corresponde à sequência de alterações cromáticas resultantes da degradação progressiva da hemoglobina extravasada nos tecidos. A hemoglobina se transforma em hemossiderina, biliverdina, bilirrubina e hematóidina, produzindo a sucessão de cores vermelha → violácea → azulada → esverdeada → amarelada, permitindo estimar o tempo da lesão.

c) Incorreta. O início da putrefação é um fenômeno cadavérico tardio, sem relação com o espectro equimótico, que é um fenômeno vital de degradação hemoglobínica.



d) Incorreta. A putrefação em fase avançada é um fenômeno cadavérico tardio, sem relação com o espectro equimótico, que é um fenômeno vital de degradação hemoglobínica.

e) Incorreta. A mancha hipercrômica na esclera não integra o espectro equimótico. As equimoses da conjuntiva ocular, inclusive, são uma exceção à marcha cromática, pois mantêm coloração avermelhada até a reabsorção completa, sem percorrer a sequência habitual.

72. 4001012800 (FGV - Per (PC AM)/PC AM/42 Classe/Biologia/2022) Lesões produzidas por meio de lâminas têm bordas regulares e podem ter profundidade significativa dependendo da massa do objeto.

Assinale a afirmativa correta sobre feridas corto-contusas encontradas no pescoço por um perito na cena de crime.

- a) Chama-se degola quando o ferimento é anterior.
- b) Quando o ferimento é na região posterior do pescoço, chama-se esgorjamento.
- c) Degola corresponde a decapitação.
- d) Chama-se degola quando o ferimento é lateral.
- e) Esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço.

Gabarito: E

Comentário:

- a) Incorreta. O degolamento ocorre na região posterior do pescoço (basta lembrar da gola da camisa, que assenta na nuca).
- b) Incorreta. O esgorjamento ocorre na região anterior e/ou lateral do pescoço (lembre-se da goela/garganta).
- c) Incorreta. A decapitação é a separação completa da cabeça do restante do corpo, conceito distinto do degolamento, que é apenas uma lesão na região posterior cervical.
- d) Incorreta. O degolamento é na região posterior, não lateral.
- e) Correta. O esgorjamento (do latim "gorja", que significa garganta) ocorre na região anterior e/ou lateral do pescoço, podendo lesar superficialmente a pele ou profundamente músculos, feixes vasculonervosos, esôfago, laringe e traqueia.

73. 4002371721 FUNDATEC - 2025 - Perito Médico-Legista (IGP RS) É correto afirmar que a Lei de Filhos e Langer pode:



- a) Determinar a distância do disparo de um projétil.
- b) Diferenciar uma ferida corto-contusa de uma contusa.
- c) Determinar a morfologia de um ferimento provocado por instrumento perfurante de médio calibre.
- d) Diferenciar uma lesão traumática in vitam ou post mortem.
- e) Determinar a dimensão da cavidade temporária e seu impacto nos órgãos internos, provocados por projéteis de alta

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. A distância do disparo é determinada pela análise dos efeitos primários e secundários do disparo, não pelas Leis de Filhos e Langer.
- b) Incorreta. A diferenciação entre ferida cortocontusa e contusa baseia-se nas características morfológicas das bordas e do fundo da lesão, não nas Leis de Filhos e Langer.
- c) Correta. As Leis de Filhos e Langer explicam a morfologia das feridas produzidas por instrumentos perfurantes de calibre médio. A 1ª Lei de Filhos estabelece que essas feridas assemelham-se às produzidas por instrumentos de dois gumes, com formato de "casa de botão". A 2ª Lei de Filhos determina que feridas na mesma região com linhas de força unidirecionais têm o maior eixo na mesma direção. A Lei de Langer completa, explicando o aspecto de ponta de seta ou quadrilátero nas regiões de convergência de fibras.
- d) Incorreta. O diagnóstico diferencial entre lesão ante mortem e post mortem baseia-se em critérios como reação inflamatória, coagulação sanguínea, formação de crosta e Índice de Verderau, não nas Leis de Filhos e Langer.
- e) Incorreta. A cavidade temporária e seus efeitos sobre órgãos internos são estudados no âmbito da balística terminal dos projéteis de alta velocidade, sem qualquer relação com as Leis de Filhos e Langer.

74. 4002371723 FUNDATEC - 2025 - Perito Médico-Legista (IGP RS) Considerando as características das lesões decorrentes de agentes mecânicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O extravasamento de sangue por diapedese pode ser um dos mecanismos pelos quais as sugilações são formadas.
- b) É possível diferenciar uma escoriação produzida em vida de uma post mortem, já que na post mortem observa-se coloração amarelado-acastanhada com aspecto semelhante a couro, apergaminhado.



c) Dependendo do mecanismo de aplicação de força, as unhas podem produzir tanto estigmas ungueais quanto faixas de escoriação, sendo que estas últimas decorrem predominantemente de deslizamento.

d) Livores podem ser diferenciados de equimoses já que aqueles se apresentam mais consistentes, com sangue coagulado e aderido aos tecidos; além disso, quando realizada incisão central, não ocorre extravasamento sanguíneo significativo, não sendo possível remover o sangue dos tecidos.

e) Dependendo da profundidade onde se formaram, as equimoses podem surgir até mesmo dias após o impacto, o que pode ser um fator confundidor para determinação de sua cronologia pelo método de Legrand Du Saulle.

Gabarito: D

Comentário:

Queremos a ERRADA.

a) Correta. As sugilações são equimoses com aspecto de grãos de areia agrupados, e podem formar-se tanto por rompimento de capilares quanto por diapedese, que é a passagem de hemácias através da parede vascular íntegra.

b) Correta. A escoriação post mortem apresenta coloração amarelado-acastanhada com aspecto apergaminhado e semelhante a couro, resultado da desidratação tecidual sem reação vascular, ao contrário da escoriação ante mortem, que forma crosta serosa ou hemática e é sinal exclusivo de vitalidade.

c) Correta. As unhas podem produzir estigmas ungueais (marcas em meia-lua resultantes de pressão perpendicular) ou faixas de escoriação lineares, sendo estas últimas decorrentes predominantemente do deslizamento das unhas sobre a pele.

d) Incorreta. A descrição está invertida em relação à equimose e ao livor. São os livores que apresentam sangue não coagulado dentro dos vasos, sem malhas de fibrina e sem infiltração tecidual, desaparecendo à digitopressão e dependendo da posição do cadáver. Já a equimose apresenta sangue fora dos vasos, coagulado, com malhas de fibrina e infiltração hemorrágica nos tecidos, não desaparecendo à pressão.

e) Correta. Equimoses profundas, formadas em massas musculares ou vísceras, podem levar dias para migrar à superfície e tornarem-se visíveis, o que pode induzir erro na estimativa cronológica pelo espectro de Legrand du Saulle, já que a coloração observada não corresponde necessariamente ao momento do trauma.

75. 4002378099 FUNDATEC - 2025 - Delegado de Polícia (PC RS) Um homem de 76 anos é encontrado morto em sua residência na zona rural. Ao exame necroscópico, o médico-legista



identificou extensa e profunda lesão em região temporal direita, de bordos pouco regulares, sem caudas, com fundo anfractuoso, com presença de edema traumático e equimose junto às margens e com fratura óssea e exposição do conteúdo encefálico. Considerando os agentes mecânicos envolvidos na traumatologia forense, o provável instrumento que provocou a lesão com consecutivo óbito foi um instrumento:

- a) Cortante.
- b) Perfurante.
- c) Corto-contundente.
- d) Perfurocontundente.
- e) Perfurocortante.

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. O instrumento cortante produz ferida incisa com bordas regulares, lisas e bem definidas, fundo limpo sem trabéculas e sangramento abundante.
- b) Incorreta. O instrumento perfurante produz lesão punctória de pequeno diâmetro, com profundidade maior que a extensão e pouco sangramento externo.
- c) Correta. O conjunto de características descrito é típico de instrumento cortocontundente. Esse tipo de instrumento, como o machado ou facão pesado, combina ação cortante e contundente, produzindo lesões de gravidade considerável, com bordas escoriadas, profundidade que atinge planos ósseos e traço de fratura que frequentemente copia o gume do instrumento.
- d) Incorreta. O instrumento perfurocontundente, cujo exemplo clássico é o projétil de arma de fogo, produz ferida com características específicas como orla de enxugo, zona de tatuagem e bordas invertidas.
- e) Incorreta. O instrumento perfurocortante produz ferida perfuroincisa com bordas regulares e profundidade prevalecendo sobre a extensão, sem o fundo anfractuoso, edema traumático nas margens e fratura óssea extensa.

76. 4001383624 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Durante uma autópsia, na região do abdome da vítima, foram encontrados ferimentos punctórios. Qual instrumento pode ter causado esses ferimentos?

- a) Porrete
- b) Agulha



- c) Facão
- d) Projétil expelido por arma de fogo
- e) Navalha

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. O porrete é instrumento contundente, produzindo lesões contusas como equimoses, hematomas e feridas contusas, não produz ferimentos punctórios.
- b) Correta. A agulha é exemplo clássico de instrumento perfurante de pequeno calibre, produzindo uma lesão punctória (puntiforme), caracterizada por orifício de diâmetro menor que 1 mm, pouco sangramento e profundidade maior que a extensão.
- c) Incorreta. O facão é um instrumento cortocontundente, que combina ação de gume e massa, produzindo lesões cortocontusas com bordas escoriadas e profundidade considerável.
- d) Incorreta. O projétil de arma de fogo é instrumento perfurocontundente, produzindo ferida perfurocontusa com características específicas (orifício de entrada, orla de enxugo, orla de escoriação, orla de equimose, zona de queimadura, zoba de esfumaçamento, zona de tatuagem, orifício de saída) que estudaremos no capítulo de Balística.
- e) Incorreta. A navalha é instrumento cortante, produzindo ferida incisa com bordas regulares, lisas e sangramento abundante.

77. 4001387908 IADES - 2023 - Perito Criminal (SPTC GO) Em processamento de local de crime contra a pessoa, durante o exame perinecropsóptico, são encontradas lesões típicas para cada instrumento usado no crime, como ferimentos punctórios, contusos, incisos e mistos. Analogamente, cada instrumento recebe uma classificação de acordo com a típica lesão que é capaz de provocar. Os instrumentos "punhal", "barra metálica" e "projétil expelido por arma de fogo" são classificados, respectivamente, como agentes

- a) cortocontundente, contundente e cortante.
- b) perfurocortante, contundente e perfurocontundente.
- c) cortocontundente, perfurocontundente e contundente.
- d) contundente, cortante e perfurocontundente.
- e) perfurocortante, contundente e contundente.

Gabarito: B

Comentário:



Punhal - Cortocontundente; Barra metálica - contundente; PAF - perfurocontundente.

- a) Incorreta. O punhal não é cortocontundente; é perfurocortante de dois gumes.
- b) Correta. O punhal possui ponta e dois gumes, sendo perfurocortante; a barra metálica age por pressão e choque sobre um plano, sendo contundente; e o projétil de arma de fogo combina perfuração e contusão, sendo perfurocontundente.
- c) Incorreta. Inverte as classificações do punhal e do projétil.
- d) Incorreta. Classifica erroneamente o punhal como contundente e a barra metálica como cortante.
- e) Incorreta. Classifica o projétil como contundente.

78. 4001387912 IADES - 2023 - Perito Criminal (SPTC GO) Tecnicamente, lesões verificadas no pescoço são diferenciadas em função da região anatômica onde a lesão se produz e pela separação parcial ou total da cabeça. Acerca desse assunto, a secção quase total do pescoço feita pela parte posterior refere-se a

- a) decapitação.
- b) degola.
- c) esgorjamento.
- d) ferida punctória.
- e) ferida perfurocontusa.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. A decapitação é a separação completa da cabeça do restante do corpo.
- b) Correta. O degolamento é a ferida cortocontusa ou incisa localizada na região posterior do pescoço, podendo resultar em secção quase total do pescoço por essa face.
- c) Incorreta. O esgorjamento ocorre na região anterior e/ou lateral do pescoço, não na posterior.
- d) Incorreta. A ferida punctória é lesão produzida por instrumento perfurante de pequeno calibre, sem relação com lesões cervicais específicas.
- e) Incorreta. A ferida perfurocontusa resulta da ação de instrumentos perfurocontundentes como o projétil de arma de fogo, sem relação com a classificação das lesões cervicais.



79. 4001383616 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Suponha que o corpo de um indivíduo do sexo masculino não identificado tenha sido encaminhado ao Instituto Médico-legal local para perícia médica acerca da causa da morte. Ao exame físico externo, observaram-se, na região abdominal, duas feridas lineares, de 10 cm e 15 cm de comprimento e 2,5 cm de profundidade, que não se cruzavam, ambas de bordas regulares, cujo centro de cada ferida era mais profundo que as extremidades, e com cauda de escoriação voltada para o mesmo lado. Com relação às lesões, assinale a alternativa que indica o instrumento lesivo mais compatível.

- a) Faca, por ação perfurocortante
- b) Facão, por ação cortocontundente
- c) Faca, por ação perfurante
- d) Navalha, por ação cortante
- e) Arma de fogo, por ação perfurocontundente

Gabarito: D

Comentário:

- a) Incorreta. A ação perfurocortante de uma faca produziria ferida com profundidade prevalecendo sobre o comprimento e sangramento predominantemente interno.
- b) Incorreta. O facão em ação cortocontundente produziria bordas escoriadas e irregulares, além de fundo anfractuoso.
- c) Incorreta. A ação perfurante de uma faca produziria lesão punctória com profundidade maior que a extensão e diâmetro reduzido.
- d) Correta. Todas as características descritas são típicas de ferida incisa produzida por instrumento cortante como a navalha: feridas lineares com comprimento prevalecendo sobre a profundidade, bordas regulares, centro mais profundo que as extremidades (perfil fusiforme) e cauda de escoriação na mesma direção nas duas feridas, indicando que o instrumento foi retirado sempre no mesmo sentido.
- e) Incorreta. A arma de fogo produziria ferida perfurocontusa com orla de enxugo, bordas invertidas e trajeto interno.

80. 4001383625 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Assinale a alternativa que apresenta a definição técnica da lesão conhecida como esgorjamento.

- a) Separação completa da cabeça em relação ao tronco
- b) Secção quase total do pescoço feita pela parte posterior



- c) Secção da parte anterior do pescoço
- d) Divisão do corpo em partes, mediante amputação ou desarticulação
- e) Separação completa de um membro ou segmento do corpo

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. A separação completa da cabeça em relação ao tronco define a decapitação.
- b) Incorreta. A secção quase total do pescoço pela parte posterior define o degolamento.
- c) Correta. O esgorjamento é a secção da parte anterior do pescoço (o termo deriva de "gorja", que significa garganta ou goela). A lesão acomete a região anterior e/ou lateral, podendo atingir superficialmente a pele ou profundamente músculos, feixes vasculonervosos, esôfago, laringe e traqueia, com morte por secção dos vasos carotídeos ou asfixia por aspiração de sangue.
- d) Incorreta. A divisão do corpo em partes por amputação ou desarticulação define o esquartejamento.
- e) Incorreta. A separação completa de um membro ou segmento do corpo define a amputação traumática, não o esgorjamento.

81. 4001261424 (IADES - 2022 - Professor (UnDF)/Medicina Legal/Deontologia) As formas das lesões causadas por instrumento perfurante de médio calibre assumem aspectos peculiares. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Numa região onde as linhas de força tenham um só sentido, o maior eixo terá sentido inverso ao das linhas de força.
- b) Em regiões de linhas de forças diferentes, a lesão tem o aspecto sempre regular.
- c) As lesões produzidas por instrumento de dois gumes têm a aparência de "casa de botão".
- d) O aspecto das lesões independe da condição post mortem
- e) Em pontos de confluência de linhas de força, as formas são irregulares.

Gabarito: C

Comentário:

- a) Incorreta. Pela 2ª Lei de Filhos (Lei do Paralelismo), em regiões onde as linhas de força têm um só sentido, o maior eixo da lesão segue a mesma direção dessas linhas.



- b) Incorreta. Em regiões de confluência de linhas de força de sentidos diferentes, a lesão assume aspecto irregular, com extremidades em ponta de seta, triângulo ou quadrilátero, conforme a Lei de Langer, portanto não é sempre regular.
- c) Correta. É exatamente o enunciado da 1ª Lei de Filhos (Lei da Semelhança): as feridas produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre assemelham-se às geradas por instrumentos perfurocortantes de dois gumes, apresentando o formato de "casa de botão".
- d) Incorreta. O aspecto das lesões é influenciado pela condição post mortem, pois após a morte a elasticidade e a tensão cutânea se alteram, modificando a morfologia das feridas.
- e) Incorreta. Nos pontos de confluência de linhas de força, as formas resultantes são poligonais ou em ponta de seta, o que a Lei de Langer chama de polimorfismo, não simplesmente irregularidade sem padrão.

82. 4002093046 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico/) Em um local de crime contra a pessoa, o Perito Criminal identificou no corpo da vítima uma lesão profunda, produzida por um instrumento cortante na região posterior do pescoço, sem que fosse constatada separação entre a cabeça e corpo, caracterizando uma lesão do tipo:

- a) esgorjamento.
- b) decapitação.
- c) evisceração.
- d) degolamento.
- e) esquartejamento.

Gabarito: D.

Comentário:

- a) Incorreta. O esgorjamento ocorre na região anterior e/ou lateral do pescoço, não na posterior.
- b) Incorreta. A decapitação implica separação completa da cabeça do restante do corpo.
- c) Incorreta. Evisceração é a exteriorização de vísceras abdominais.
- d) Correta. O degolamento é a lesão produzida por instrumento cortante ou cortocotundente na região posterior do pescoço, sem necessariamente promover a separação entre cabeça e corpo. O nome remete à gola da camisa, que assenta justamente na nuca.
- e) Incorreta. Esquartejamento é a redução do corpo em quartos (fragmentos mais regulares que o espostejamento) por amputação ou desarticulação. Geralmente tem a finalidade de dificultar a identificação do cadáver. Para aproveitar a questão, vamos revisar o espostejamento: é a



redução do corpo em fragmentos diversos e irregulares, sendo comum em acidentes ferroviários e aéreos.

83. 4002093047 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico) Ao examinar o corpo de uma vítima, o Perito Criminal constatou a presença de diversas lesões perfuroincisas e cortocontusas. Prioritariamente, quais instrumentos ele deveria procurar na cena de crime, respectivamente?

- a) Arma de fogo e barra de ferro.
- b) Faca e facão.
- c) Machado e peça de madeira.
- d) Estilete e navalha.
- e) Arma de fogo e punhal.

Gabarito: B

Comentário:

- a) Incorreta. Arma de fogo produz lesão perfurocontusa, não perfuroincisa; e barra de ferro é instrumento contundente, não cortocontundente.
- b) Correta. A faca, quando introduzida no corpo com ponta e gume, é instrumento perfurocortante e produz a lesão perfuroincisa. O facão, por sua vez, combina gume e massa considerável, sendo instrumento cortocontundente que produz lesão cortocontusa. A correspondência está correta em ambos os casos.
- c) Incorreta. O machado é cortocontundente (correto para a segunda lesão), mas a peça de madeira é contundente, incompatível com lesão perfuroincisa.
- d) Incorreta. O estilete é perfurante ou perfurocortante de um gume, podendo produzir lesão perfuroincisa; mas a navalha é instrumento cortante, não cortocontundente.
- e) Incorreta. Arma de fogo é perfurocontundente, não perfurocortante; e o punhal, embora perfurocortante, estaria na ordem invertida em relação ao que a questão pede.

84. 4002092938 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Com relação à ação contundente, marque a alternativa INCORRETA:

- a) as lesões podem ser decorrentes de meios sólidos, líquidos e até gasosos.
- b) pode provocar rubefação, edema, equimose, escoriação e até ferida.
- c) frequentemente produz traumatismo cranioencefálico.



- d) embora relativamente comum, não é o tipo de ação mecânica mais frequente.
- e) o meio lesivo pode ser ativo, passivo e misto ou biativo.

Gabarito: D

Comentário:

Queremos a ERRADA.

- a) Correta. A ação contundente pode ser produzida por meios sólidos (pedra, bastão), líquidos (jato d'água de alta pressão) e gasosos (onda de explosão), já que o que define o instrumento contundente é a ação por pressão sobre um plano, independentemente do estado físico do agente.
- b) Correta. Isso mesmo! Temos a rubefação, edema traumático, equimose, escoriação e, nos casos em que a resistência dos tecidos é superada, ferida contusa aberta.
- c) Correta. O traumatismo cranioencefálico é uma das consequências mais frequentes e graves da ação contundente, especialmente por objetos que atingem a cabeça.
- d) Incorreta. A ação contundente é o tipo mais frequente de ação mecânica observada nas perícias. Cerca de 80% das perícias traumatológicas nos institutos oficiais decorrem de violência por instrumentos contundentes. E por isso, o mais cobrado em provas!
- e) Correta. O meio lesivo contundente pode atuar de forma ativa (instrumento vai ao encontro do corpo), passiva (corpo vai ao encontro do instrumento imóvel) ou mista/biativa (ambos em movimento, como em colisões frontais).

85. 4002092939 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Analise as proposições:

- I — Feridas cortantes ou incisivas geralmente apresentam regularidade das bordas, forma linear, ausência de vestígios traumáticos ao redor da ferida, hemorragia é mais frequente e a profundidade predomina sobre o comprimento;
- II — Feridas cortocontusas são, em geral, mais graves, profundas, não têm cauda de escoriação e atingem planos interiores, podendo determinar lesões ósseas;
- III- Feridas puntiformes aparecem como um ponto, abertura estreita, raro sangramento, pouca nocividade na superfície;
- IV - Feridas perfurocortantes apresentam geralmente orla desepitelizada de França no ângulo mais agudo.

Assinale a alternativa correspondente.

- a) Todas as proposições são falsas.



- b) Há apenas uma proposição verdadeira.
- c) Há apenas duas proposições verdadeiras.
- d) Há apenas três proposições verdadeiras.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Gabarito: C

Comentário:

Proposição I — Falsa. As feridas incisas apresentam comprimento prevalecendo sobre a profundidade. A profundidade é maior no centro da ferida, mas o comprimento total é que predomina sobre ela.

Proposição II — Verdadeira. As feridas cortocontusas são de gravidade considerável, atingem planos profundos incluindo ossos, geralmente não apresentam cauda de escoriação e têm o traço de fratura que frequentemente copia o gume do instrumento.

Proposição III — Verdadeira. As feridas punctórias (puntiformes) produzidas por instrumentos perfurantes de pequeno calibre apresentam abertura estreita em formato de ponto, raro sangramento externo e pouca nocividade na superfície, embora possam ser graves em profundidade conforme as estruturas atingidas.

Proposição IV — Falsa. A orla desepitelizada de França é encontrada no ângulo reto ou arredondado das feridas perfurocortantes de um gume, correspondente ao lado do dorso do instrumento, não no ângulo agudo, que corresponde ao lado do gume.

Portanto, apenas as proposições II e III são verdadeiras.

86. 4002092862 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Médico-Legal/) Sobre desmembramentos, marque a alternativa correta.

- a) Nunca envolvem o tronco.
- b) Frequentemente é realizado após a morte.
- c) Envolvem somente desarticulação de membros.
- d) Nunca envolvem decapitação.
- e) Envolvem apenas a secção dos membros.

Gabarito: B

Comentário:



- a) Incorreta. Os desmembramentos podem envolver o tronco, especialmente no espostejamento, que é a fragmentação irregular do corpo comum em acidentes ferroviários e aéreos.
- b) Correta. O desmembramento, seja esquartejamento, espostejamento ou decapitação, é realizado frequentemente após a morte, geralmente com a finalidade de dificultar a identificação da vítima ou facilitar o transporte e ocultação do corpo.
- c) Incorreta. Os desmembramentos não envolvem somente desarticulação de membros; podem incluir secções ósseas, decapitação e fragmentação irregular de qualquer parte do corpo.
- d) Incorreta. A decapitação, que é a separação completa da cabeça do tronco, é considerada uma forma de desmembramento.
- e) Incorreta. Os desmembramentos abrangem não apenas a secção de membros, mas também a separação da cabeça, divisão do tronco e fragmentação irregular do corpo em geral.

87. 4002092940 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Analise as proposições:

- I - No exame de uma ferida, caso o Perito observe um ângulo agudo e outro reto ou arredondado é possível afirmar que a lesão fora causada por objeto perfurante de médio calibre;
- II - O comprimento da lâmina da faca ou objeto usado para produzir uma ferida perfurocortante pode ser sempre determinado a partir do comprimento do trajeto da lesão no interior do corpo;
- III — Feridas perfurocortantes geralmente deixam pontes de tecido íntegro;
- IV - Decapitação caracteriza-se por uma separação total entre a cabeça e o corpo em decorrência de uma ação cortante em região cervical.

Assinale a alternativa correspondente.

- a) Todas as proposições são falsas.
- b) Há apenas uma proposição verdadeira.
- c) Há apenas duas proposições verdadeiras.
- d) Há apenas três proposições verdadeiras.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

Gabarito: B

Proposição I — Falsa. A presença de um ângulo agudo e outro reto ou arredondado é característica de ferida produzida por instrumento perfurocortante de um gume. Instrumento perfurante de médio calibre produz lesão em casa de botão com dois ângulos agudos simétricos orientados pelas linhas de Langer.



Proposição II — Falsa. O comprimento do trajeto interno não permite sempre determinar o comprimento da lâmina, pois o fenômeno da lesão em acordeão de Lacassagne demonstra que em regiões depressíveis como o abdome, a profundidade da ferida pode ser maior que o próprio comprimento do instrumento.

Proposição III — Falsa. As pontes de tecido íntegro no fundo da lesão são características das feridas contusas, não das perfuroincisas, que apresentam bordas regulares e fundo limpo sem trabéculas.

Proposição IV — Verdadeira. A decapitação pode resultar tanto de ação cortante quanto cortocontundente, como o uso da guilhotina ou do machado. A afirmativa não menciona a ação cortocontundente, mas também não é taxativa afirmando que a ação cortante pudesse ser a única forma de decapitação. Portanto, a proposição está incompleta, mas não está errada.

88. 4002093078 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico) JDP, sexo masculino, 15 anos, conduziu automóvel na contramão, atropelou a pessoa em situação de rua JMB, 68 anos, e bateu num poste. Levados a um pronto-socorro foram avaliados:

JMB, sem sinais vitais, apresentava equimose em região frontal, fratura de crânio e hemorragia encefálica, sem outras lesões.

JDP, sem lesões externas, apresentava discurso acelerado e desconexo, dilatação pupilar, alucinações visuais, auditivas e portava droga ilícita.

O que mais provavelmente determinou a morte de JMB foi um meio ou instrumento:

- a) perfurocontundente.
- b) cortante.
- c) perfurante.
- d) contundente.
- e) lacerante.

Gabarito: D

Comentário:

a) Incorreta. O instrumento perfurocontundente, como o projétil de arma de fogo, produziria lesão com orifício de entrada, trajeto e eventualmente saída, incompatível com o mecanismo de atropelamento e colisão descrito.

b) Incorreta. O instrumento cortante produziria feridas incisivas com bordas regulares e sangramento externo abundante, não o padrão de fratura craniana e hemorragia encefálica por trauma de impacto.



c) Incorreta. O instrumento perfurante produziria lesão punctória profunda, incompatível com fratura de crânio extensa e equimose em região frontal por impacto de atropelamento.

d) Correta. O atropelamento e a colisão são mecanismos tipicamente contundentes, em que o corpo sofre impacto de grande superfície com transferência de energia cinética. A equimose frontal, a fratura craniana e a hemorragia encefálica são lesões contusas clássicas resultantes dessa dinâmica, confirmando o instrumento contundente como agente causador da morte de JMB.

e) Incorreta. O termo "lacerante" não integra a classificação formal dos instrumentos lesivos mecânicos na traumatologia forense brasileira. Alguns autores mencionam lesões lacerocontusas, mas como subcategoria das contusas e mesmo assim o instrumento seria contundente, não lacerante.



QUESTÕES EXTRAS - LISTA DE QUESTÕES

1. 4002238070 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

As feridas incisivas tendem a apresentar bordas regulares, ausência de pontes de tecido no fundo da lesão e maior extensão no plano horizontal que na profundidade, sendo frequente a presença de lesões de defesa em membros superiores, quando associadas a homicídio.

() Certo

() Errado

2. 4002238069 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

Lesões do tipo contragolpe observadas em traumatismos cranianos apresentam-se obrigatoriamente no mesmo lado que sofreu o impacto direto, sendo indicativas de trauma contuso com fratura óssea subjacente.

() Certo

() Errado

3. 4002238068 (CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 12/2025) No âmbito da medicina legal, as energias de ordem mecânica são responsáveis pela maioria das lesões traumáticas observadas em vítimas de agressões, acidentes e homicídios. Além dessas, há também as energias físicas não mecânicas, como térmicas, elétricas, químicas e radioativas, que produzem efeitos lesivos com características distintas. No que se refere a esse assunto, julgue o seguinte item.

As lesões por ação contundente, como hematomas, equimoses e escoriações, produzem necessariamente solução de continuidade da pele, sendo consideradas obrigatoriamente lesões abertas, de acordo com a classificação médico-legal.

() Certo



() Errado

4. 4002150298 (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC CE)/PC CE/2025) Uma pessoa que sofreu lesão corporal dolosa alegou ter sido agredida com pauladas, socos, pontapés e tapas. A lesão mais grave dolorosa, que a incapacitava de deambular, era uma lesão na região inguinal (raiz da coxa) esquerda, provocada por chute. Durante o exame da vítima, que foi realizado mais de quatro dias após a violência, o médico-legista notou uma coleção de tonalidade azul-violácea no joelho do mesmo lado daquela lesão. O periciando referiu que neste local não havia sofrido agressão.

Pelas características da formação azul-violácea descrita na situação hipotética apresentada, é correto concluir a existência de

- a) bossa sanguínea.
- b) equimose profunda à distância.
- c) fratura oculta.
- d) hematoma sinovial.
- e) equimose externa ou superficial.

5. 4001318562 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As lesões oriundas de energia de etiologia mecânica podem ser provocadas por mecanismo de tração, torção, compressão ou sucção.

- () Certo
() Errado

6. 4001318971 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

O espectro de Legrand du Saulle é utilizado para avaliar a evolução das escoriações.

- () Certo



☐ Errado

7. 4001318971 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Fratura óssea durante um jogo por parte de um jogador caracteriza-se como lesão contusa.

☐ Certo

☐ Errado

8. 4001318975 (CEBRASPE (CESPE) - Papis (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento perfurocortante e produz uma lesão perfuroincisa.

☐ Certo

☐ Errado

9. 4001323373 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. À luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Nas perícias médico e odonto-legais, o diagnóstico do instrumento causador da lesão deve observar o seguinte paradigma: é a lesão que denomina o instrumento, nunca o inverso.

☐ Certo

☐ Errado

10. 4001323390 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.



Entre os instrumentos relacionados aos agentes mecânicos incluem-se os instrumentos perfurantes, os instrumentos bolhosos e os instrumentos maciços.

() Certo

() Errado

11. 4001323413 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Na prática da medicina e da odontologia legal, são tipos de lesões (ferimentos) as puntiformes, as incisas, as contusas, as perfuroincisas, as cortocontusas, as perfurocontusas.

() Certo

() Errado

12. 4001323486 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense é um ramo da área médica que tem por fim estudar as lesões corporais resultantes de traumatismos produzidos por energias de ordem mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou energias de ordem mista. A luz dessa premissa, julgue o item a seguir.

Instrumento cortante é todo objeto rombo capaz de agir traumáticamente sobre o organismo.

() Certo

() Errado

13. 4001323094 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Em medicina legal, uma lesão tecidual ampla ocasionada por uma paulada é denominada contusodilacerante.

() Certo

() Errado



14. 4001318561 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

As manchas roxas descritas por Maria Alice fazem referência às equimoses, que se conceituam como o extravasamento de sangue oriundo da rotura dos capilares sanguíneos nas malhas dos tecidos superficiais ou profundos, sem infiltração hemorrágica.

☐ Certo

☐ Errado

15. 4001318560 (CEBRASPE (CESPE) - Aux Per (POLC AL)/POLC AL/2023) Maria Alice compareceu à delegacia de polícia para narrar uma série de agressões das quais havia sido vítima. Durante seu depoimento, narrou aos policiais que seu marido, Pedro, tinha praticado agressões contra ela por meio de choques elétricos, queimaduras provocadas por garfos aquecidos no fogão da residência e socos que lhe produziram manchas roxas pelo corpo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Segundo a classificação de Borri, as energias vulnerantes de etiologia mecânica são estudadas separadamente das energias vulnerantes de ordem física.

☐ Certo

☐ Errado

16. 4001323096 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Quando o instrumento perfurante é de médio calibre, as soluções de continuidade das lesões, conforme a Primeira Lei de Filhos (Edouard Filhos), assemelham-se às produzidas por instrumento de dois gumes ou têm a aparência de casa de botão.

☐ Certo

☐ Errado



17. 4001323097 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

Esgorjamento é uma lesão transversal abdominal que expõe o conteúdo visceral.

() Certo

() Errado

18. 4001323098 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) No que concerne aos tipos de lesões ocasionados por diversos meios ou objetos que atingem um tecido corporal, julgue o próximo item.

As feridas cortantes apresentam as extremidades mais superficiais e a parte mediana mais profunda, nem sempre de forma regular, além de terem, como característica principal, a chamada cauda de escoriação.

() Certo

() Errado

19. 4001323099 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A rubefação caracteriza-se pela congestão repentina e momentânea de uma região do corpo atingida pelo traumatismo, evidenciada por mancha avermelhada, efêmera e fugaz que desaparece em alguns minutos.

() Certo

() Errado

20. 4001323498 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue O item subsequente.

Fraturas correspondem a uma solução de continuidade dos ossos.



- ☐ Certo
☐ Errado

21. 4001323101 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

O desferimento de socos e pontapés em um indivíduo é considerado ação de instrumento contundente ativo, ao passo que a queda da própria altura no asfalto é ação de instrumento contundente passivo.

- ☐ Certo
☐ Errado

22. 4001323500 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue o item subsequente.

As lesões, observando-se as suas características, podem fornecer informações relativas ao ponto ou área onde se produziu violência; à data provável do evento; à vida ou morte da vítima, quando da agressão; à forma do instrumento e à natureza do atentado ou ação.

- ☐ Certo
☐ Errado

23. 4001323103 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Considerando a variedade de traumas avaliada na medicina legal, julgue o item a seguir.

A sequência evolutiva de cores do espectro equimótico de Legrand du Saulle é caracterizada, na ordem evolutiva, por vermelho- escuro, preto, azul, violeta, verde e amarelo.

- ☐ Certo
☐ Errado

Gabarito: Errado



24. 4001323501 (CEBRASPE (CESPE) - Per Odonto (POLC AL)/POLC AL/2023) A traumatologia forense estuda traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Nesse âmbito, trauma é o resultado do acréscimo e(ou) da ação vulnerante que possuem energia capaz de produzir lesão; ao passo que lesão nada mais é do que o dano tecidual, temporário ou permanente, resultante do trauma. Nessa perspectiva, julgue O item subsecutivo.

As fraturas são exclusivamente consequências da ação de compressão.

() Certo

() Errado

25. 4001323105 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as armas brancas podem ser empregadas de diversas formas e, assim, produzir lesões de diferentes tipos e com diversos graus de potencial lesivo, julgue o item que se segue.

De acordo com a lei de Langer, feridas produzidas em regiões de confluência de linhas de força são paralelas entre si.

() Certo

() Errado

26. 4001323106 (CEBRASPE (CESPE) - Per ML (POLC AL)/POLC AL/2023) Tendo em vista que as armas brancas podem ser empregadas de diversas formas e, assim, produzir lesões de diferentes tipos e com diversos graus de potencial lesivo, julgue o item que se segue.

Feridas causadas por armas brancas que alcançam grande profundidade são denominadas cortocontusas.

() Certo

() Errado

27. 4001376953 (CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC AL)/PC AL/2023) No que diz respeito a lesões por ação contundente, por armas brancas e de fogo e por projéteis de arma de fogo comuns, julgue o próximo item.

Um bisturi, ao ser manipulado por ação em linha, deslizando e cortando um tecido, provoca uma lesão cortante.

() Certo



() Errado

28. 4001087461 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Per (PC PB)/PC PB/Área Geral/2022) Uma criança foi levada ao IML após ter sido examinada na emergência infantil de um hospital pediátrico com suspeita de síndrome de Straus. Ao exame físico, constatou-se descolamento metafisário, provavelmente decorrente de trações e constrictões violentas, bem como trações e tensões ao nível de uma articulação. Considerando essas informações, é correto afirmar que houve ação de energia de ordem

- a) química.
- b) mecânica.
- c) biodinâmica.
- d) física.
- e) físico-química.

29. 4001203403 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) A área da medicina legal que estuda as lesões e estados patológicos, imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano, nos seus aspectos de diagnóstico, prognóstico e implicações legais e socioeconômicas, assim como as diversas modalidades de energias causadoras desses danos, é denominada

- a) diceologia médica.
- b) antropologia forense.
- c) traumatologia forense.
- d) infortunística.
- e) tanatologia forense.

30. 4001229848 (CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC RO)/PC RO/2022) A traumatologia forense é um ramo da medicina legal

- a) que estuda a cronotanatognose.
- b) também conhecido como lesionologia.
- c) que estuda as asfixias sob o ponto de vista médico e jurídico.
- d) responsável por estudar a parte de identificação médico-legal.



e) que define as características antropológicas do ser humano.

31. 4001084576 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) Uma ferida de forma linear, bordas regulares, predominância do comprimento sobre a profundidade, afastamento das bordas da ferida, regularidade do fundo da lesão, hemorragia quase sempre abundante, presença de cauda de escoriação, centro da ferida mais profundo que as extremidades é denominada ferida

- a) contusa.
- b) perfurocontusa.
- c) punctória.
- d) cortante.
- e) perfurocortante.

32. 4001084862 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) Periciado vítima de acidente automobilístico apresentou fratura exposta de fêmur direito em ambas as tíbias, extensa equimose em tórax anterior, hematoma subgaleal em região frontoparietal direita. O instrumento que provocou as referidas lesões é do tipo

- a) perfurante.
- b) perfurocortante.
- c) perfurocontundente.
- d) contundente.
- e) cortante.

33. 4001202587 (CEBRASPE (CESPE) - Med Leg (PC RO)/PC RO/2022) No que se refere à necessidade de conhecer diversas lesões em medicina legal, assinale a opção correta sobre o referido tema e assuntos correlatos.

- a) Sinal de Chavigny manifesta-se quando há lesões contusas sobrepostas (provocadas uma em cima da outra).
- b) Lei de Filhos e Langer é a lei aplicada em casos de lesões produzidas por instrumentos contundentes.
- c) Instrumentos como punhal e faca introduzidos em um corpo produzem lesão perfurocortante.



- d) Ferimentos produzidos por instrumentos perfurocortantes tendem, de maneira geral, a apresentar o formato do instrumento que os produziu.
- e) Degolamento caracteriza-se, em geral, por uma ferida incisa ou cortocontusa localizada na porção posterior do pescoço.

34. 4001202548 (CEBRASPE (CESPE) - Med Leg (PC RO)/PC RO/2022) No que se refere à coloração das equimoses no trabalho de cronologia de uma agressão, assinale a opção correta.

- a) As equimoses, comumente, ocorrem devido à ação de instrumento cortante.
- b) O Índice de Verderau auxilia na análise das equimoses no que se refere à determinação da ocorrência de uma lesão intra vitam e post mortem.
- c) As equimoses são classificadas como profundas porque se situam em tegumentos e massas musculares.
- d) A presença de equimose superficial de coloração amarelada, tendo como parâmetro o espectro equimótico de Le Grand du Saulle, sugere lesão ocorrida em, no máximo, sete dias.
- e) As equimoses profundas assumem coloração avermelhada durante toda a sua evolução.

35. 4001084580 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) São considerados instrumentos cortocontundentes

- a) projétil de arma de fogo, vergalhões de construção civil.
- b) furador de gelo, prego.
- c) punhal, faca peixeira.
- d) foice, facão.
- e) faca de cozinha, canivete.

36. 4001084585 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Médico Legal/Área Geral/2022) Julgue os itens a seguir, relativos à traumatologia forense.

- I A rubefação é considerada a menor e mais transitória lesão causada pela ação contundente.
- II O hematoma corresponde a discreto extravasamento de sangue dos capilares com sua difusão nas malhas dos tecidos moles.
- III A escoriação define-se como arrancamento da epiderme e o desnudamento da derme, de onde fluem serosidade e sangue.



IV A equimose corresponde às lesões que se traduzem por coleções hemorrágicas que não se difundem nas malhas dos tecidos.

Estão certos apenas os itens

- A. I e II
- B. I e III.
- C. II e IV
- D. I, III e IV
- E. II, II e IV

37. 4001087469 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Per (PC PBJ/PC PB/Área Geral/2022) Dois agricultores agrediram-se mutuamente com facões e um deles feriu-se gravemente no antebraço direito, tendo trauma ósseo e secção de diversos tendões, após solução de continuidade na face anterior desse segmento. Com base nessa situação, é correto afirmar que o trauma descrito caracteriza lesão

- a) incisa.
- b) corto-contundente.
- c) contusa.
- d) perfuro-contusa.
- e) perfuro-incisa.

38. 4001203486 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) Assinale a opção que apresenta os meios produtores de lesões causadoras de danos em energias de ordem mecânica.

- a) revólveres, punhais, machado, energia elétrica, radioatividade e venenos
- b) punhais, pistolas elétricas (taser), dentes, máquinas, animais, venenos e asfixia
- c) faca, machado, explosões, cáusticos, asfixia e choque
- d) foice, pistolas elétricas (taser), animais, quedas, queimaduras e radioatividade
- e) revólveres, soqueira, navalha, foice, punhos, dentes, máquinas, veículos, animais e quedas

39. 4001203497 (CEBRASPE (CESPE) - Tec Necro (PC RO)/PC RO/2022) Assinale a opção que corresponde às características das lesões produzidas por ação perfurante.



- a) forma estrelada, sinuosa ou retilínea; bordas irregulares, escoriadas e esquimosadas; vertentes irregulares, pouco sangrantes, retração das bordas da ferida
- b) forma linear; regularidade das bordas; regularidade do fundo da lesão; afastamento das bordas da ferida
- c) abertura estreita; raro sangramento; pouca nocividade na superfície; eventual gravidade na profundidade, em face do órgão atingido; diâmetro quase sempre menor que o do instrumento causador
- d) centro da ferida mais profundo que as extremidades; paredes da ferida lisas e regulares; vertentes cortadas obliquamente; hemorragia quase sempre abundante
- e) ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida; presença de cauda de escoriação voltada para o lado onde terminou a ação do instrumento; perfil de corte de aspecto angular

40. 4001230397 (CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC RO)/PC RO/2022) O hematoma é caracterizado pela literatura médico-legal como uma lesão

- a) incisa, proveniente de energia de ordem física.
- b) contusa, proveniente de energia de ordem química.
- c) cortocontusa, proveniente de energia de ordem bioquímica.
- d) contusa, proveniente de energia de ordem mecânica.
- e) cortocontusa, proveniente de energia de ordem biodinâmica.

41. 4000986580 (CEBRASPE (CESPE) - DP TO/DPE TO/2022) Um faxineiro de um hospital público, ao manusear o lixo da unidade cirúrgica, sofreu uma lesão que foi descrita no prontuário médico como incisa. Com base nessas informações, é correto afirmar que, na situação hipotética apresentada, a lesão foi causada por instrumento

- a) cortocontundente.
- b) perfurante.
- c) perfurocontundente.
- d) contundente.
- e) cortante.



42. 4002237251 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Atente para a seguinte descrição: Mulher de 42 anos procura a delegacia de Polícia Civil plantonista, por volta de meia-noite, após uma discussão com seu companheiro, que estava alcoolizado, há cerca de 6 horas. Declara que foi agredida fisicamente e moralmente. O policial que a atendeu percebe que ela apresenta equimoses avermelhadas e difusas em face, associadas com escoriações irregulares em membro superior direito e luxação em joelho esquerdo. Entre outros procedimentos, foi emitida guia policial para realização de perícia com o médico legista. Considerando as lesões descritas, quais sejam: equimoses, escoriações e luxação, é correto afirmar que os meios ou instrumentos promotores dessas lesões serão apresentados, no laudo pericial, respectivamente, como

- a) perfurocortante, contundente e cortante.
- b) cortante, contundente e contundente.
- c) contundente, perfurocortante e contundente.
- d) contundente, contundente e contundente.
- e) cortante, contundente e cortante.

43. 4001774247 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Na frase “indivíduo apresenta objeto perfurante penetrado em esclera” conclui-se que há um objeto perfurando o:

- a) Tórax.
- b) Abdome.
- c) Olho.
- d) Cérebro.
- e) Baço.

44. 4002543244 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Considerando a traumatologia médico-legal:

- I. Esgorjamento, degola e decapitação são lesões localizadas no pescoço da vítima.
- II. As equimoses não são encontradas no cadáver em lesões produzidas após a morte.
- III. A desidratação é o quadro clínico provocado pela perda de água do organismo, podendo ocorrer somente pela via cutânea ou em razão da sudorese intensa.



IV. Fica afastada a hipótese de suicídio quando a asfixia for por esganadura.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) I, III e IV.
- d) I II e III.
- e) I, II e IV.

45. 4001237035 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) O ramo da Medicina Legal que estuda as lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano, bem como os aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais é a:

- a) Asfixiologia.
- b) Antropologia forense.
- c) Deontologia.
- d) Traumatologia forense.
- e) Tanatologia.

46. 4000955077 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) A Traumatologia Médico-Legal estuda as lesões e condições patológicas, imediatas ou tardias, geradas por violência sobre o corpo humano, nos seus aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas consequências legais e socioeconômicas. As causas de mortes por trauma têm relação direta com a idade. Assim, em adolescentes, a principal causa de morte por trauma é causada por:

- a) Afogamentos.
- b) Queimaduras.
- c) Quedas de bicicletas.
- d) Quedas da própria altura.
- e) Acidentes automobilísticos.



47. 4001237033 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Na traumatologia forense, a identificação de equimoses pode ser caracterizada:

- a) Pela forma mais simples das lesões, hiperemiada e edemaciada, sendo fugaz, efêmera, passageira, e, por isso, o exame de corpo de delito deve ser feito rapidamente, sob risco de desaparecimento.
- b) Pelo arrancamento traumático da epiderme, com exposição da derme, sem, contudo, ultrapassá-la e com cicatrização por reepitelização.
- c) Pelas soluções de continuidade dos tecidos com bordos regulares, superficiais e profundos e hemorragia profusa.
- d) Pelas soluções de continuidade dos tecidos com esmagamento da epiderme e derme, de forma contusa e irregular.
- e) Pela infiltração do sangue nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão. Em regra, ocorre pela ruptura de capilares, vênulas e arteríolas.

48. 4001237050 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) Uma ferida que apresenta uma forma linear, regularidade das bordas, regularidade do fundo da lesão, ausência de vestígios traumáticos em torno da ferida, hemorragia quase sempre abundante e predominância do comprimento sobre a profundidade é uma característica das lesões produzidas por:

- a) ação cortante.
- b) ação perfurante.
- c) ações contundentes.
- d) ação mista abrasiva e cortante.
- e) ação mista perfuro-contundentes.

49. 4000955062 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) As lesões simples causadas por instrumentos externos, como no atrito por deslizamento, que lesa a superfície da pele removendo camadas da epiderme (1º grau), epiderme e derme (2º grau) ou toda a espessura da pele (3º grau), usualmente vistas em quedas, atropelamentos, etc, caracterizam a:

- a) Ferida incisa.
- b) Ferida punctória.



- c) Ferida contusa tipo equimose.
- d) Ferida contusa tipo escoriação.
- e) Ferida contusa tipo bossas e hematomas.

50. 4000955073 (CEBRASPE (CESPE) - Per Of (PC PB)/PC PB/Odonto Legal/Geral/2022) As lesões complexas ou mistas são geralmente causadas por um instrumento cujas características de atuação têm mais de um mecanismo de lesão. Por exemplo, lesões causadas por punhais, estiletes, facas e similares, caracterizam uma lesão por:

- a) Instrumento corto-contundente, produzindo lesão corto contusa.
- b) Instrumento perfuro-contundente, produzindo lesão perfuro contusa.
- c) Instrumento contundente, produzindo fraturas e luxações.
- d) Instrumento perfurocortante, produzindo lesão perfuro incisa.
- e) Instrumento contundente, produzindo hematomas e equimoses.

51. 4002424822 (FGV - Of Inv Pol (PC PI)/PC PI/2026) Os agentes vulnerantes são classificados de acordo com seu mecanismo de ação. As energias de ordem física causam grande parte das lesões observadas no cotidiano das investigações e perícias. Sobre os tipos de ferimentos encontrados, assinale a opção correta.

- a) As lesões causadas por objetos perfurantes causam sangramento intenso.
- b) As feridas causadas por projéteis de arma de fogo têm a largura proporcional à profundidade.
- c) Objetos perfurantes de calibre médio podem causar feridas com aspecto de casa de botão.
- d) As feridas com aspecto de casa de botão só podem ser causadas por objetos perfurocortantes de dois gumes.
- e) Objetos cortantes são capazes de causar desarticulação de um membro.

52. 4002429623 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Odontologista/2026) Quando ocorre tracionamento e contusão que distendem ligamentos, mas sem perda do contato articular, a lesão é classificada como

- a) fratura.
- b) luxação.



- c) entorse.
- d) ruptura visceral.
- e) equimose.

53. 4002428705 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Psiquiatria/2026) Durante uma briga em via pública, um homem é golpeado na região frontal da cabeça por um bastão de madeira de superfície larga. No atendimento pericial, observa-se no local do impacto uma lesão aberta, de forma estrelada, com bordas irregulares, escoriadas e levemente equimosadas, presença de pontes de tecido íntegro entre as margens e pouco sangramento. O fundo da lesão é irregular, mas apresenta vasos e estruturas profundas preservadas, e os ângulos da ferida tendem à obtusidade. Considerando o mecanismo da agressão e as características morfológicas descritas, o tipo de lesão apresentada é denominada

- a) esquimose.
- b) ferida punctória.
- c) ferida contusa.
- d) rubefação.
- e) escoriação

54. 4002429436 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Patologia/2026) As lesões perfurantes de médio calibre deixam feridas fusiformes características na pele, e que seguem as Leis de Filhos e de Langer. Assim sendo, duas lesões desse tipo, nas regiões lateral e posterior do pescoço, deixam, respectivamente, feridas com o seu sentido (maior eixo) dirigido pelas seguintes estruturas:

- a) Músculo esternocleidomastóideo e músculo trapézio
- b) Artéria carótida e músculo grande dorsal
- c) Plano horizontal e plano sagital
- d) Músculo platisma e músculos hióideos
- e) Eixo vertical e coluna vertebral cérvico-dorsal

55. 4002429437 (FGV - Per OC (PC PI)/PC PI/Médico Legista/Patologia/2026) Um exame cadavérico revela uma ferida alongada, fusiforme, com bordas lisas e extremidades agudas, com



comprimento superior à profundidade, muito sangrante, com cauda de escoriação longa em uma das extremidades. Lesões dessa natureza são produzidas por ações do tipo

- a) perfurante de médio calibre.
- b) perfurocortante de um gume.
- c) cortante.
- d) cortocontundente
- e) perfurocortante de dois gumes

56. 4001947013 (FGV - Med Leg (PC MG)/PC MG/2025) Sobre as lesões causadas por objetos perfurantes, que apresentam características diferentes de acordo com o calibre do mesmo, assinale a afirmativa correta

- a) Todas as lesões produzidas por objetos perfurantes têm formato de casa de botão
- b) As leis de Filhos e Langer se reportam apenas a objetos perfurantes de calibre médio.
- c) As lesões causadas por objetos perfurocortantes obedecem à lei do paralelismo (Lei do Paralelismo).
- d) As lesões causadas por objetos cortocontundentes podem ter aspecto de ponta de seta ou de quadrilátero.
- e) De acordo com a primeira lei de Filhos, as lesões causadas por instrumentos de pequeno calibre tendem a ser semelhantes entre si (Lei da Semelhança).

57. 4001947015 (FGV - Med Leg (PC MG)/PC MG/2025) Sobre as características das lesões causadas por ação contundente, as mais frequentemente observadas na prática pericial, assinale a afirmativa correta.

- a) As bordas são regulares.
- b) A profundidade predomina sobre a largura.
- c) A extensão predomina sobre a profundidade.
- d) As bordas são invertidas na entrada e evertidas na saída.
- e) As bordas são irregulares com traves de tecido íntegro no fundo.



58. 4001522823 (FGV - Del Pol (PC SC)/PC SC/2024) No dia 05/11/2023, Miguel conduzia seu veículo automotor dentro da velocidade permitida em determinada via pública de Blumenau quando, em certo momento, atingiu Jamiles, que atravessava a rua na faixa de pedestres, lesionando-a. Após o socorro médico, os envolvidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para lavratura do procedimento cabível.

No mesmo dia, por ocasião da realização da perícia pertinente, ficou comprovado que Jamiles estava com uma equimose de coloração amarelada, de formato circular, na região pélvica, medindo cerca de quarenta milímetros de diâmetro, além de apresentar fraturas cominutivas no terço médio do fêmur da perna esquerda, escoriações nos dois cotovelos e uma lesão cortocontusa na região da glabella.

Acerca dessas lesões constatadas em Jamiles, é correto afirmar que

- a) as fraturas cominutivas são assim chamadas, pois apenas uma das suas duas partes fragmentadas é projetada para além de uma abertura da pele, razão pela qual também é compreendida como “fratura incompleta”.
- b) a lesão cortocontusa na glabella representa uma forma clássica do emprego de energia vulnerante de etiologia físico-química.
- c) a escoriação é representada pela literatura médico-legal como “lesão em acordeão ou sanfona”, com sangramento abundante, abertura estreita e de menor diâmetro de entrada em comparação com o agente vulnerante.
- d) a equimose percebida não guarda nexo de causalidade com o evento traumático referente ao acidente provocado por Miguel.
- e) a escoriação é representada pela literatura médico-legal como uma vasodilatação exclusivamente vital, causando o eritema, que é uma mancha avermelhada, efêmera e fugaz.

59. 4001015981 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/43 Classe/2022) Dependendo dos fatores envolvidos, principalmente a forma e força de agressão, existirão diversas modalidades de lesões com repercussões e consequências diferentes. Partindo dessa premissa, relacione a condição com suas respectivas particularidades:

1. Rubefação.
2. Escoriação.
3. Equimose.
4. Hematoma.
5. Esmagamento.



- () Congestão local passageira.
- () Coleção sanguínea localizada.
- () Síndrome de Crush.
- () Derrame sanguíneo na malha tecidual.
- () Exposição do córion.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

- A. 1, 4, 5, 3 e 2.
- B. 1, 4, 3, 5 e 2.
- C. 4, 1, 5, 3 e 2.
- D. 4, 1, 2, 5 e 3.
- E. 3, 4, 5, 2 e 1.

60. 4001015997 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) No estudo das energias de ordem mecânica, a classificação médico-legal dos agentes pressupõe, invariavelmente, como primeira etapa, a análise da lesão para sua denominação. A literatura científica referencia que os arcos dentários humanos podem produzir vários tipos de feridas. Segundo Arbenz (1988) a dinâmica da mordida é habitualmente classificada como instrumento do tipo

- a) perfurante.
- b) contundente.
- c) corto-contundente.
- d) cortante.
- e) perfuro-contundente,

61. 4001016429 (FGV - Per Leg (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Armas brancas podem produzir feridas de diferentes tipos, a depender da atuação de outros componentes. Quando a ferida é produzida por meio do deslizamento da lâmina sobre o tecido, seccionando vasos sanguíneos e causando hemorragia volumosa, ela é denominada

- a) contusa.
- b) corto-contusa.



- c) perfuro-contusa.
- d) cortante.
- e) perfurante,

62. 4001016069 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Entre as lesões contusas superficiais causadas por ação física mecânica, temos a equimose. Na sufusão ocorre a transformação química da hemoglobina fora do vaso, determinando a mudança cromática no tecido traumatizado. Considerando o espectro equimótico de Legrand du Saulle, indique a sequência de cores no processo evolutivo dessa lesão.

- a) Vermelho-violáceo, avermelhado, azulado, esverdeado e amarelado.
- b) Avermelhado, azulado, vermelho-violáceo, esverdeado e amarelado.
- c) Avermelhado, azulado, esverdeado, vermelho-violáceo e amarelado.
- d) Avermelhado, vermelho-violáceo, azulado, esverdeado e amarelado.
- e) Vermelho-violáceo, avermelhado, esverdeado, azulado e amarelado

63. 4001007177 (FGV - Del Pol (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) O conhecimento das características das feridas é fundamental para que a Autoridade Policial compreenda a dinâmica dos eventos criminosos que causam lesões corporais. Assinale a opção que relaciona corretamente o tipo de ferida elencada às suas características.

- a) Ferida contusa: apresenta bordas regulares e fundo com traves de tecido íntegro.
- b) Ferida corto-contusa: é produzida por objetos que têm massa e gume e tem bordas regulares.
- c) Ferida perfuro-contusa: é causada exclusivamente por projéteis de arma de fogo.
- d) Ferida perfuro-cortante: apresenta grande profundidade sem sangramento, pois é causada pelo afastamento dos tecidos.
- e) Ferida cortante: tem profundidade maior do que a extensão, independente de ter um ou mais gumes.

64. 4001016077 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Após uma contusão aparece uma lesão superficial do tipo equimose que pode assumir diversas formas no tecido. Partindo dessa premissa, relacione a lesão com suas respectivas características.

- 1. Forma de lençóis.



2. Forma de estriações.
 3. Forma de grãos de areia sobre uma área.
 4. Forma de pontos de 1mm ou mais de diâmetro.
- () Sufusões.
- () Sugilações.
- () Petéquias.
- () Víbices.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.

- a) 1,2,3 e 4.
- b) 1,4,3 e 2.
- c) 2,1,3 e 4.
- d) 4,1,2 e 3.
- e) 1,3,4 e 2.

65. 4001274509 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) A Traumatologia Forense estuda as lesões e as condições patológicas, imediatas ou tardias, decorrentes da violência sobre o corpo humano, nas perspectivas do diagnóstico, do prognóstico e das suas consequências, sobretudo, legais. Considerando que tal estudo inclui a análise das diversas modalidades de energias causadoras de danos, assinale a afirmativa correta.

- a) Lesão é a denominação dada à alteração morfológica ou funcional do corpo humano no local em que ocorreu transferência de energia.
- b) Os agentes lesivos podem ser divididos em instrumentos e meios, sendo esses últimos exemplificados pelos objetos ou estruturas que transferem energia cinética (mecânica).
- c) Energias sonoras, elétricas, térmicas e radioativas são exemplos de energia de ordem química.
- d) As asfixias consistem na modalidade de energia de ordem biodinâmica.
- e) A fadiga e a inanição representam, respectivamente, as energias de ordem bioquímica e mista.



66. 4001274510 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) Cerca de 80% das perícias traumatológicas realizadas nos institutos oficiais de perícia são decorrentes de violência por instrumentos contundentes. Diante da importância do estudo desses agentes, relacione as lesões produzidas por eles às suas respectivas definições.

1. Rubefação
2. Hematoma
3. Equimose
4. Escoriação
5. Bossa

() Coleção sanguínea, localizada, formada pelo rompimento de vasos de grande ou médio calibre. Além de superficial, pode acontecer em profundidade, em massa de órgãos ou em espaços teciduais (retroperitônio, mediastino).

() Ocasionado pela vasodilatação no local da transferência de energia mecânica, guardando a assinatura do instrumento, porém de duração efêmera.

() Produzida pelo acúmulo de líquido linfático ou de sangue, quando a região do corpo atingida apresenta um plano subjacente resistente e impermeável.

() Sufusão hemorrágica difusa decorrente da infiltração tecidual de sangue extravasado pelo rompimento de vasos.

() Resultante da ação tangencial do instrumento que ocasiona o arrancamento da epiderme. Sua forma pode indicar o instrumento que a produziu. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a. 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
- B. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- C. 2 – 1 – 5 – 3 – 4.
- D. 5 – 1 – 2 – 3 – 4.
- E. 2 – 5 – 1 – 4 – 3.

67. 4001274514 (FGV - Per Odon (PCA AP)/PCA AP/2022) Em relação aos agentes lesivos de ordem mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e F para a falsa.

() Blast Injury é ocasionada pela proximidade do corpo a um local onde ocorreu uma transformação violenta e brusca de energia em outras formas, tais como: cinética, calórica,



lumínica, dinâmica ou térmica. Em geral são lesões contusas generalizadas, de grande extensão, podendo ainda estar presentes queimaduras de diversos graus.

() Entre as lesões especiais por ação cortante, o degolamento consiste na ferida localizada na região anterior ou ântero-lateral do pescoço, enquanto o esgorjamento é caracterizado pela ferida localizada estritamente na região cervical posterior.

() Lesão em “buraco de fechadura” é um tipo de traumatismo craniano ocasionado pela ação tangencial de projétil de arma de fogo sobre a calota craniana, quando ele apresenta uma inclinação mínima suficiente para entrar.

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

A. F, V e V.

B. V, F e F.

C. F, F e F.

D. V, F e V.

E. V, V e V.

68. 4001015976 (FGV - Per Odon (PC AM)/PC AM/42 Classe/2022) Em termos conceituais, a traumatologia forense estuda os traumas, lesões, instrumentos e ações vulnerantes, visando elucidar a dinâmica dos fatos. Sabendo-se que o trauma é resultado da ação vulnerante que possui energia capaz de produzir a lesão, correlacione a energia/ordem (causa) com seu respectivo sinal (efeito) sobre o corpo humano.

1. Ordem Mecânica.

2. Ordem Elétrica.

3. Ordem Térmica.

() Escara negra.

() Bossa linfática.

() Sinal de Lichtenberg.

() Sinal de Chambert positivo.

() Sinal de Jellinek.

() Sinal de Bonnet.

Assinale a opção que indica a relação correta na ordem apresentada.



- A. 3, 1, 2, 3, 2 e 1.
- B. 3, 2, 1, 3, 1 e 2.
- C. 2, 1, 2, 1, 3 e 3.
- D. 3, 1, 2, 1, 2 e 3.
- E. 1, 2, 3, 2, 3 e 1.

69. 4001281245 (FGV - Tec Per (PCA AP)/PCA AP/Biomédico/2022) No que tange aos exames no âmbito da Medicina Legal, assinale a afirmativa incorreta.

- a) Instrumentos pérfuro-contundentes são aqueles que atuam por meio de uma ponta romba, por pressão, e produzem lesão em forma de túnel. São exclusivamente representados pelos projéteis de arma de fogo.
- b) Instrumentos perfurantes são os que transferem sua energia cinética por meio de uma ponta, pressionando e afastando os elementos dos tecidos. O modo de ação dos instrumentos perfurantes está implícito em sua conceituação: a ponta atua por pressão e vai afastando as fibras dos tecidos à medida que se faz a penetração da haste.
- c) Instrumentos cortantes são os que transferem sua energia cinética por deslizamento e leve pressão através de uma borda aguçada a que se dá o nome de gume ou fio. Qualquer objeto provido de gume pode atuar como instrumento cortante, sendo exemplos a navalha, cacos de vidro, folhas metálicas e até mesmo folhas de papel.
- d) Instrumentos pérfuro-cortantes são os que transferem sua energia cinética por pressão, através de uma ponta, e por deslizamento, por meio de um ou mais gumes que seccionam as fibras dos tecidos.
- e) Instrumentos cortocontundentes são os que, dotados de grande massa, transferem sua energia por meio de um gume. Ao contrário dos instrumentos cortantes, que atuam mais por deslizamento, os cortocontundentes agem principalmente por pressão. O gume força os tecidos perpendicular ou obliquamente, penetra e abre caminho para a cunha que constitui o instrumento.

70. 4001272806 (FGV - Aux TP (PCA AP)/PCA AP/Técnico em Agrimensura/2022) No que tange aos exames no âmbito da medicina legal, em relação às contusões, assinale a afirmativa incorreta.

- a) A rubefação é a lesão mais simples das produzidas por ação contundente.



- b) A tumefação é causada por um trauma mais intenso e se traduz por elevação e palidez da pele na área do impacto.
- c) A equimose é a infiltração do sangue nas malhas dos tecidos e, em geral, deve-se à rotura de capilares, vênulas e arteríolas, mas pode se formar também por diapedese.
- d) As equimoses são resultantes de lesões apenas superficiais, e, portanto, não podem ser profundas nem viscerais.
- e) A equimose é chamada de petéquia, sugilação ou sufusão de acordo com a sua forma.

71. (FGV - Per (PC AM)/PC AM/42 Classe/Biologia/2022) Sabemos que a cronologia das lesões e o tempo de morte são estimados através de fenômenos cadavéricos e de decomposição de substâncias orgânicas.

O espectro equimótico de Legrand du Saulle corresponde

- a) ao depósito de sangue nos tecidos moles.
- b) à degradação da hemoglobina.
- c) ao início do estado de putrefação.
- d) ao estado de putrefação em fase avançada.
- e) à presença de mancha hipercrômica na esclera.

72. 4001012800 (FGV - Per (PC AM)/PC AM/42 Classe/Biologia/2022) Lesões produzidas por meio de lâminas têm bordas regulares e podem ter profundidade significativa dependendo da massa do objeto.

Assinale a afirmativa correta sobre feridas corto-contusas encontradas no pescoço por um perito na cena de crime.

- a) Chama-se degola quando o ferimento é anterior.
- b) Quando o ferimento é na região posterior do pescoço, chama-se esgorjamento.
- c) Degola corresponde a decapitação.
- d) Chama-se degola quando o ferimento é lateral.
- e) Esgorjamento pode ser referente a ferimentos em face lateral ou anterior do pescoço.



73. 4002371721 FUNDATEC - 2025 - Perito Médico-Legista (IGP RS) É correto afirmar que a Lei de Filhos e Langer pode:

- a) Determinar a distância do disparo de um projétil.
- b) Diferenciar uma ferida corto-contusa de uma contusa.
- c) Determinar a morfologia de um ferimento provocado por instrumento perfurante de médio calibre.
- d) Diferenciar uma lesão traumática in vitam ou post mortem.
- e) Determinar a dimensão da cavidade temporária e seu impacto nos órgãos internos, provocados por projéteis de alta

74. 4002371723 FUNDATEC - 2025 - Perito Médico-Legista (IGP RS) Considerando as características das lesões decorrentes de agentes mecânicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O extravasamento de sangue por diapedese pode ser um dos mecanismos pelos quais as sugilações são formadas.
- b) É possível diferenciar uma escoriação produzida em vida de uma post mortem, já que na post mortem observa-se coloração amarelado-acastanhada com aspecto semelhante a couro, apergaminhado.
- c) Dependendo do mecanismo de aplicação de força, as unhas podem produzir tanto estigmas ungueais quanto faixas de escoriação, sendo que estas últimas decorrem predominantemente de deslizamento.
- d) Livores podem ser diferenciados de equimoses já que aqueles se apresentam mais consistentes, com sangue coagulado e aderido aos tecidos; além disso, quando realizada incisão central, não ocorre extravasamento sanguíneo significativo, não sendo possível remover o sangue dos tecidos.
- e) Dependendo da profundidade onde se formaram, as equimoses podem surgir até mesmo dias após o impacto, o que pode ser um fator confundidor para determinação de sua cronologia pelo método de Legrand Du Saulle.

75. 4002378099 FUNDATEC - 2025 - Delegado de Polícia (PC RS) Um homem de 76 anos é encontrado morto em sua residência na zona rural. Ao exame necroscópico, o médico-legista identificou extensa e profunda lesão em região temporal direita, de bordos pouco regulares, sem caudas, com fundo anfractuoso, com presença de edema traumático e equimose junto às margens e com fratura óssea e exposição do conteúdo encefálico. Considerando os agentes



mecânicos envolvidos na traumatologia forense, o provável instrumento que provocou a lesão com consecutivo óbito foi um instrumento:

- a) Cortante.
- b) Perfurante.
- c) Corto-contundente.
- d) Perfurocontundente.
- e) Perfurocortante.

76. 4001383624 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Durante uma autópsia, na região do abdome da vítima, foram encontrados ferimentos punctórios. Qual instrumento pode ter causado esses ferimentos?

- a) Porrete
- b) Agulha
- c) Facão
- d) Projétil expelido por arma de fogo
- e) Navalha

77. 4001387908 IADES - 2023 - Perito Criminal (SPTC GO) Em processamento de local de crime contra a pessoa, durante o exame perinecroscópico, são encontradas lesões típicas para cada instrumento usado no crime, como ferimentos punctórios, contusos, incisos e mistos. Analogamente, cada instrumento recebe uma classificação de acordo com a típica lesão que é capaz de provocar. Os instrumentos "punhal", "barra metálica" e "projétil expelido por arma de fogo" são classificados, respectivamente, como agentes

- a) cortocontundente, contundente e cortante.
- b) perfurocortante, contundente e perfurocontundente.
- c) cortocontundente, perfurocontundente e contundente.
- d) contundente, cortante e perfurocontundente.
- e) perfurocortante, contundente e contundente.



78. 4001387912 IADES - 2023 - Perito Criminal (SPTC GO) Tecnicamente, lesões verificadas no pescoço são diferenciadas em função da região anatômica onde a lesão se produz e pela separação parcial ou total da cabeça. Acerca desse assunto, a secção quase total do pescoço feita pela parte posterior refere-se a

- a) decapitação.
- b) degola.
- c) esgorjamento.
- d) ferida punctória.
- e) ferida perfurocontusa.

79. 4001383616 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Suponha que o corpo de um indivíduo do sexo masculino não identificado tenha sido encaminhado ao Instituto Médico-legal local para perícia médica acerca da causa da morte. Ao exame físico externo, observaram-se, na região abdominal, duas feridas lineares, de 10 cm e 15 cm de comprimento e 2,5 cm de profundidade, que não se cruzavam, ambas de bordas regulares, cujo centro de cada ferida era mais profundo que as extremidades, e com cauda de escoriação voltada para o mesmo lado. Com relação às lesões, assinale a alternativa que indica o instrumento lesivo mais compatível.

- a) Faca, por ação perfurocortante
- b) Facão, por ação cortocontundente
- c) Faca, por ação perfurante
- d) Navalha, por ação cortante
- e) Arma de fogo, por ação perfurocontundente

80. 4001383625 IADES - 2023 - Auxiliar de Autópsia (SPTC GO) Assinale a alternativa que apresenta a definição técnica da lesão conhecida como esgorjamento.

- a) Separação completa da cabeça em relação ao tronco
- b) Secção quase total do pescoço feita pela parte posterior
- c) Secção da parte anterior do pescoço
- d) Divisão do corpo em partes, mediante amputação ou desarticulação
- e) Separação completa de um membro ou segmento do corpo



81. 4001261424 (IADES - 2022 - Professor (UnDF)/Medicina Legal/Deontologia) As formas das lesões causadas por instrumento perfurante de médio calibre assumem aspectos peculiares. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Numa região onde as linhas de força tenham um só sentido, o maior eixo terá sentido inverso ao das linhas de força.
- b) Em regiões de linhas de forças diferentes, a lesão tem o aspecto sempre regular.
- c) As lesões produzidas por instrumento de dois gumes têm a aparência de "casa de botão".
- d) O aspecto das lesões independe da condição post mortem
- e) Em pontos de confluência de linhas de força, as formas são irregulares.

82. 4002093046 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico/) Em um local de crime contra a pessoa, o Perito Criminal identificou no corpo da vítima uma lesão profunda, produzida por um instrumento cortante na região posterior do pescoço, sem que fosse constatada separação entre a cabeça e corpo, caracterizando uma lesão do tipo:

- a) esgorjamento.
- b) decapitação.
- c) evisceração.
- d) degolamento.
- e) esquartejamento.

83. 4002093047 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico) Ao examinar o corpo de uma vítima, o Perito Criminal constatou a presença de diversas lesões perfuroincisas e cortocontusas. Prioritariamente, quais instrumentos ele deveria procurar na cena de crime, respectivamente?

- a) Arma de fogo e barra de ferro.
- b) Faca e facão.
- c) Machado e peça de madeira.
- d) Estilete e navalha.
- e) Arma de fogo e punhal.



84. 4002092938 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Com relação à ação contundente, marque a alternativa INCORRETA:

- a) as lesões podem ser decorrentes de meios sólidos, líquidos e até gasosos.
- b) pode provocar rubefação, edema, equimose, escoriação e até ferida.
- c) frequentemente produz traumatismo cranioencefálico.
- d) embora relativamente comum, não é o tipo de ação mecânica mais frequente.
- e) o meio lesivo pode ser ativo, passivo e misto ou biativo.

85. 4002092939 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Analise as proposições:

I — Feridas cortantes ou incisivas geralmente apresentam regularidade das bordas, forma linear, ausência de vestígios traumáticos ao redor da ferida, hemorragia é mais frequente e a profundidade predomina sobre o comprimento;

II — Feridas cortocontusas são, em geral, mais graves, profundas, não têm cauda de escoriação e atingem planos interiores, podendo determinar lesões ósseas;

III- Feridas puntiformes aparecem como um ponto, abertura estreita, raro sangramento, pouca nocividade na superfície;

IV - Feridas perfurocortantes apresentam geralmente orla desepitelizada de França no ângulo mais agudo.

Assinale a alternativa correspondente.

- a) Todas as proposições são falsas.
- b) Há apenas uma proposição verdadeira.
- c) Há apenas duas proposições verdadeiras.
- d) Há apenas três proposições verdadeiras.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

86. 4002092862 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Médico-Legal/) Sobre desmembramentos, marque a alternativa correta.

- a) Nunca envolvem o tronco.
- b) Frequentemente é realizado após a morte.
- c) Envolvem somente desarticulação de membros.



- d) Nunca envolvem decapitação.
- e) Envolvem apenas a secção dos membros.

87. 4002092940 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Odonto-Legal) Analise as proposições:

- I - No exame de uma ferida, caso o Perito observe um ângulo agudo e outro reto ou arredondado é possível afirmar que a lesão fora causada por objeto perfurante de médio calibre;
- II - O comprimento da lâmina da faca ou objeto usado para produzir uma ferida perfurocortante pode ser sempre determinado a partir do comprimento do trajeto da lesão no interior do corpo;
- III — Feridas perfurocortantes geralmente deixam pontes de tecido íntegro;
- IV - Decapitação caracteriza-se por uma separação total entre a cabeça e o corpo em decorrência de uma ação cortante em região cervical.

Assinale a alternativa correspondente.

- a) Todas as proposições são falsas.
- b) Há apenas uma proposição verdadeira.
- c) Há apenas duas proposições verdadeiras.
- d) Há apenas três proposições verdadeiras.
- e) Todas as proposições são verdadeiras.

88. 4002093078 (IBADE - 2025 - Perito (DPT BA)/Criminalístico) JDP, sexo masculino, 15 anos, conduziu automóvel na contramão, atropelou a pessoa em situação de rua JMB, 68 anos, e bateu num poste. Levados a um pronto-socorro foram avaliados:

JMB, sem sinais vitais, apresentava equimose em região frontal, fratura de crânio e hemorragia encefálica, sem outras lesões.

JDP, sem lesões externas, apresentava discurso acelerado e desconexo, dilatação pupilar, alucinações visuais, auditivas e portava droga ilícita.

O que mais provavelmente determinou a morte de JMB foi um meio ou instrumento:

- a) perfurocontundente.
- b) cortante.
- c) perfurante.
- d) contundente.



e) lacerante.



QUESTÕES EXTRAS - GABARITO

1. CERTA	23.ERRADA	45.D	67.D
2. ERRADA	24.ERRADA	46.E	68.A
3. ERRADA	25.ERRADA	47.E	69.A
4. B	26.ERRADA	48.A	70.D
5. CERTA	27.ERRADA	49.D	71.B
6. ERRADA	28.B	50.D	72.E
7. CERTA	29.C	51.C	73.C
8. CERTA	30.B	52.C	74.D
9. CERTA	31.D	53.C	75.C
10.ERRADA	32.D	54.A	76.B
11.CERTA	33.E	55.C	77.B
12.ERRADA	34.B	56.B	78.B
13.ERRADA	35.D	57.E	79.D
14.ERRADA	36.B	58.D	80.C
15.ERRADA	37.B	59.A	81.C
16.CERTA	38.E	60.C	82.D
17.ERRADA	39.C	61.D	83.B
18.CERTA	40.D	62.D	84.D
19.CERTA	41.E	63.B	85.C
20.CERTA	42.D	64.E	86.B
21.CERTA	43.C	65.A	87.B
22.CERTA	44.E	66.C	88.D



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.